

Онкология и радиология Казахстана

№2 (19) 2011

Қазақстан онкология және радиология журналы

Главный редактор
К.Ш. Нургазиев,
д.м.н.

Редакционная коллегия

Абисатов Х.А., Адильбаев Г.Б., Есентаева С., (зам.главного редактора), Жолдыбай Ж.Ж., Ижанов Е.Б., Имангалиева Н.Т. (патентовед), Кайрбаев М.Р. (административный редактор), Ким В.Б., Нургалиев Н.С., Сейтказина Г.Д., Талаева Ш.Ж., Чичуа Н.А.

Редакционный совет

Давыдов М.И. (Россия)	Ш. Фуджи (Япония)
Мусулманбеков К.Ж. Казахстан	В. Кешич (Сербия)
Шарман А.Т. (Казахстан)	М.А. Мур (США)
Алчинбаев М.К. (Казахстан)	Р. Якез (Австрия)
М. Россели (Италия)	К. Нарайян (Австралия)

Ответственный секретарь

Кабдрахманов К.Б.

Редакторы переводов

Галушкин М.А., Утельбаева А.Е., Шалбаева Р.Ш.

Адрес редакции

г. Алматы, 480091, пр. Абая, 91

НИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Тел. (327) 292 10 63

«Онкология и радиология Казахстана», №2 (19), 2011 г.

Собственник - РГКП «НИИ онкологии и радиологии МЗ РК»

Свидетельство о регистрации - №10248-ж от 14.07.2009 г.

Тип. «Идан», ул. Коммунальная, 39

Тираж 200 экз.

Журнал выпускается 1 раз в 3 мес.

Содержание

Организация онкологической службы

Комбинированное и комплексное лечение рака шейки матки в Восточно-Казахстанском областном онкологическом диспансере за 1995-1999 гг. *Жумагалиева Г.Ж.* (3)

К 70-летию национального центра онкологии Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики. *Бахшалиева Н.А.* (4)

Онкологическая эпидемиология

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Акмолинской области и загрязнение объектов окружающей среды в ряде ее регионов. *Каримов М.А., Сейтказина Г.Д., Доскеева Р.А., Имангалиева Н.Т., Койшекенова Г.А.* (8)

Вопросы диагностики

Современные методы диагностики и лечения неходжкинских лимфом. *Каракулов Р.К.* (12)

Биологические особенности отечно-инфильтративных форм рака молочной железы. *Чичуа Н.А., Есентаева С.Е., Хамидуллина Г.А., Смагулова К.К., Абдрахманов Р.З., Мусаханова Ж.С.* (19)

Рак легкого в географическом регионе «Нахичевань» Азербайджана. *Солтанов А.А.* (23)

Оптимизация скрининга заболеваний молочной железы. *Ватанха В.С.* (26)

Онкохирургия

Анализ результатов хирургического лечения колоректального рака в онкохирургическом отделении. *Досан Б.О.* (34)

Результаты реконструктивно-пластических операций при раке молочной железы в КазНИИОиР. *Талаева Ш.Ж., Ли И.Н., Кайбуллаев Б.А.* (36)

Роль лимфодиссекции и механических сшивающих аппаратов в хирургическом лечении рака прямой кишки. *Абдужаппаров С.Б., Наврузов Б.С., Акбаров Э.Т., Исламов Х.Д.* (38)

Анестезиология, реаниматология

Некоторые аспекты применения ингаляционной анестезии в онкохирургии. *Мухамадиев Б.Т., Раев Г.Б., Сазанов Е.О., Муканова М.Б., Нурманова А.А.* (40)

Сравнительная оценка общей анестезии у онкологических больных высокого сердечно-сосудистого риска. *Мухамадиев Б.Т., Раев Г.Б., Сазанов Е.О., Муканова М.Б., Нурманова А.А.* (42)

Влияние некоторых анестезиологических препаратов на CD95-зависимый апоптоз и пролиферативную активность лимфоцитов у больных с разлитым гнойным перитонитом. *Гасанова Л.В., Исаев Г.Б.* (44)

Опыт применения препарата Септонест в местной анестезии при малых гинекологических операциях. *Ли В.В., Абдулаханова Р.Р.* (46)

Химиотерапия, лучевая терапия

Комбинация таксотера и герцептина в лечении больных местно-распространенных форм рака молочной железы

с гиперэкспрессией HER2/NEU. *Ли И.Н., Талаева Ш.Ж., Кайбуллаев Б.А.* (49)

Лучевая терапия в алгоритмах комбинированных методов лечения больных раком прямой кишки. *Кулиева Н.Г.* (52)

Оценка эффективности применения НАПХТ при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря. *Нургалеев Н.С., Косанов М.С., Онгарбаев Б.Т., Ишкинин Е.И.* (56)

Применение схемы R CHOP-14 при лечении В-клеточных индолентных неходжкинских лимфом. *Каракулов Р.К., Габбасова С.Т., Сагиндыков Г.А., Асанов А.А., Насипов Б.А., Джазылтаева А.С.* (59)

Ультразвук – от диагностики к лечению (HIFU терапия). *Култаев А. С.* (61)

Клиническая фармакология

Применение Тонбиола в лечение больных раком легкого, желудка, молочной железы, толстой и прямой кишки III-IV ст. *Досан Б.О.* (63)

Публикации практических врачей

Роль бронхоскопии в диагностике неопластических процессов дыхательных путей. *Мизиев И.А., Созаева С.Р., Базиев З.М.* (64)

Профилактика постлучевых осложнений у пациенток с раком шейки матки. *Батырова Л.М.* (65)

Консервативное лечение больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста. *Ниязбекова К.И.* (66)

Ранняя диагностика рака яичников. *Батырова Л.М.* (68)

Роль ранней диагностики рака молочной железы. *Батырова Л.М.* (69)

Опыт хирургического лечения обтурационной толстокишечной непроходимости опухолевого происхождения. *Тимашова Е.В.* (70)

Диагностика и хирургическое лечение обтурационной толстокишечной непроходимости. *Курбонов К.М., Шамсиев Г.Х., Шарипов Х.Ю., Назаров Х.Ш.* (71)

Преимущества грудного вскармливания для здоровья детей и матерей. *Мамбетова С.Т.* (73)

Климактерический синдром и ЗГТ. *Тян И.И.* (75)

Сочетание хронического вирусного гепатита В и злокачественной опухоли фатерова сосочка смешанной этиологии. Случай из практики. *Сулейменова З.И., Лавлинская Е.А., Жакешов Т.И., Сагитов Ш.Ж., Анетбекова А.А.* (76)

Острая обтурационная толстокишечная непроходимость как грозное осложнение опухоли толстой кишки в экстренной абдоминальной хирургии у больных пожилого и старческого возраста. *Сактаганов К. Е., Мукашев У.И.* (77)

Биполярная трансуретральная резекция доброкачественной гиперплазии предстательной железы. *Турысбеков К.Т.* (78)

Цитомегаловирусная инфекция. *Мамбетова С.Т.* (79)

Комбинированное и комплексное лечение рака шейки матки в Восточно-Казахстанском областном онкологическом диспансере за 1995-1999 гг.

Жумагалиева Г.Ж.

Восточно-Казахстанский областной онкологический диспансер, г. Усть-Каменогорск

По показателям онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы) рак шейки матки (РШМ) в структуре злокачественных опухолей органов гениталий занимает 1-ое место. Число заболевших РШМ варьирует от 0,43 до 0,48 случаев на 100 тысяч женщин. В общей структуре РШМ занимает 5-ое место после опухоли желудка, кожи, молочной железы и составляет 6-7%. Показатель смертности по Казахстану составляет 4,1 случай на 100 тыс женского населения, по России - 23,0, по Украине- 24,6.

В то же время статистические данные свидетельствуют об интенсивном снижении показателей заболеваемости раком шейки матки (1). Это обусловлено проведением профилактических осмотров с обязательным применением цитологического исследования, выявлением предопухолевых заболеваний и их оздоровлением.

Причинами развития РШМ является нарушение гормонального гомеостаза и присутствие вирусной инфекции.

Были проработаны материалы областного онкологического диспансера (ООД) по лечению интерэпителиального РШМ различными методами за пятилетний период (1995-1999гг.). Возраст больных варьирует от 30 до 58 лет. Объем оперативного вмешательства от диатермокоагуляции шейки матки до расширенной экстирпации шейки матки по Вертгейму. В основном оперативное лечение проводят при раке шейки матки по индивидуальному плану с учетом данных всестороннего исследования.

В настоящее время в литературе и клинической практике (1) разработано несколько методов комплексного, комбинированного и сочетанно-лучевого лечения, в их числе большинство случаев предоперационная и послеоперативная сочетанно-лучевая терапия или операция + лучевая терапия, либо только наружная (полостная / терапия), реже химиотерапия и операция. Очевидность

Жатыр мойнындағы қатерлі ісікті (жмқ 5 жыл ішінде сәулем, қиыстыру және симптомдық, терапия әдісімен емдеудің салыстырмалы мәліметтер беріп, сондайақ 80% ауруларға жасалған сәулелі терапияның себептері ашып көрсетілген.

The article provides a comparison of treatment of cervical cancer over a 5-year period the methods of radiation, combined and symptomatic therapy, but also revealed the reasons for the use radiotherapy in 80% of patients.

применения отдельных компонентов этих методов лечения зависит от ряда факторов.

Для каждой отдельной больной в зависимости от показаний, может быть применено два или три лечебных воздействия, проводимых в различной последовательности и в различных сочетаниях.

В таблице 1 приведены сравнительные данные результатов лечения РШМ за 1995-1999 г.г. различными методами.

В таблице 2 отражены показатели наблюдаемой выживаемости больных РШМ от вида операции по ООД.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при расширенной экстирпации шейки матки с придатками по Вертгейму с последующей лучевой терапией наблюдается тенденция к повышению % выживаемости в отличие от тех больных, которым была произведена простая экстирпация матки с придатками + лучевая послеоперационная терапия.

Выводы

Таблица 1- Результаты лечения рака шейки матки

Показатели	1995	1996	1997	1998	1999
Всего больных с впервые в жизни установленным диагнозом	61	43	73	79	68
Из них только лучевая терапия	27 (44,3%)	20 (46,5%)	40 (54,8%)	51 (64,%)	36 (52,9%)
Комбинированная терапия (хирургия+ЛТ+ХТ). Только симптоматическая терапия	32 (52,4%)	19 (44,2%)	25 (34,3%)	22 (27,9%)	29 (42,7%)
Умерло (из количества больных с впервые в жизни установленным диагнозом)	3 (4,94%)	7 (16,3%)	6 (8,2%)	9 (11,4%)	12 (17,6%)
Общее количество пациентов, состоящих на «Д» учете на конец года	965	931	93	953	950
Из них общее количество умерших	44	25	31	48	51

Таблица 2 – Выживаемость больных РШМ в зависимости от вида операции

Вид операции	Число наблюдений	Выживаемость, %		
		1 год	3 года	5 лет
Расширенная экстирпации матки с придатками+ лучевая терапия	22	100		
Экстирпация матки с придатками + лучевая терапия	5	94,5	85,4	80,2

1. Эффективность лечения рака шейки матки более эффективна при условии ранней диагностики и индивидуального подхода, с учетом показаний и противопоказаний больных к различным лечебным методам.
2. Наиболее высокие результаты выживаемости зависят от стадии заболевания, вида лучевой

К 70-летию национального центра онкологии Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики

Бахшалиева Н.А.

Национальный центр онкологии Минздрава Азербайджанской Республики

Исторически сложилось так, что становление онкологии как отрасли клинической медицины, практически, во всех странах мира и, в том числе, в России происходило в период расцвета многих других разделов медицины и, в первую очередь, рентгеновской диагностики и, частично, рентгенотерапии. Аналогичная тенденция наблюдалась и в Азербайджане. Поэтому не будет ошибкой считать реальной основой процесса становления онкологии как отрасли здравоохранения и организации первых онкологических учреждений появление в ряде медицинских учреждений г. Баку специализированных рентгеновских кабинетов: при Кожно-венерологическом Институте был организован первый в стране рентгентерапевтический кабинет, предназначенный для лечения распространенных в те годы грибковых заболеваний кожи (парша, трифолития) (1924 г. - это ознаменовало начало применения в Азербайджане рентгенотерапии); в Железнодорожной больнице был установлен универсальный рентгентерапевтический аппарат, позволивший применить рентгенотерапию для лечения онкологических больных (1926 г.).

В конце 1928 г. при Азербайджанском медицинском обществе организуется секция рентгенологов. В 1935 г. секция реорганизуется в общество рентгенологов и радиологов Азербайджана.

В 1929 г. в Центральной поликлинике г. Баку начинается поликлинический прием онкологических больных. В связи с наплывом больных и ростом популярности этой специализированной помощи здесь организуется первый онкологический кабинет, который в 1930 году реорганизуется в онкологическое отделение с хирургическим, гинекологическим и лабораторно-диагностическим кабинетами, а также с кабинетом глубокой рентгенотерапии для лечения онкологических больных.

В 1930 г. в Азербайджанском медицинском институте, на базе кафедры пропедевтики внутренних болезней организуется «учебный курс по рентгенологии и радиологии».

В этот же период на базе стационара Клинической больницы им. Н.А.Семашко, в одном из ее хирургических корпусов, создается онкологический сектор, на базе которого к 1932 г. открывается онкологическое отделение на 40 коек. Во главе отделения встает профессор И.С.Гинзбург. Создание этого отделения положило начало развитию клинических и экспериментальных исследований в области онкологии и лучевой терапии. Кроме того, уже первые месяцы работы отделения выявили потребность централизации рентгено-радиологической и онкологической служб.

Бакинское общество хирургов на своих заседаниях трижды заслушало доклады по организационным вопросам противораковой борьбы. Следствием этого явилось избрание в 1932 г. на одном из своих заседаний Комитета по организации Ракового Института.

В этом же году усилиями Наркомздрава и Комитета по организации Ракового Института стали создаваться условия для проведения научных исследований в области рентгенологии, радиологии и онкологии, что привело

Азербайджан Республикасы. Денсаулық сақтау министрлігі Ұлттық онкология орталығына 70 жыл.

XX жүзжылдықтың 40 жылдарында жағдай белгілі еді, соның бір себебі, онкологияның кешеуілдеген дамуы оған қоса Әзербайжан медицинасының саласы, мұнда жергілікті жағдайларға байланысты рентгенорадиология және қатерлі ісіктердің проблемаларымен айналысатын біріңғай мамандандырылған ғылыми-әдістемелік орталық болмады. Сол себептен 1941 жылдың қаңтар айында Әзербайжанның Мемлекеттік рентгено-радиология ғылыми-зерттеу институты (қазіргі Ұлттық онкология орталығы) құрылды. Бұл орталық Әзербайжанда радиология саласының дамуына үлкен септігін тигізді және онкологияның ғылым ретінде қалыптасуына шешуші роль атқарды, содай-ақ ол Әзербайжанда нақты түрде орнықты.

Бүгінде Ұлттық онкология орталығы Әзербайжан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіндегі – ірі жетекші мамандандырылған ғылыми-зерттеу және клиникалық мекеме, клиникалық базасы 650 төсек. Мұнда көптеген этиопато- генезге қатысты сұрақтар зерттеледі, емдеу және қатерлі өспелерге қатысты проблемаларға профилактикалар жүргізу. Ұлттық онкология орталығы барлық ғылыми-әдістемелік және профилактикалық жұмыстарды орталықтандырады. Әзербайжан Республикасының тұрғындарына мамандандырылған онкологиялық көмек көрсетеді.

To The 70th Anniversary Of The National Centre Of Oncology Of The Ministry Of Health Of The Azerbaijan Republic

Bakhshaliyeva N.

In 40 years of XX century, has become increasingly clear that one of the causes that obstacle the development of oncology and related fields of medicine in Azerbaijan, is the lack of a unified particularized scientific-systematic center engaged problems of radiology and malignant tumors applied to local conditions. Therefore creation in January 1941, the Azerbaijan State Radiology Research Institute (now is the National Center of Oncology) was particularly important in the development of radiological service in Azerbaijan and played key role in the development of oncology as a science and, in fact, marked its appearance in Azerbaijan.

Today, the National Centre of Oncology of the Ministry of Health of the Azerbaijan Republic is a large and leading institute in the Republic, particularized research and clinical center with a clinical base for 650 beds. Here is investigating a number of problems of etiology and pathogenesis, diagnosis, treatment and prophylaxis of malignant tumors

к началу научной работы в этих областях, и уже в 1936 г. был издан первый выпуск «Сборника научных работ по онкологии», включавший 14 работ.

Проведенная в 1937 г. в г. Баку Противораковая декада мобилизовала медицинскую общественность на дальнейшее усиление организованной помощи больным раком: организуются онкологические кабинеты в Гяндже, Степанакерте, Нахичевани и Нухе. В том же году в системе Наркомздрава создается научно-исследовательская база клинической и экспериментальной онкологии - лаборатория по онкологии. Вскоре указанное онкологическое отделение Центральной поликлиники г. Баку превращается в самостоятельный городской Онкологический диспансер, где уже наряду с хирургическим методом начинает широко использоваться рентгенотерапия. В 1939 г. сюда впервые доставляется радий и радий-мезоторий, что дает возможность проводить контактную радиотерапию аппликационным, внутритканевым и внутрисполостным методами. Наряду с этим, начинается разработка сочетанной рентгенорадиотерапии и комбинированного хирургического и лучевого лечения больных.

Это позволяет считать, что к данному моменту становление онкологии как отрасли клинической медицины в Азербайджане уже завершилось, поскольку методический уровень специализированной помощи, в целом, соответствовал таковому в других городах бывшего СССР и был сопоставим с методическими возможностями в других странах.

В 1938 г. в г. Баку проводится 1-я конференция рентгенологов Азербайджана, на которой было заслушано 20 докладов [8].

С развитием рентгеновской сети и ростом кадров рентгенологов и радиологов возросла потребность в обмене научным опытом и результатами научно-исследовательских работ, что и послужило поводом для проведения 2-ой конференции рентгенологов Азербайджана (1940 г.).

Вместе с тем, становится все очевидней, что одной из веских причин, тормозивших развитие онкологии и смежных с ней отраслей медицины в Азербайджане, является отсутствие здесь единого специализированного научно-методического центра, занимающегося проблемами рентгенорадиологии и злокачественных опухолей применительно к местным условиям [4].

Поэтому Постановлением Совнаркома Азербайджанской ССР и Народного Комиссариата Здравоохранения за №2928 от 10 декабря 1940 г. в январе 1941 г. был организован Азербайджанский Государственный научно-исследовательский Институт рентгено-радиологии (НИИ Р-Р), первоначально разместившийся в здании 18-го корпуса Клинической больницы имени Н.А.Семашко (директор - профессор Исаак Соломонович Гинзбург - организатор онкологической службы в Азербайджане).

На НИИР-Р была возложена функция организационного, научно-исследовательского, лечебного координационного центра по рентгенологии и радиологии в масштабе всей Республики.

Создание НИИР-Р имело особо важное значение в развитии радиологической службы в Азербайджане и сыграло решающую роль в становлении онкологии как науки и, фактически, ознаменовало ее реальное появление в Азербайджане. Действительно, как показывают результаты анализа источников, именно НИИР-Р стало тем учреждением, где было выполнено абсолютное большинство научных исследований в области рентгенологии, радиологии и онкологии.

В Азербайджане началось интенсивное развитие онкологии и медицинской радиологии. Было создано более десятка городских и межрайонных онкологических диспансеров в Гяндже, Сумгаите, Степанакерте, Мингечауре, Кубе, Шеки,

and other related problems. NCO coordinates all scientific-methodological and prophylaxis work in providing of specialized cancer care to the population of Azerbaijan.

Агдаме, Али-Байрамлах, Ленкорани. Все они были оснащены рентгенодиагностическим и рентгено-терапевтическим оборудованием [2,3].

В 1949 г. при НИИР-Р вводится аспирантура, благодаря которой количество кадров врачей-онкологов и рентгено-радиологов стало заметно увеличиваться из года в год.

К этому времени в клинике НИИР-Р выполнялись все типовые онкологические операции на желудке, кишечнике и других органах. Осваивались усовершенствованные виды общего наркоза - внутритрахеальный и эфирокислородный. При радикальных операциях по поводу рака кожи применялась первичная пластика. В диагностике стали широко применяться методы эндоскопии (эзофагоскопия, гастроскопия и др.).

Проводилось и лучевое лечение рака, эффективность которого ощутимо возросла благодаря применению новых рентгенотерапевтических установок серии «РУМ». Благодаря применению радиоактивных изотопов начала широко применяться методика лечения больных гинекологическими новообразованиями с благоприятными ближайшими и отдаленными результатами, а также сосудистыми опухолями наружных покровов и новообразованиями нижней губы.

В 1955 г. Приказом Министерства Здравоохранения Азербайджана (за №113-к от 13 марта) директором НИИР-Р был назначен доцент Мустафа Мамедович Аликишибеков, известный в Азербайджане хирург. По инициативе нового директора, наряду с реорганизацией некоторых подразделений, создаются и новые структуры.

В том же году была организована и успешно проведена Республиканская рентгено-радиологическая конференция с участием крупнейших рентгенологов бывшего Советского Союза. В 1956 г. проводится 4-я Республиканская конференция рентгенологов и радиологов, а в 1958 г. - 3-я Закавказская конференция онкологов.

Совершенствуется лечебно-диагностическая работа и расширяются клинические возможности института. В 1956 г. он оснащается новым гамматерапевтическим аппаратом «ГУТ-Кобальт-400», обладающим существенными преимуществами перед используемыми до этого рентгенотерапевтическими и цезиевыми аппаратами. В стенах клиники находят применение первые советские противоопухолевые лекарственные препараты и др.

Вскоре НИИР-Р становится крупным научно-исследовательским учреждением, обеспечивающим Республику научными и практическими кадрами по соответствующим отраслям медицины, и ему летом 1957 г. присваивается 2-я всесоюзная категория.

Несмотря на официальный профиль НИИР-Р, его клинический контингент составляли, в основном, больные раком, а в научной деятельности преобладала онкологическая тематика. С учетом этого обстоятельства Минздрав издал приказ за №171 от 11 июля 1963 г. об изменении названия НИИ Р-Р в НИИ рентгенологии, радиологии и онкологии (НИИРРиО).

Уже в 1964 г. было завершено строительство двух первых новых корпусов, включая типовое здание для онкогинекологических больных, расположенных на северной окраине города, в которых были размещены все подразделения института. Перемещение позитивно сказалось не только на клинической деятельности, но и на интенсивности научных работ, для которых появились новые благоприятные условия. В том же году НИИРРиО получил более современный и мощный гамматерапевтический аппарат «ЛУЧ-1». Подобный аппарат был установлен и в

Гянджинском онкодиспансере.

К этому времени в НИИРРиО сложился коллектив врачей и исследователей, обладавших большим научно-клиническим потенциалом, благодаря которому уровень лечебно-диагностической работы и научной деятельности института вполне соответствовал среднесоюзному стандарту онкологических учреждений в столицах других союзных республик бывшего СССР [1]. В 1965 г. в институте было 5 докторов и 28 кандидатов наук.

Во второй половине 60-х гг. начали проводиться первые совместные исследования с учеными из Москвы, Ленинграда, Киева и др. городов. Стала более интенсивной подготовка научных кадров и, в первую очередь, докторов наук. Расширился и арсенал используемых в клинике методов диагностики и терапии злокачественных опухолей. Были внедрены в работу новые методы лабораторных исследований, отвечающие своему времени.

В 1969 г. был создан специальный топометрический дозиметрический кабинет с соответствующим оборудованием и аппаратурой. Это обеспечило ощутимое улучшение предлучевой подготовки больных и повысило качество и эффективность лучевой терапии.

В 1974 г. директором НИИРРиО был назначен профессор Рагим Нурмамедович Рагимов [7].

В начале 70-х годов, в соответствии с политикой Правительства Азербайджана, началась интенсивная подготовка специалистов в области онкологии на базе ведущих онкологических учреждений бывшего СССР (Москва, Ленинград и др.). Именно в этот период были подготовлены кандидаты и доктора наук по основным онкологическим и радиологическим специальностям. С этого времени НИИРРиО становится «кузницей» научных кадров для других медицинских учреждений: сотрудников института приглашают в медицинский институт. Вместе с тем, часть подготовленных в Москве специалистов вернулась в г. Баку и продолжила деятельность на родине.

За несколько лет более чем в два раза увеличилось количество коек (к 1980 г. оно достигло 300), в 1976 г. был построен и сдан в эксплуатацию новый 5-ти этажный клинично-лабораторный корпус и созданы новые клинические (химиотерапии, эндоскопии, анестезиологии) подразделения и бактериологическая лаборатория. В 1980 гг. в НИИРРиО функционировали 2 гамма-терапевтических аппарата для дистанционной лучевой терапии (РОКУС и Агат-Р). В НИИРРиО начали выполняться фундаментальные исследования совместно с научно-исследовательскими институтами Академии наук Азербайджана.

По личной инициативе занимавшего в тот период должность первого заместителя Председателя Совета Министров СССР Г.А.Алиева и под его личным контролем в 1986 г. началось строительство новых современных корпусов для РОНЦ. В 1987 г. был выстроен и сдан в эксплуатацию новый 4-х этажный корпус, предназначенный для vivария. В эти же годы был организован ряд новых подразделений РОНЦ (кабинет ультразвуковой диагностики, лаборатория экспериментальной терапии).

С целью подготовки специалистов по различным отраслям онкологии в период с 1985 г. по 1990 г. из числа наиболее перспективных выпускников медицинского института была отобрана и направлена на учебу во Всесоюзный онкологический научный центр АМН СССР в г. Москву группа молодых специалистов. Впоследствии именно они, вернувшись на Родину, составили костяк молодой части коллектива РОНЦ, которые с энтузиазмом приступили к клинической работе и продолжили научные разработки в Азербайджане.

В 1988 г. по личной инициативе Д.А.Алиева на базе РОНЦ был создан Республиканский маммологический центр, основными задачами которого явились ранняя диа-

гностика рака молочной железы и снижение количества больных с данной заболеваемостью в Азербайджане.

Улучшение материально-технической базы и пополнение кадрового потенциала, закономерно, привело к возрастанию значения НИИРРиО в системе здравоохранения и медицинской науки, что выразилось в изменении статуса института и преобразовании его Решением Коллегии Минздрава СССР от 06.01.1988 г. и Приказом Минздрава Азербайджана №18 от 25.01.1988 г. в Республиканский онкологический научный центр (РОНЦ) Министерства здравоохранения Азербайджанской ССР.

После соответствующей реорганизации подразделений РОНЦ, завершившейся, в основном, к концу 1988 г., его административно-штатная структура приблизилась к современной.

В марте 1990 года директором Центра был назначен академик АМН РФ Д.А.Алиев, возглавляющий Центр по настоящее время [5].

Имея большой научный потенциал и современное материально-техническое оснащение, НЦО обеспечивает проведение многопрофильных научных исследований не только в области онкологии, но и по ряду смежных, связанных с ней, проблем.

Начинают разрабатываться и реализовываться в масштабах Республики скрининговые программы по ранней диагностике рака молочной железы и легкого, что приводит к существенному снижению запущенных форм данных заболеваний в Республике. Также были разработаны комплексные методы лечения и реабилитации больных раком молочной железы, включающие органосохранные операции. Начаты перспективные исследования по созданию новых противоопухолевых препаратов.

Усилия руководства были сконцентрированы на повышении результативности научных исследований и максимальном использовании материально-технического и кадрового потенциала Центра. Это нашло выражение в том, что в феврале 1991 г. распоряжением Минздрава СССР и Приказом Минздрава Азербайджанской ССР за №47 от 26.02.91г. РОНЦ был переведен в 1-ю всесоюзную категорию научно-исследовательских учреждений.

В начале 90-х годов, несмотря на трудное политико-экономическое положение Азербайджана, связанное с распадом СССР, коллектив РОНЦ встретил с воодушевлением обретение Азербайджаном независимости. Заслугой руководства Центра стало то, что ему, несмотря на тяжелые экономические условия, удалось не только сохранить ценные научные кадры, но и продолжать их подготовку [6]. Клиническая работа и научные исследования также продолжались достаточно интенсивно. Кроме того, всего за 4 года РОНЦ наладил связи с онкологами Англии, Турции и других стран. При этом, практически, не прерывались и, даже, продолжали расширяться научные контакты с коллегами из России и вновь образовавшихся стран СНГ. За короткое время сотрудники НЦО побывали в научных командировках в целом ряде стран (Австрия, Англия, Германия, Италия, Турция, Франция, Швейцария и США). Был проведен целый ряд конференций, посвященных актуальным проблемам онкологии. Именно на этот период пришелся выход в свет целого ряда книг и монографий.

Наконец, 10 октября 1995 г. Приказом Минздрава Азербайджанской Республики №197 РОНЦ был переименован и обрел статус Национального центра онкологии (НЦО). К этому времени здесь работали 1 академик, 4 профессоров, 5 докторов наук и более 30 кандидатов медицинских и биологических наук.

За последние 10 лет структура НЦО, в соответствии с требованием времени, претерпела изменения, связанные с укрупнением и развитием наиболее приоритетных направлений в работе.

На территории Центра возвышается современное здание, предназначенное для хирургических подразделений. Это здание оснащено самым современным медицинским оборудованием.

Завершилось сооружение нового радиологического корпуса.

В настоящее время на стадии завершения работы по строительству корпуса для отделения детской онкологии.

Сегодня Национальный центр онкологии Минздрава Азербайджанской Республики - крупнейшее и ведущее в Республике специализированное научно-исследовательское и клиническое учреждение с клинической базой на 650 коек. Здесь изучается целый ряд вопросов, касающихся этиопатогенеза, диагностики, лечения и профилактики злокачественных новообразований и ряда связанных с ними проблем.

НЦО координирует всю научно-методическую и профилактическую работу по оказанию специализированной онкологической помощи населению Азербайджана. Сюда стекается вся информация о заболеваемости и состоянии диагностики и лечения онкологических больных, проводимых в онкологической больнице Баку, 7 Межрайонных онкологических диспансерах (в гг.Нахичевань, Сумгаит, Шеки, Куба, Мингечаур, Али-Байрамлы, Ленкорань) и около сотни онкологических кабинетов. Силами сотрудников НЦО проводятся выездные сессии, посвященные вопросам совершенствования онкологической помощи населению.

В НЦО сосредоточено большинство ведущих специалистов Республики в области клинической и экспериментальной онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.

За 70 лет работы в НЦО проводились научные исследования более чем по 400 темам. Сотрудниками Центра получены более 20 авторских свидетельств на изобретения, опубликовано более монографий и несколько тысяч научных работ, изданных в Азербайджане, России, республиках бывшего СССР, странах Европы, Азии и Северной Америки.

За это время в НЦО издано 20 томов научных трудов под названием «Актуальные вопросы рентгенологии, радиологии и онкологии» (до 1991) и «Проблемы онкологии и медицинской радиологии» (до 1994 г.), более десятка монотематических сборников научных статей и материалов научных конференций. С 1995 г. в Центре учрежден и ежегодно издается первый в Азербайджане специализированный медицинский журнал «Азербайджанский журнал онкологии и гематологии», распространяемый в России и ряде стран СНГ.

В клинической ординатуре при НЦО постоянно ведется подготовка квалифицированных кадров для практического здравоохранения. Здесь же проходят интернатуру врачи, избравшие своей специальностью онкологию и медицинскую радиологию.

На базе НЦО функционирует аспирантура. Здесь выполнено более сотни кандидатских и немало докторских диссертаций. Среди бывших аспирантов и соискателей Центра сегодня немало известных в Азербайджане и за его пределами ученых.

С 1993 г. на базе Центра начал функционировать Диссертационный совет по защите диссертаций,

представляемых для присуждения ученой степени по двум специальностям: 14.00.14 - «онкология» и 14.00.19 - «лучевая диагностика, лучевая терапия». За 18 лет здесь был защищен целый ряд кандидатских и докторских диссертаций.

НЦО поддерживает тесные связи с Онкологическим научным центром им. Н.Н.Блохина Российской АМН, где проходят подготовку многие азербайджанские специалисты. Традиционные научные связи НЦО поддерживает с онкологами стран Закавказья, Украины, Узбекистана. Специалисты НЦО выполняют кооперированные исследования совместно со своими коллегами из Турции, Англии, Германии, Швейцарии, США и ряда других стран. Тесные связи налажены со Всемирной организацией здравоохранения и другими международными организациями, занимающимися проблемами рака.

Таким образом, становление и развитие онкологии в Азербайджане выражало общую тенденцию развития здравоохранения и медицины в мире, но в силу социально-исторических причин происходило на основе общего развития советской системы социального здравоохранения, как результат нахождения Азербайджана в составе бывшего Советского Союза, характеризующаяся всеми присущими этой системе преимуществами (бесплатность и всеобщая доступность специализированной помощи населению) и недостатками (усредненность «уровня» помощи в силу государственного финансирования здравоохранения и, в силу этого, строгая централизация и дискриминированность в ассигновании периферических областей государства).

Развитие онкологии в Азербайджане, осуществляемое, в основном, силами местных научно-клинических кадров, даже в отмеченных выше условиях обеспечивало население страны квалифицированной помощью и создало условия для дальнейшего самостоятельного развития этой отрасли медицины в будущем за счет создания собственной группы научных работников и квалифицированных специалистов в области клинической онкологии.

Литература

1. Агеев А.И. Лицо рака. М.: Медицина, 1994
2. Алиев Д.А., Мамедов М.К., Гудратов Н.О. Онкологические аспекты вирусного гепатита В. Баку: Билик, 1993
3. Алиев Д.А., Наджафов Т.А., Оруджлы Р.Н. Применение опухолевых маркеров в клинической онкологии. - Азербайджанский журнал онкологии и смежных наук. Баку, 1998, т.4, №1-2, с.3-10
4. Бахшалиева Н.А. Вклад азербайджанских ученых в развитие онкологии. - Дисс... канд. биол. наук. Баку, 2004, 196с.
5. Гинзбург И.С. 5 лет работы НИИ рентгенологии, радиологии и онкологии МЗ Азербайджанской ССР. - Бюллетень Государственного Научно-исследовательского Института рентгенологии, радиологии и онкологии. Баку, 1946, т.1, вып. 1 и 2, с.5-20
6. Гудратов Н.О., Мамедов М.К. Экспериментальная гепатопатия, противоопухолевая резистентность и развитие опухолевого процесса. - Здоровье, Баку, 2002, №10, с.55-56
7. К 75-летию со дня рождения профессора А.Т.Аббасова. - Материалы 1 международной онкологической конференции «Предопухолевые и опухолевые заболевания молочной железы». Баку, 2003, с.117
8. Комбинированное и комплексное лечение больных со злокачественными опухолями (Руководство для врачей) /Под ред. В.И.Чиссова/ М.: Медицина, 1989, 560с.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Акмолинской области и загрязнение объектов окружающей среды в ряде ее регионов

Каримов М.А., Сейтказина Г.Д., Доскеева Р.А., Имангалиева Н.Т., Койшекенова Г.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы, Республика Казахстан

В последние годы экологические факторы стали приоритетными в эпидемиологии злокачественных опухолей, поскольку онкогенные риск- факторы тесно связаны с окружающей средой, что получило развитие в новом направлении «экологическая эпидемиология онкологических заболеваний» [1]. Среди факторов риска – выбросы промышленности и автотранспорта в атмосферный воздух, технические стоки в поверхностные и подземные воды, бытовые и производственные свалки, ядовитый дым и загрязненные стоки, которые поступают в среду обитания человека [2, 3].

Ранее [4] при изучении влияния загрязнения окружающей среды (ЗОО) канцерогенными веществами на общую онкологическую и заболеваемость раком органов желудочно-кишечного тракта в Восточно-Казахстанской области мы в качестве контроля брали эти же показатели в Акмолинской области. В дальнейшем нами специально изучалось ЗОО канцерогенными веществами в ряде населенных пунктов Акмолинской области (являющихся, по существу, пригородами г.Астаны) и северной столицы Республики [5].

Целью работы

является изучение загрязнения питьевой воды токсическими, канцерогенными веществами и выявление особенностей распространения злокачественных новообразований (ЗН) в Акмолинской области, г.Астане.

Материал и методы

Материалом для эпидемиологического анализа служили данные Канцер-регистра за 2000-2009 годы. Анализ онкологической заболеваемости проведен в соответствии с МКБ IX и X пересмотров по экстенсивным, интенсивным (ИП) и стандартизованным (СП) показателям. Последние рассчитаны прямым методом на основе мирового стандарта [6]. В биоматериале изучалось содержание канцерогенов двух классов: ПАУ (полициклических ароматических углеводородов), ТМ (тяжелых металлов), а также предшественников канцерогенов третьего класса- N-нитрозосоединений. Из класса ПАУ изучалось содержание бенз(а)пирена (БП), из класса ТМ- содержание – кадмия (Cd) никеля (Ni), свинца (Pb) и кобальта (Co), из класса N- нитрозосоединений – их предшественников (нитратов). Концентрация этих канцерогенов и токсикантов определялась в воде открытых и закрытых водоемов, используемых населением для питья и приготовления пищи, а также бытовых нужд. Кроме того, определялось их содержание в сточных водах канала и накопителя. Исследовалось эффективность очистных сооружений, о которой судили по содержанию канцерогенов и токсикантов до очистки и после нее насосно-фильтровальной станцией (НФС).

Ақмола облысындағы және оның аймақтарындағы қоршаған ортаны ластанған объектілердегі қатерлі өспелер аурулары

Каримов М.А., Сейтказина Г.Д., Доскеева Р.А., Имангалиева Н.Т., Койшекенова Г.А.

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты. Қазақстан Республикасы.

Ақмола облысында, Астана қаласында 2000-2009 жылдар аралығында уланған ауыз сулары зерттелді, канцерогенді заттегі және қатерлі өспелердің пайда болу себептері анықталды.

Ақмола облысындағы тұрғындар арасында қатерлі өспелер орта есеппен 6,5% көрсетті. Астана қаласында 7,6% ҚР мәліметтер бойынша. Қатерлі өспелердің деңгейі орта есеппен зерттеген кезде облыс бойынша 228,6% 000, СП (дүнежүзілік) -213% 000, Астана қаласы бойынша 241,8% 000, СП-214,4% 000, СП-214,4% 000.

Биообъект (су сынағы) алынды, Астана қаласы және «Малиновка» ауылы, «Жібек жолы» ауылы, «Мичурин» ауылы, «Интернационал» ауылы, «Қараөткел» ауылдарының сулары ластанған БП және ТМ (кадмий, никель, свинец, кобальт) және нитраттар. ПДК өрлеуі барлық жағдайларда орта есеппен 1,5-тен 15 ретке дейін болды. Ауыз суды тазарту Астана қаласында НФС тиімді болды, үш канцероген класына қарағанда ТМ (Ni, Pd, Co) және із бастар (нитраттар) канцероген класы N- нитрозосбіріккен, Cd тазалау кезінде әсері әлсіз. ПАУ канцероген класына қарағанда (БП) әдісі әсерлі емес.

Изучено загрязнение питьевой воды токсическими, канцерогенными веществами и выявлены особенности распространения злокачественных новообразований (ЗН) в Акмолинской области, г.Астане за 2000-2009 годы.

Удельный вес ЗН населения Акмолинской области - 6,5%, по г.Астане - 7,6% по отношению данных РК. Уровень ЗН за изучаемый период был с тенденцией снижения и в среднем по области составил 228,6%000, СП (мировой) - 213%000, по г.Астане 241,8%000, СП -214,4%000.

Биообъекты (проба воды) отобранные по г.Астане и в селе «Малиновка», селе «Жибек жолы», пос. «Мичурино», пос.«Интернационал», в скважинах с.«Қараөткел» и «Жибек жолы», пос.«Интернационал», «Мичурино» загрязнены БП и ТМ (кадмий, никель, свинец, кобальт) и нитратами. Превышение ПДК во всех случаях в среднем было от 1,5 до 15 раз. Способ очистки питьевой воды в г.Астане на НФС эффективен по отношению к трем канцерогенам класса ТМ (Ni, Pb, Co) и предшественникам (нитратам) канцерогенов класса N-нитрозосоединений,

Всего изучено 27 проб по 11 и 15 проб два раза в 2009 и 2010 гг. Определение ПАУ, а именно индикаторного БП проводилось спектрально-флуоресцентным методом на приборе Флюорат-02М с приставкой ВЭЖХ, а тяжелых металлов методом атомной абсорбции на спектрофотометре С-301.

Результаты. В Акмолинской области и г.Астане за 10 лет зарегистрировано 28713 больных злокачественными новообразованиями (ЗН), и удельный вес составил 9,9% по отношению данных по республике. Изучение заболеваемости ЗН проведено в динамике, а также по 3-летним временным периодам (I-2000-2002, II-2003-2005, III-2006-2008 гг.).

По Акмолинской области с 2000 по 2009 годы зарегистрировано 18717 больных с онкопатологией. Заболеваемость ЗН населения за 10 лет в целом характеризовалась тенденцией снижения с 229,3‰ (2000 г) до 211,6‰ (2009 г.). Динамика показателей заболеваемости ЗН имела три пика роста в 2001

г. (239,8‰) и 2004 г. (239,3‰), а также в 2007 году (229,3‰), однако анализ заболеваемости ЗН по трехлетним интервалам показал снижение с 234,6‰ (2000-2002 гг.), до 219,4‰ в последнем периоде. Аналогичные изменения (рис.1) отмечены при стандартизации показателей заболеваемости мировым стандартом (Тин=3,8, Тст=-3,1).

Интенсивные показатели заболеваемости ЗН мужского населения были с незначительным понижением с 239,0‰ до 231,2‰ в последнем периоде (Тин=-1,3%), тогда как стандартизованные показатели выросли с 193,9‰ до 243,2‰ (рис.2).

Анализ интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости женского населения (рис.3), показал, что они выросли с 151,9‰ до 208,6‰, тогда как стандартизованные снизились с 248,0‰ до 162,0‰.

Таким образом, удельный вес заболевших злокачественными опухолями населения Акмолинской области в среднем составил 6,5% по отношению данных республики. Уровень ЗН населения области в среднем за изучаемый период был 228,6‰, а СП (мировой) - 213‰.

№	Место отбора проб	Характеристика проб	Содержание канцерогенных веществ					
			ПАУ, мкг/л	тяжелых металлов, мг/л				
				БП	Cd	Ni	Pb	Co
			Предельно допустимые концентрации (ПДК)					
			0,005	0,001	0,1	0,03	0,1	45,0
1	р. Ишим	вход в город	0,014	0,007	0,012	0,013	0,022	37,12
2	р. Ишим	центр города	0,03	0,01	0,03	0,029	0,02	35,64
3	р. Ишим	выход из города	0,031	0,013	0,03	0,034	0,019	42,13
4	Астана, Алматин. р-н	ЦВС, колонка	0,009	0,01	0,029	0,024	0,010	35,7
5	Астана, Сарыаркин. р-н	ЦВС, колонка	0,011	0,006	0,012	0,014	0,009	20,92
6	с. Караоткел	скважина, 8 м	0,004	0,009	0,026	0,033	0,021	41,38
7	с. Малиновка	ЦВС, колонка	0,006	0,009	0,024	0,03	0,024	54,3
8	с. Жибек жолы	скважина, 8м	0,023	0,008	0,20	0,019	0,015	47,12
9	с. Жибек жолы	колонка	0,010	0,007	0,012	0,015	0,02	32,17
10	пос. Мичурино	колодец, 10м	0,04	0,009	0,03	0,031	0,012	64,8
11	насос-фильтров.станция	до очистки	0,02	0,009	0,032	0,028	0,025	46,71
12	насос-фильтров.станция	после очистки	0,03	0,008	0,026	0,012	0,018	35,60
13	с. Бошан	канал сточн.вод	0,15	0,011	0,05	0,04	0,19	39,58
14	с. Бошан	накоп. сточных вод	0,12	0,015	0,04	0,05	0,22	49,0
15	р. Сорбулак	вход в Ишим	0,03	0,01	0,09	0,061	0,2	50,25

Таблица 1 - Содержание канцерогенных веществ в пробах воды г.Астаны и Акмолинской области за 2010г

№	Место отбора проб	Характеристика проб	Содержание канцерогенных веществ					
			ПАУ, мкг/л	тяжелых металлов, мг/л				
				БП	Cd	Ni	Pb	Co
			Предельно допустимые концентрации (ПДК)					
			0,005	0,001	0,1	0,03	0,1	45,0
1	р. Ишим	вход в город	0,038	0,004	0,027	0,041	0,037	34,52
2	р. Ишим	центр города	0,02	0,013	0,03	0,052	0,030	24,37
3	р. Ишим	выход из города	0,04	0,007	0,017	0,035	0,024	31,40
4	Астана, Алматин. р-н	ЦВС, колонка	0,005	0,007	0,027	0,038	0,035	68,19
5	пос.Мичурино	скважина, 8 м	0,03	0,009	0,013	0,037	0,020	29,12
6	пос.Мичурино	ЦВС, колонка	0,12	0,012	0,022	0,021	0,028	14,95
7	пос.Интернационал	скважина, 8м	0,09	0,008	0,03	0,073	0,032	20,56
8	пос.Интернационал	ЦВС, колонка	0,024	0,006	0,011	0,06	0,017	27,43
9	насос-фильтров.станция	до очистки	0,02	0,002	0,019	0,072	0,032	21,87
10	насос-фильтров.станция	после очистки	0,048	0,0006	0,011	0,024	0,017	12,56
11	с. Бошан	накоп. сточных вод	0,13	0,017	0,023	0,048	0,030	39,47

Таблица 2 - Содержание канцерогенных веществ в пробах воды г.Астаны и Акмолинской области за 2009г

Среднегодовые ИП заболеваемости мужского населения области составили 239,7‰, а стандартизованные – 230,6‰. Частота ЗН среди женского населения - 220,8‰. СП – 186,2‰.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в г.Астана за 10-летний период зарегистрировано 9996 больных злокачественными новообразованиями в г.Астана, что составляет 3,46% по отношению данных республики. Динамика интенсивных показателей ЗН населения области за 2000-2009 гг. имела тенденцию снижения с 251,9‰ (2000 г) до 191,3‰ (2009 г) (рис. 4).

Аналогичные изменения отмечены в показателях при стандартизации данных мировым стандартом (259,8‰-195,2‰).

Для заболеваемости ЗН мужского населения характерно снижение ИП с 247,3‰ до 162,0‰, СП – с 303,1 до 190,5‰ в последнем периоде (рис.5).

Анализ интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости женского населения (рис.6), показал, что по ИП отмечается его резкое падение в 2001 году, затем постепенное снижение заболеваемости по выравненным 3-летним интервалам до 202,6‰. Динамика СП соответ-

ствовала изменениям ИП (в 234,4‰ – 208,0‰) (рис. 6).

Таким образом, удельный вес злокачественными опухолями обоего пола населения в г.Астана в среднем составляет 7,6% по отношению данных республики. Среднегодовые интенсивные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями населения за изучаемый период составили 191,4‰, а стандартизованные (мировой) - 214,4‰.

Среднегодовые интенсивные показатели заболеваемости мужского населения в г.Астана – 194,0‰, а стандартизованные - 210,8‰. Частота злокачественных опухолей в области среди женского населения была 189,0‰, а стандартизованные показатели были 187,6‰.

Изучалось загрязнение канцерогенными веществами воды открытых водоемов- реки Ишим, канала и накопителя сточных вод, в с.Бошан, а также закрытых водоемов - из труб центрального водоснабжения (ЦВС), колонок, скважин и колодцев. Определению подвергалось: вода реки Ишим до вхождения в г. Астану, в самом городе и при выходе из него; вода из водопровода (колонок) ЦВС в Алматинском, Сарыаркинском районах города Астана, в селе «Малиновка», селе «Жибек жолы», пос. «Мичурино», пос. «Интернационал», в скважинах с.«Караоткел» и «Жибек жолы», пос. «Интернационал», «Мичурино».

Полученные данные приведены в табл. 1 и 2. Как видно из табл.1, в 2009г во всех изученных пробах воды содержание канцерогенов класса ПАУ было выше предельно допустимых концентраций (ПДК). Если содержание БП в воде р.Ишим у пос.«Кегенжар» при входе ее в город было равно 0,038 мкг/л, что выше ПДК (равный 0,005мкг/л) в 7,6 раза, то при вытеании из города в воде реки оно составляло 0,04 мкг/л, т.е. 8ПДК. Другими словами в это время года в момент отбора проб город реку почти не загрязнял. В скважинах пос. «Мичурино» содержание БП превышало ПДК в 6 раз, и в пос.«Интернационал» почти в 5 раз. В пробах воды, отобранной из колонок этих населенных пунктов, содержание БП было заметно больше - от 18 до 24ПДК.

Если содержание БП в воде, отобранной из насосно-фильтровальной станции (НФС) до очистки, превышало ПДК в 4 раза, то после очистки оно не только не снизилось, а даже повысилось, превышая ПДК в 6 раз. Подобное явление трудно объяснить однозначно. Можно полагать две возможные версии. Первая- материал, служащий в качестве фильтра, утратил свои фильтрационные свойства и за многолетнее использование в самом фильтре накопилось значительное количество БП и при протекании воды через этот фильтр БП поступает из среды с большим его содержанием в среду с меньшим содержанием, т.е. происходит реабсорбция БП. Иначе говоря, этот фильтр не годится для очистки воды от БП. Вторая версия - материалы, используемые для фильтрации, т.е. керамзит и (или) цоалит сами содержат БП, который образуется в процессе выработки керамзита и цоалита. Поэтому из него БП попадает в воду. В таком случае следует отказаться от керамзита и (или) цоалита как фильтра и использовать для этих целей песок и глину, как хорошие адсорбенты.

В 2010 г (табл.2) проведенное повторное изучение показало, что содержание БП в воде р.Ишим при входе ее в город было равно 0,014 мкг/л (3ПДК), т.е. река была уже загрязнена этим канцерогеном. В самом центре города содержание БП в воде р.Ишим было в 2 раза больше, слегка повысившись в воде реки при вытекании ее из города. В колонках ЦВС Алматинского и Сарыаркинского районов города содержание БП было в пределах 2ПДК. Питьевая

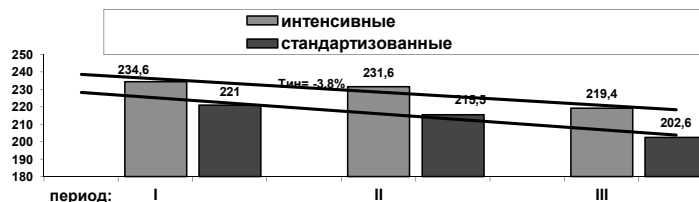


Рисунок 1 - Динамика показателей заболеваемости ЗН населения Акмолинской области по трехлетним периодам

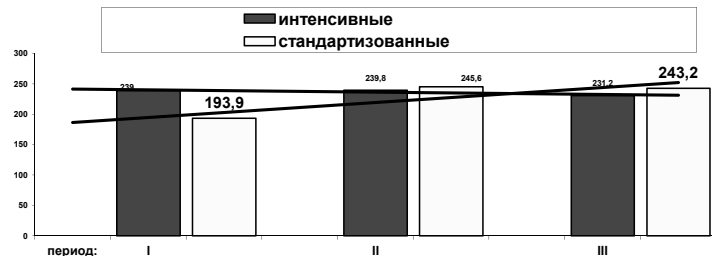


Рисунок 2- Динамика показателей заболеваемости ЗН мужского населения Акмолинской области по трехлетним периодам

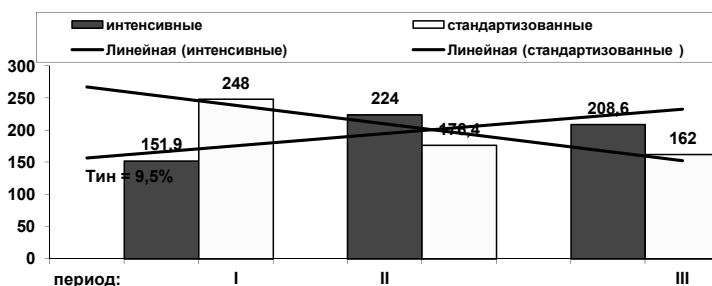


Рисунок 3- Динамика показателей заболеваемости ЗН женского населения Акмолинской области по трехлетним периодам

вода в колонках ЦВС с.Малиновки была всего на 17% выше допустимой концентрации, тогда как в воде скважины этого населенного пункта превышение ПДК БП было в 2 раза. В колонке с.Жибек-Жолы содержание БП было выше ПДК в 2 раза, в воде колодца пос. Мичурино содержание БП было выше ПДК в 8 раз. В воде канала и накопителя СВ содержание БП превышало ПДК в 24-30 раз, т.е. эта вода для хозяйственных нужд- водопоя скота и поливов сельхозугодий не пригодна. В реке Сорбулак, впадающей в Ишим, содержание БП было выше ПДК в 6 раз. Другими словами эта речка заметно загрязняет р.Ишим.

Определение содержания ТМ в 2009 г (см.табл.1) свидетельствовало о незначительном загрязнении ими воды открытых и закрытых водоемов Рb, превышающим ПДК в р.Ишим, скважинах и колонках пос.«Мичурино» в 1,2-1,7 раза, а в воде скважин и колонок пос.«Интернационал»- в 2-2,4 раза. Содержание Ni, Со было в пределах допустимых величин. Река Ишим значительно загрязнена Cd, содержание которого при входе в г.Астану составляло 4ПДК, а в центре города в воде реки в районе парка «Астана» - 13ПДК и при выходе реки из города- 7ПДК. В воде скважин и колонок пос.«Мичурино» содержание Cd было в пределах 9-12ПДК, пос.«Интернационал»- 6-8ПДК. В накопителе сточных вод содержание Cd доходило до уровня 17ПДК. Содержание нитратов во всех изученных пробах воды было в пределах нормы. Определение содержания ТМ в 2010 г (см.табл.2) показало, что оно превышало ПДК только по Cd. Содержание Ni, Рb, Со ни в одной из 12 проб, отобранных в открытых и закрытых водоемах г.Астана, не превышало ПДК. Только в речке Сорбулак, впадающей в р.Ишим, Рb и Со содержалось в пределах 2ПДК, а Cd в пределах 10ПДК. Содержание Cd было повышено во всех изученных пробах, превышающих ПДК в 7-10 раз. В канале и накопителе сточных вод (СВ) содержание Cd превышало ПДК в 11-15 раз, Рb- в 1,5 раза, Со- в 1,9-2,2 раза. Содержание нитратов во всех исследованных пробах

воды было в пределах нормы.

Особое внимание следует обратить на деятельность очистных сооружений. Содержание БП, относящегося к классу канцерогенных ПАУ, после очистки не только не снизилось, но даже повысилось. Если в 2009 г содержание БП в воде НФС до очистки было 0,02 мкг/л (4ПДК), то в воде НФС после очистки оно составило 0,048 мкг/л (9,6ПДК). Повторное исследование в 2010 г подтвердило мнение относительно неэффективности способа очистки воды от БП, применяемого в г.Астане. Так, если содержание БП в воде НФС до очистки было равно 0,02мкг/л (4ПДК), то в воде НФС после очистки оно составляло 0,03мкг/л (6ПДК). Следовательно, этот метод очистки воды не эффективен по отношению к БП. Что касается очистки питьевой воды от канцерогенов класса ТМ, то данные определения их в 2009 г в воде до и после очистки свидетельствуют о достаточной эффективности НФС. Так, содержание Cd снизилось в 3 раза и достигло нормы. Содержание Ni снизилось почти в 2 раза, Pb- в 3 раза и достигло нормы, Co- в 2 раза. Определение их в 2010 г показало, что снижение уровня Cd было незначительное (на 12%) и его количество после очистки составляло 8ПДК. Снижение содержания Ni было в 5 раз, Pb- в 2 раза, Co- на 25%. Снижение содержания нитратов было на 24% и оно было в пределах допустимых концентраций.

Таким образом, способ очистки питьевой воды в г.Астане на НФС эффективен по отношению к трем канцерогенам класса ТМ (Ni, Pb, Co) и предшественникам (нитратам) канцерогенов класса N-нитрозосоединений, слабо эффективен при очистке от Cd. По отношению к канцерогенам класса ПАУ (БП) метод не эффективен.

Список литературы

1. Ревич Б.А. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения // Введение в экологическую эпидемиологию. М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 264 С.
2. Ильющенков А.В. Среда обитания и формирование канцерогенного риска здоровью населения малого промышленного города: Автореф. дис... канд. мед. наук.- Оренбург, гос. мед. акад., Оренбург.- 2004. - 20 с.
3. Лазарев А.Ф. Экологическая эпидемиология онкологических заболеваний // IV съезд онкологов и радиологов СНГ (материалы съезда), 28 сентября-01 октября 2006. Баку. – 2006. - С. 18-19.
4. Каримов М.А., Сейтказина Г.Д., Доскеева Р.А., Игисинев С.И., Имангалиева Н.Т., Койшекенова Г.А. Эпидемиология злокачественных новообразований в Восточно-Казахстанской области и загрязнение объектов окружающей среды в ряде ее регионов. // «Гигиена, эпидемиология и иммунобиология». -2011. - №2 (48). – с. 34-39.
5. Ананьев Н.И., Исенев Ш.А. Мейрамов Э.А. Биоресурсы и экологическое состояние Акмолинской области- Акмола, 1997.-134 с.
6. Мерков А.М., Поляков Л.Е. Санитарная статистика.- Ленинград, 1974. – 134 с.

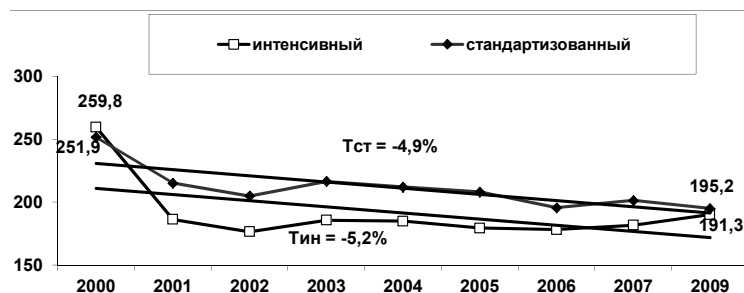


Рисунок 4 - Динамика интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости ЗН всего населения г. Астаны

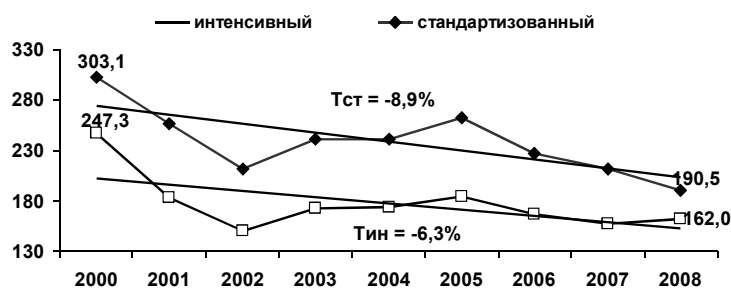


Рисунок 5 - Динамика интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости ЗН мужского населения г. Астаны

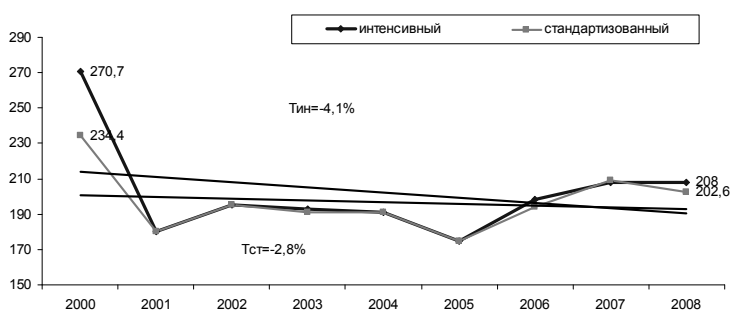


Рисунок 6 - Динамика интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости ЗН женского населения г. Астаны

Современные методы диагностики и лечения неходжкинских лимфом

Каракулов Р.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Неходжкинские лимфомы (НХЛ) – это злокачественные опухоли с быстрым ростом заболеваемости во всем мире. Заболеваемость НХЛ значительно выше в развитых странах. В России НХЛ составляют 2,55 от всех злокачественных опухолей; в 2002 г. выявлено 5532 новых случая. Стандартизованный показатель заболеваемости среди мужчин составил 8,2, а среди женщин – 7,2 на 100 000 населения, в США с 1973 по 1991 г заболеваемость возросла с 8,5 до 15,1 случаев на 100 000 населения, в Украине среди взрослого населения составляет 2,51 на 100 000 населения.

В Республике Казахстан злокачественные лимфомы в структуре онкопатологии занимает 8 ранговую позицию составляя 4,2 на 100 000 населения. ежегодно регистрируется около 500 первично диагностированных злокачественных лимфом, около 350 погибает в первый год регистрации. Средний возраст погибающих от данной патологии составляет 40-45 лет, т.е. это наиболее трудоспособный возраст. Пятилетняя выживаемость составляет 48,0-50,0%. Самые высокие показатели заболеваемости этой формой опухоли установлены в Северо-Казахстанской (16,3%000), Павлодарской (14,2%000.). Аналогичная ситуация наблюдается и по смертности. Так, высокая смертность от НХЛ отмечается в Мангистауской области-7,6, СКО-7,1, Павлодарской-7,1 и ВКО-7,0 на 100 тыс.населения (Арзыкулов Ж.А. и др.,2010).

В соответствии с современной классификации ВОЗ (2001 г) выделяется большое количество различных морфоиммунологических вариантов НХЛ. Однако частота встречаемости их весьма вариабельна. По данным мировой статистики, наиболее часто выявляется НХЛ В-клеточного происхождения (более 80%), а среди них – диффузная крупноклеточная (30,6%) и фолликулярная (22,1%). Другие варианты диагностируются значительно реже: НХЛ Т- клеточного происхождения составляют менее 20%, а периферические Т-клеточные – только 7%.

При НХЛ 5-летняя выживаемость широко варьирует в зависимости от морфоиммунологического варианта опухоли: при В-клеточных лимфомах маргинальной зоны, MALT-лимфомах и фолликулярных лимфомах не превышает 70%, что трактуется как очень хороший прогноз, тогда как при Т-лимфобластных, приферических Т-клеточных НХЛ этот показатель ниже 30% (Поддубная И.В.,2002).

Классификация и клиника неходжкинских лимфом

Лимфомы можно разделить на группы: первая группа (индолентные), которые включают В-клеточные : ХЛЛ/мелкоклеточная лимфоцитарная , волосоклеточный лейкоз, лимфома маргинальной зоны (селезенки), экстра nodальные (MALT), нодальные фолликулярные лимфомы (1-П тип). Т-клеточные: грибовидный микоз, ангиоиммуннобластная лимфома, В-,Т-,О-фенотип анапластическая крупноклеточная. Пятилетняя выживаемость которых составляет 50,0%.

Агрессивные лимфомы включают В-клеточные лимфомы, фолликулярную лимфому (Ш тип), диф-

Жана талапка сай эдютемен Ходжскин емес лимфомана анықтау және емдеу

Каракалов Р.К.

Макалада эдеби шолу жасалып, ходжскин емес лимфомада (ХЕЛ) диагностика да және емдеуде жана эдютер колданылган. Мәселен, ХЕЛ-д\ емдегенде катерл1 киктиц ишиде эртурл1 антигендердиц бар болуын еспетейд1 (CD 20 (+) жәнэ хромосомдык анамолылардыц кездесу1 немесе кездеспеу1 ете маңызды.

Современные методы диагностики и лечения неходжкинских лимфом

проф.Каракулов Р.К.

В статье приведены литературные данные, касающиеся современных методов диагностики и лечения неходжкинских лимфом (НХЛ). В частности применение методов ИГХ и определение генетических маркеров при различных формах НХЛ. Лечение НХЛ проводится с учетом присутствия в опухолях CD 20 (+) антигена и химерных онкогенов, а также хромосомной аномалии.

Modern methods of non Hodgkins lymphomas diagnosis and treatment

Proffessor Karakulov R.K.

Modern methods presents the literature data concerning modern methods of non Hodgkins lymphomas diagnosis and tretment. In particular the application of immunohistochemistry and identification of genetic markers in different forms of non Hodgkins lymphomas. Treatment non Hodgkins lymphoms conduc with the presence CD20 (+) antigen, chimeric oncogens, and chrosomal abnormalities in tumors.

фузную В-клеточную, превично медиастинальную, В-крупноклеточную и Беркитоподобную, пламацитома\миелома, пятилетняя выживаемость которых составляет 30-50,0%. Высокоагрессивные лимфомы: Т-иВ-лимфобластная лимфома\лейкемия из клеток предшественников.В-клеточные:лимфома зоны мантии и Беркита. Т-клеточные:Т-лимфомы\лейкемия взрослых, еприферическая Т-клеточная лимфома и тонкокишечная Т-клеточная лимфома. Пятилетняя выживаемость которых равна 30,0%.

Клинические проявления НХЛ

Отмечается отчетливая разница в частоте поражения разных органов и тканей: так, поражение медиастинальных лимфатических узлов возникает реже, чем при лимфоме Ходжкина, составляя 15–25%, паренхиматозные легочные поражения встречается в 3–6% случаев, вовлечение в процесс селезенки составляет 30–40%, печени – 15–50%, костей – 5–15%, желудочно-кишечного тракта – 10–24%, костного мозга – 30–40%.

Наиболее часто первыми проявлениями болезни бы-

вает поражение лимфатических узлов (45–50%); при этом периферические лимфатические узлы вовлекаются в процесс значительно чаще (35–38%), чем медиастинальные, забрюшинные и внутрибрюшные.

Поражая изначально одну анатомическую зону, опухоль постепенно генерализуется. С наибольшей частотой происходит метастазирование в однородные органы и ткани; этот тип генерализации является основным для исходного поражения лимфатических узлов, кожи, костей. Велика вероятность появления опухоли в желудке при начале болезни с поражения лимфатического аппарата кольца Пирогова–Вальдейера. Известно, что при начальном вовлечении в процесс лимфатических узлов средостения происходит преимущественно гематогенная диссеминация с поражением легочной ткани, ЦНС, надпочечников, костного мозга. Костный мозг может поражаться с развитием лейкемической или очаговой опухолевой инфильтрации.

Для определения распространенности НХЛ рекомендуется использовать предложенную в Ann Arbor (1971 г.) классификацию лимфогранулематоза. Существуют две системы стадирования: клиническая (cS) и патологоанатомическая (pS), клиническое стадирование (cS). Хотя клиническая классификация по стадиям несовершенна, она легко выполнима и может применяться в различных учреждениях для получения сопоставимых данных. Эта классификация базируется на данных анамнеза, клинического обследования, методов визуализации и биопсии. Биопсия костного мозга должна проводиться из клинически и рентгенологически не пораженного участка кости.

Патологоанатомическое стадирование (pS). Более точное представление о распространенности опухолевого поражения дает определение патологоанатомических (p) стадий процесса. Классификация применяется в тех случаях, когда для нее имеются данные гистологического исследования. Ряд признаков при определении стадии в зависимости от результатов гистологического исследования отмечаются знаками «+» (плюс) или «-» (минус).

Патологоанатомическая информация классифицируется с помощью символов, указывающих тканевую принадлежность исследованного материала. Обозначения символов используют такие же, как и при отдаленных метастазах в классификации TNM (категории M1) злокачественных опухолей других локализаций. Однако применяются также и символы, употребляемые в классификации Ann Arbor.

Клинический вариант заболевания с исходным локализованным поражением экстранодальных органов и тканей определяется как первичная экстранодальная

НХЛ. Предполагается, что подобная трактовка клинической ситуации допустима при выявлении экстранодального опухолевого очага как единственного проявления болезни или сочетании с появляющимся впоследствии вовлечением регионарных лимфатических узлов (клинические стадии IЕ или IIЕ).

Во всем мире увеличивается число экстранодальных форм НХЛ. В США, где темп прироста заболеваемости НХЛ самый высокий, ежегодно число экстранодальных

НХЛ увеличивается на 3,0–6,9% по сравнению с 1,7–2,5% увеличением нодальных проявлений болезни; за последние две декады поражение головного мозга увеличивается на 10% в год, а органа зрения – на 6% в год. Ранее в соответствии с Ann-Arbor классификацией предполагалось, что опухолевые изменения в лимфоидной ткани (кольцо Пирогова–Вальдейера, тимус, селезенка, аппендикс, пейеровы бляшки тонкой кишки не относятся к экстранодальным. Однако в настоящее время признано, что к экстранодальным НХЛ относят опухоли, развивающиеся изначально в любых органах и тканях, кроме лимфатических узлов. Частота поражения разных органов и тканей неодинакова: наиболее часто изолиро-

ванно вовлекается желудочно-кишечный тракт (24,3%), кольцо Пирогова–Вальдейера (19,4%), головной мозг (10%), значительно реже – молочная железа (2,0%), легкие, плевра (1,1%).

Морфологический спектр экстранодальных лимфом разнообразен; при этом в одном органе могут встречаться различные опухоли. Например, в тонкой кишке могут развиваться диффузные В-крупноклеточные лимфомы, В-лимфомы маргинальной зоны, фолликулярные, зоны мантии и Т-клеточные лимфомы, ассоциированные Practical oncology с энтеропатией, иммунопролиферативная болезнь, болезнь тяжелых альфа цепей). Если же НХЛ развилась в молочной железе у молодой женщины во время беременности, то это, как правило, высокоагрессивная лимфома; в более старшем возрасте в молочной железе возникают лимфомы маргинальной зоны, фолликулярные или диффузные В-крупноклеточные.

Необходимо подчеркнуть, что биологические особенности опухоли при одних и тех же морфологических вариантах НХЛ различаются в зависимости от их экстранодальной локализации: так, диффузная В-крупноклеточная лимфома ЦНС, яичка или костей обладает различным прогнозом.

Диагноз НХЛ устанавливается на основании морфологического исследования опухолевой ткани с иммунофенотипированием. Чаще всего выполняется биопсия периферических лимфатических узлов. Необходимо отдавать предпочтение биопсии длительно существующего лимфатического узла, расположенного в легко доступных анатомических областях (лучше шейно-надключичной области, менее желательна биопсия паховых и апикальных аксиллярных лимфатических узлов).

В настоящее время вариант НХЛ устанавливается в соответствии с классификацией Всемирной Организации Здравоохранения 2001 г. При создании её на основе REAL, классификации были учтены все известные на сегодня сведения о биологии лимфоидных опухолей. Частота встречаемости различных вариантов НХЛ неодинакова: диффузная крупноклеточная лимфома – 30%, фолликулярная – 22%, маргинальной зоны – 8%, В-мелкоклеточная и периферическая Т-клеточная – 7%, зоны мантии – 5%, лимфома Беркитта – 3%, анапластическая крупноклеточная – 2%, другие варианты составляют – 12%.

Иммунологическая диагностика лимфом заключается в подробном изучении антигенов мембраны и цитоплазмы опухолевых клеток для того, чтобы определить происхождение лимфомы (В- или Т-клеточное) и стадию на которой остановлено их нормальное развитие. Проводится сопоставление иммунофенотипа (т.е. набора маркеров) клеток опухоли с иммунофенотипом нормального клеточного аналога. В процессе формирования лимфомы опухолевые лимфоидные клетки приобретают необычные (в норме практически отсутствующие) иммунологические признаки и частично утрачивают типичные антигены.

В- и Т-клеточные лимфомы подразделяются на две большие группы: лимфомы из клеток, предшественников и периферические лимфомы. При этом учитываются моноклональность или монотипность лимфоидного опухолевого пролиферата и его отличия от нормальных клеток лимфатического узла. Наиболее распространенным признаком В-клеточных лимфом является моноклональность злокачественных В-клеток по типу легких полипептидных цепей иммуноглобулинов (каппа или лямбда).

Чаще (>90%) НХЛ имеют В-клеточное происхождение, экспрессируя пан-В-клеточные антигены: CD19, CD20, CD22, обычно в сочетании с HLA/DR и молекулами поверхностных иммуноглобулинов. Наличие других В-клеточных антигенов (CD5, CD10, CD38, CD23 и др.) позволяет с наибольшей достоверностью установить В-клеточный подвариант НХЛ, что лежит в основе выбора

адекватной лечебной тактики.

Для Т-клеточных опухолей характерно наличие CD4, CD7, CD8. Дополнительные иммунофенотипические характеристики способствуют дифференциальной диагностике различных вариантов НХЛ.

Учитывая возможность расположения опухолей в любых органах и тканях, в план обследования включается большой набор диагностических методов. Обследование больного начинается с физикального осмотра с исследованием всех групп периферических лимфатических узлов. Рентгеновское исследование органов грудной клетки позволяет уточнить состояние медиастинальных лимфатических узлов (медиастинальная лимфаденопатия наблюдается в среднем у 15–25% больных, за исключением первичной НХЛ средостения или лимфобластной лимфомы из клеток предшественников, при которых это является первым или основным проявлением болезни) и выявить паренхиматозное поражение легких, наблюдающееся в 3–6% случаев. Развитие специфического плеврита отмечается нечасто (8–10%), преимущественно при агрессивных и высокоагрессивных НХЛ, или является единственным клиническим симптомом при первичной В-клеточной НХЛ серозных оболочек (primary effusion lymphoma). Доказательством опухолевой природы плеврита является цитологическое исследование выпота; информативность этого метода не превышает 65%. Поражение внутрибрюшных и забрюшинных лимфатических узлов отмечается в среднем у 20–30% больных, печени – у 15–50%, селезенки – у 30–40%. Высокой разрешающей способностью обладает ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства, которое должно выполняться всем больным, независимо от определяемых в момент диагностики клинических проявлений заболевания. Высокая частота поражения костного мозга (30–70%), нередко протекающего без изменений гемограммы, требует обязательного исследования аспирата и трепана костного мозга.

Лимфатический аппарат кольца Вальдейера вовлекается в опухолевый процесс в 10–12% случаев. Сведения о том, что у 1/4 больных с поражением лимфатического кольца Вальдейера следующей областью поражения может быть желудок, а также данные о высокой частоте вовлечения желудочно-кишечного тракта в целом (15–25%) делают настоятельную необходимость, выполнение рентгенологического исследования желудка или, предпочтительно, гастроскопии с множественной биопсией суспензионных участков слизистой оболочки. При выявлении специфического поражения желудка обязательно рентгенологическое исследование всех отделов кишечника, так как у этих больных в 4% наблюдений может быть сочетанное вовлечение нескольких отделов желудочно-кишечного тракта. Опухолевые изменения в костях наблюдаются у 5–15% больных и могут быть диагностированы при рентгенологическом или радиоизотопном методе исследования.

Уточняющими и дополняющими возможностями обладают компьютерная и магнитно-резонансная томографии (КТ и МРТ), показания к применению которых определяются в каждом конкретном клиническом случае.

При некоторых особых клинических вариантах НХЛ требуется проведение специфических дополнительных методов обследования: при клинических признаках поражения оболочек головного и спинного мозга – осмотр невропатолога и, при показаниях, – люмбальная пункция.

Лабораторная диагностика НХЛ

У больных с лимфомой в крови изменения либо отсутствуют, либо выявляются небольшой лейкоцитоз и лимфоцитоз. При нодулярном варианте в мазке крови или

в лейкоконцентрате могут быть обнаружены лимфоциты с расщепленным ядром. Иногда отмечаются эозинофилия и увеличение числа эозинофилов в миелограмме. Количество тромбоцитов нормальное, но в дальнейшем оно может снижаться. Число эритроцитов не изменено, в некоторых случаях развивается АГА с положительной прямой пробой Кумбса. СОЭ чаще повышена. Картина пунктата костного мозга неспецифична. В то же время в трансплантате костного мозга у 1/3 больных, чаще с нодулярным вариантом и диффузной зрелоклеточной лимфомой, могут обнаруживаться пролифераты лимфоидных клеток, которые имеют диагностическое значение. Лейкемическая фаза, когда процесс уже неотличим от лейкоза, редко наблюдается у взрослых больных, но развивается у 25 % детей.

При пункции и биопсии опухолевых узлов (лимфатических узлов, селезенки и т. д.) выявляют нодулярную или диффузную опухолевую пролиферацию лимфоидных клеток того или иного морфологического типа.

Наряду с морфологическим изучением проводят иммунологическое фенотипирование опухолевых клеток с выявлением иммуноглобулиновых поверхностных маркеров В-клеток, тестом розеткообразования с эритроцитами барана (Т-клетки), а также использованием моноклональных антител к В- и Т-клеткам. Весьма важным является определение химерных онкогенов и хромосомных аномалий при различных формах НХЛ. В частности определение экспрессии BclA1,2,3, BclA10, c-myc, pax A5, IgH – hcl2 и Bcl-6.

Диагноз и дифференциальный диагноз НХЛ

Первыми признаками лимфомы являются, когда появляется какая-либо плотная опухоль в лимфатических узлах, селезенке и других областях. Сохранение этой опухоли в течение длительного времени, даже без других общих признаков заболевания, требует биопсии опухолевого узла. При расположении лимфатических узлов в труднодоступных областях проводят комплекс диагностических исследований для их выявления с целью биопсии. Диагноз всегда морфологический, при всех случаях биопсии необходимо отпечатки полученного материала сравнивать с данными гистологического исследования.

Дифференциальную диагностику проводят с лимфогранулематозом. Критериями отличия является то, что неходжкинские лимфомы чаще, чем лимфогранулематоз, локализируются вне лимфатических узлов (соответственно в 40 и 10 % случаев) и уже в момент постановки диагноза обнаруживают признаки генерализации, в связи с чем стадия I и II диагностируют редко.

Окончательное разграничение основывается на морфологических данных. Дифференциальный диагноз следует провести с реактивными лимфаденитами, метастатическими поражениями лимфоузлов, туберкулезным лимфаденитом и другими реактивными

Основные принципы лечения и прогноз НХЛ

Лечение зависит от клинической стадии и характеристики опухолевых клеток, составляющих субстрат опухоли. Выделение стадий проводится по тем же признакам, что и при лимфогранулематозе. У больных с I и II стадиями болезни может применяться только лучевая терапия, локализованные лимфомы, например желудка, селезенки, требуют хирургического лечения, удаление опухоли с последующей химиотерапией или иногда даже без нее ведет к длительной ремиссии. Больным с III и IV стадиями

(на этих стадиях болезнь диагностируют чаще) назначают преимущественно полихимиотерапию (циклофосфан, адриамицин, винкристин, преднизолон, блеомицин).

Однако тактика лечения у этих больных может быть разной в зависимости от цитологического состава опухоли. Агрессивную полихимиотерапию проводят больным неходжкинской лимфомой группы высокой и промежуточной степени злокачественности, имеющим при естественном течении заболевания продолжительность жизни 1–2 года. В результате полихимиотерапии у 60 % больных достигают полной ремиссии, безрецидивное течение возможно до 5 лет и более. У больных лимфомой низкой степени злокачественности, средняя продолжительность жизни которых составляет и при естественном течении около 5 лет, допустимо определенное время только наблюдение или назначение паллиативной лучевой терапии и монохимиотерапии, например хлорбутином.

Современные методы лечения позволяют продлевать жизнь значительной части больных и добиваться полного выздоровления у 50 % больных с I и II стадиями заболевания.

Хирургическое лечение считается безусловно показанным только при одиночных желудочно-кишечного тракта, кроме опухолей прямой кишки. Если I стадия была установлена правильно, то после операции почти 60% пациентов живут без рецидивов 5 и более лет. Во стадии и у больных с неблагоприятными прогностическими признаками в I стадии хирургическое лечение обязательно должно быть дополнено полихимиотерапией.

Лучевая терапия является высоко эффективным методом лечения НХЛ низкой степени злокачественности. Лишь в отдельных случаях, при невозможности или бесперспективности проведения химиотерапии, лучевая терапия может быть использована в качестве паллиативного облучения отдельных опухолевых образований по 2 Гр ежедневно до СОД 38–40 Гр.

Комбинированное (химиолучевое лечение) при 1–2 А и Б стадиях приводит к полной ремиссии не менее, чем у 70–80% больных. Химиолучевое лечение занимает более короткое время, если лучевая терапия проводится одновременно с химиотерапией. Облучение в дозе 34–36 Гр подлежат только клинические зоны поражения.

Больным НХЛ низкой степени злокачественности в I стадии до и после лучевой терапии можно ограничиться 2-мя циклами ПХТ или монохимиотерапией. Пациентам НХЛ высокой степени злокачественности даже I стадии до начала лучевой терапии и после нее проводится по 3 цикла ПХТ. Во II-стадии всем пациентам вне зависимости от степени злокачественности лимфом следует проводить все 6 циклов ПХТ: 3 до и 3 после облучения.

Химиотерапия основным методом лечения, применяется при всех гистологических вариантах, стадиях и локализациях НХЛ.

Алгоритм лечения индолентных НХЛ

Исходные позиции алгоритма лечения индолентных НХЛ заключаются в том, что он предназначен для В-клеточных их вариантов и, в основном, фолликулярных I и II степени, составляющих большинство, но в 20–30% случаях трансформирующихся в диффузные В-крупноклеточные и требующие соответственно другого лечения по принципиальной схеме для агрессивных форм, к которым примыкают фолликулярные НХЛ III степени. Одна лишь лучевая терапия в I и II стадиях (30–50 Гр на очаг) дает от 54% до 88% 10-летней безрецидивной выживаемости [11,24,30]. Выжидательная тактика – до появления симптомов интоксикации или прогрессирования, опирающаяся на то, что другие варианты подхода не приводят к увели-

чению продолжительности жизни, разделяется отнюдь не безоговорочно (в том числе и больными). Характерно, что клинические рекомендации ESMO (2003) предполагают, что выжидательная тактика целесообразна только после первоначального лечения. В отечественной практике, в особенности при достаточном количестве опухолевых массах в III–IV стадиях, принято начинать лечение с химиотерапии – моно (алкилирующими агентами, винкаалкалоидами) или комбинированной (LOPP, COP). Следует иметь в виду, что комбинированная химиотерапия увеличивает частоту ответа и безрецидивный период но не оказывает влияния на общую выживаемость, медиана которой составляет 8–10 лет. Впрочем, и высокодозная химиотерапия с пересадкой стволовых клеток дает в этом отношении противоречивые результаты даже при достигаемых молекулярных ремиссиях. Несомненно, прогрессивным в лечении индолентных (фолликулярных I–II степени) лимфом является применение в III–IV стадии препарата моноклональных антител мабтера (ритуксимаба), индуцирующего в моноиммунотерапии до 73% ответа, с медианой времени до прогрессирования 552 дня, а при первично-рефрактерных формах и рецидивах – не менее 50% длительных ремиссий. Российский и другой опыт применения препарата, в том числе в комбинации с химиотерапией (CHOP), свидетельствует о том, что подобный подход имеет все основания считаться приближающимся к стандарту лечения индолентных НХЛ и заслуживает дальнейшего изучения, в том числе в сочетании с высокодозной терапией и пересадкой стволовых клеток или аутоотрансплантацией костного мозга, как метод повышения продолжительности жизни больных при этих лимфомах, которые до сих пор считаются принципиально инкурабельными, несмотря на длительность течения.

Существенную поддержку в аспекте продления достигнутой ремиссии при фолликулярных НХЛ I и II степени оказывает назначение рекомбинантного альфа, интерферона, явно увеличивающего их продолжительность и выживаемость при длительном (12–18 мес) применении этого цитокина.

Приведенный алгоритм не относится к достаточно редко встречающимся MALT, лимфомам, в частности, с поражением желудка, требующим, в первую очередь, эрадикации инфекции *Helicobacter pylori* (антибиотики, блокаторы H₂-рецепторов, коллоидный висмут, антипротозойные средства) и только в резистентных случаях – стандартной для индолентных или агрессивных НХЛ химиотерапии.

Разнообразные варианты индолентных неходжкинских лимфом (НХЛ) представлены медленно прогрессирующими опухолями, обладающими своеобразными клиническими особенностями. Индолентными лимфомами считаются В-клеточные – лимфоцитарная, фолликулярная (I–II типы), маргинальной зоны (селезенки, нодальные, экстра nodальные – MALT) и Т-клеточные – грибовидный микоз, ангиоиммунобластная; анапластическая крупноклеточная лимфома. Лимфоцитарная лимфома, морфологически и иммунофенотипически идентична хроническому лимфолейкозу (ХЛЛ), но отличается от последнего отсутствием лейкемического поражения костного мозга. Пятилетняя актуальная выживаемость равна 51%, а выживаемость, свободная от неудач лечения, – 25%. Это указывает на менее благоприятный прогноз, чем при ХЛЛ, для которого медиана выживаемости равна 7 годам.

Большинство опухолевых В-лимфоцитов экспрессируют пан В-клеточные антигены CD19, CD22, CD20 и поверхностные иммуноглобулины, которые отражают зрелоклеточный этап дифференцировки и представлены иммуноглобулинами М или М и Д. Экспрессия CD20 и CD22 значительно слабее, чем при лимфоме зоны мантии и фолликулярной. CD38 экспрессируется почти в 50% случаев, ассоциируясь

с отсутствием признаков соматических гипермутаций вариабельного региона тяжелых цепей иммуноглобулинов, и является показателем неблагоприятного прогноза.

Идентичность лимфоцитарной лимфомы и ХЛЛ обуславливает одинаковую лечебную тактику. Не более 2% больных с истинно локализованными стадиями эффективно лечатся с использованием лучевой терапии или монотерапии алкилатами. Пуриновые антиметаболиты (флударабин, кладрибин, пентостатин) более эффективны. Большую роль играет сопутствующая терапия: при развитии аутоиммунной анемии и тромбоцитопении – использование кортикостероидов, при возникновении инфекционных осложнений вследствие иммунодефицита – применение антибиотиков и иммуноглобулинов.

Фолликулярная лимфома – наиболее часто встречающийся среди индолентных НХЛ вариант; занимает второе место среди всех НХЛ после диффузной В-крупноклеточной лимфомы и др. (2003).

Фолликулярная лимфома развивается преимущественно у взрослых. Лимфатические узлы при пальпации безболезненные, мягкоэластической консистенции. Общие симптомы (лихорадка, похудание, потливость) встречаются редко (10–15%), и основные клинические проявления обусловлены локальными симптомами в области расположения основных опухолевых масс (например, боли в спине или животе с нарушением функции кишечника при увеличении абдоминальных или забрюшинных лимфатических узлов). У 65% пациентов болезнь диагностируется в распространенной (IV) стадии; значительно реже (19%) констатируется наличие III стадии; еще реже заболевание удается выявить на начальных этапах процесса: в I стадии – в 6% случаев, во II стадии – в 10% случаев. Прогноз благоприятный; 5-летняя выживаемость равна 70%, 10-летняя – 15%. Несмотря на благоприятный прогноз болезни в целом, установлено отчетливое негативное влияние факторов риска на длительность жизни пациентов.

Морфологически фолликулярная лимфома состоит либо из преимущественно мелких В-лимфоидных клеток с извитым ядром (центроциты), либо из их сочетания с крупными клетками (центробласты). Опухоль чаще имеет склонность к узловому росту (75%), хотя может иметь место диффузный и смешанный характер её распространения (25–75%). Прогноз существенно ухудшается при увеличении в опухолевой ткани количества крупных клеток. Это легло в основу морфологического выделения трёх типов фолликулярной НХЛ: 1 тип – опухоль состоит преимущественно из мелких клеток, 2 тип – смешанное представительство мелких и крупных клеток. Установлено, что I–II типы фолликулярной лимфомы, будучи индолентными, обычно не излечиваются, а III тип более агрессивен и, в то же время, более чувствителен к терапии, используемой для лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы. Терапевтические подходы зависят от распространенности заболевания: I–II стадии в сравнении с III–IV стадиями.

Комбинированное лечение всегда следует начинать с химиотерапии, которая приводит к полным ремиссиям не менее чем у 70% больных уже к моменту начала лучевого этапа лечения. Несмотря на это, лучевую терапию обязательно включают в комплекс лечебных мероприятий, так как она дает более стойкие местные лечебные результаты. Комбинированное химиолучевое лечение осуществляется или в виде «сэндвича» (2–3 цикла полихимиотерапии + лучевая терапия + 2–3 цикла полихимиотерапии) или после завершения всей программы химиотерапии. Выбор метода химиолучевой терапии зависит от морфоиммунологического варианта НХЛ и прогностического индекса.

При I стадии индолентных НХЛ до и после лучевой терапии проводится по 2 цикла полихимиотерапии по схеме COP. Альтернативным вариантом лечения этой

группы больных могут быть 3 цикла полихимиотерапии с последующей лучевой терапией без дополнительной химиотерапии после облучения, если к моменту начала лучевой терапии была достигнута полная ремиссия.

Облучению подлежат только исходные зоны поражения (традиционный режим гамма-терапии – 2 Гр/сут до суммарной очаговой дозы 32–36 Гр). Частота рецидивов составляет 18–30%, в течение первого года они возникают менее чем у 1/3 больных.

Основными гормональными препаратами являются преднизолон и его аналоги, в том числе метилпреднизолон (медрол для приема внутрь), которые назначаются короткими курсами (7–14 дней в дозе 30–40 мг/м²) с быстрой (за 3–4 дня) отменой и повторением лечения каждые 3–4 нед. Гормонотерапия оказывает быстрый противоопухолевый эффект в 20–80% случаев и уменьшает выраженность общих симптомов.

При медленно прогрессирующих опухолях в течение длительного времени может с успехом использоваться монокимиотерапия, преимущественно алкилирующими препаратами. Лейкеран назначается в дозе 6 мг/м² (суточная доза 10 мг) ежедневно или 5 дней в неделю до суммарной дозы 400–500 мг. Получило признание использование лейкерана непрерывно в течение 6 нед (при приеме 5 дней в неделю по 10 мг суммарная доза составит 300 мг) с последующим чередованием 2-недельного курса лечения (с применением тех же доз) и 2-недельных интервалов до суммарной дозы 500 мг. Наибольшее распространение получили схемы CHOP, LVPP, COP, CVP; схемам COP и CVP следует отдавать предпочтение при исходной тромбоцитопении.

Перспективным считается использование флударабина, кладрибина, митоксантрона в сочетании с алкилатами. Следует помнить, что использование флударабина оказывает не редко быстрый противоопухолевый эффект, но значительно повышает риск развития инфекций (бактериальных, грибковых, вирусных, в частности герпетических) и гемолитической анемии, что отрицательно сказывается на качестве жизни пожилых больных.

Большой мировой опыт убеждает в целесообразности применения флударабина в комбинации с митоксантроном (FM) или циклофосфаном (FC) в первой линии терапии распространенных фолликулярных лимфом: двукратно увеличивается частота ПР и на 20–25% – 5-летняя выживаемость.

В последнее время в схемах полихимиотерапии индолентных лимфом все шире стал использоваться митоксантрон (новантрон). В качестве первой линии терапии больных с благоприятным прогнозом наибольшее распространение получила комбинация MCP (митоксантрон 14 мг/м² однократно в 1-й день, лейкеран 6 мг/м² с 1-го по 10-й день и преднизолон 25 мг/м² с 1-го по 10-й день), которая все чаще заменяет схему COP. При наличии неблагоприятных факторов прогноза на первом этапе индукционной терапии используются комбинации MAP (митоксантрон, цитарабин, преднизолон), OPEN (винкристин, преднизолон, этопозид, новантрон), NOPP (новантрон, винкристин, натулан, преднизолон), MVLP (митоксантрон, тенипозид, лейкеран, преднизолон).

Особое значение при фолликулярной лимфоме приобретает использование моноклональных антител (МКА) (Короленко В.О. и др., 2003).

Терапия анти-CD20 МКА – это лечебное воздействие, обладающее уникальным механизмом действия, включающим прямую индукцию апоптоза, усиление комплемента, и антителозависимой цитотоксичности, тумороспецифичность и способность снижать токсичность лечебного средства относительно клеток «хозяина». В настоящее время представляется обоснованным интерес

комбинированному использованию мабтеры в сочетании с полихимиотерапией в первой линии терапии III–IV стадий фолликулярной лимфомы. Мабтера вводится в первый день каждого лечебного цикла в дозе 375 мг/м². Выразительные результаты применения схемы R-CHOP (с добавлением ритуксимаба к стандартному режиму CHOP): после 6 циклов ПР достигнуты у всех (100%) больных, медиана времени до прогрессирования составила 82 мес; лечение было безопасным, у пожилых больных не отмечено увеличения частоты инфекционных осложнений.

Сочетание мабтеры с флударабином также весьма эффективно. Добавление мабтеры в первый день трехдневного курса лечения флударабином (25 мг/м² в/в ежедневно) обеспечило 90% общую эффективность с высоким числом ПР (80%) и длительность ремиссии более 15 мес.

Таким образом, современные данные позволяют утверждать, что в первой линии терапии фолликулярной лимфомы схемы с мабтерой становятся новым стандартом:

Наиболее важным биологическим агентом в современной терапии НХЛ низкой степени злокачественности на этом этапе оказания помощи является рекомбинантный интерферон-альфа (альфа, IFN), который активно изучается в течение последних 20 лет. Не все аспекты его применения изучены в равной степени, но на многие вопросы позволили ответить итоги шести многоцентровых рандомизированных исследований, начатых в 1985–1988 гг. (медиана наблюдений составила 6 лет).

Метаанализ результатов применения альфа, IFN 136 центрами Европы убедительно показал, что при НХЛ низкой степени злокачественности использование его должно стать стандартным методом поддерживающей терапии; результаты применения достоверно лучше при использовании препарата на фоне ПР; доза альфа-IFN в поддерживающем режиме не должна быть меньше 9 млн.МЕ в неделю при трехкратном введении (результаты ухудшаются в 2 раза при снижении суммарной недельной дозы); длительность лечения должна быть не менее 18 мес. Соблюдение этих принципов улучшает 5-летнюю выживаемость на 20% (70% против 50% без поддерживающей терапии альфа, IFN).

Алгоритм лечения агрессивных форм НХЛ

Более сложны и требуют дифференцированного подхода в зависимости от морфологического варианта и клинического течения принципы лечения агрессивных

В-клеточных НХЛ, не включающие лимфому из клеток мантийной зоны, которая в отличие от остальных крайне агрессивна по течению (медиана выживаемости всего в пределах от 3 до 5 лет, считается инкурабельной и требует особого подхода к лечению).

Стандартом лечения большинства В-клеточных агрессивных лимфом можно считать комбинированную химиотерапию по известной программе CHOP в виде 6–8 циклов с проведением 2 циклов после достижения полной ремиссии при 3-х недельных интервалах.

Подобный стандарт содержится в «Минимальных клинических рекомендациях Европейского общества медицинской онкологии» 2003 г. с указанием, что в I и II стадиях В-крупноклеточных НХЛ допустимо проведение лучевой терапии после 3–4 циклов CHOP, в том числе в модифицированном 2-недельном варианте. Действительно, повышение эффективности программы CHOP (до 75–86% полных ремиссий) может быть достигнуто сокращением интервала между циклами до 2 недель, но с обязательной поддержкой проведения колониестимулирующими факторами G-CSF

или GM-CSF в дни, свободные от химиотерапии.

Определенные надежды на улучшение результатов лечения этого, не вписывающегося в общие принципы терапии агрессивных НХЛ варианта опухоли, создают попытки применения с самого начала высокодозных режимов комбинированной химиотерапии с пересадкой стволовых клеток, ауто и аллогенной трансплантацией костного мозга или без этих процедур, но с дополнением иммунотерапией ритуксимабом и полихимиотерапией по программе «Hyper-CVAD»1 с гиперфракциями циклофосфана, доксорубина, винкристина и большими дозами цитарабина и метотрексата].

Выработка общих принципов лечения Т-клеточных лимфом встречает гораздо большие трудности, чем при В-клеточных в связи с разнообразием морфологических, клинических, в том числе экстранодальных вариантов, а также гетерогенности последних в пределах одной органной локализации, как, например, при Т-клеточных первичных кожных лимфомах, относящихся, в основном, к индолентным. Практически, задачи лечения индолентных Т-клеточных лимфом, кроме весьма редкого Т-клеточного хронического лимфолейкоза/Т-клеточного пролимфоцитарного лейкоза, заключаются в терапии первичных кожных НХЛ и, прежде всего, грибовидного микоза или его варианта – синдрома Сезари (Armitage J.O. e.a.1998).

При ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфоме (ангиоиммунобластной лимфоаденопатии) определенный ответ (около 30% полных ремиссий) может быть получен уже при одной кортикостероидной терапии, иногда с альфа, интерфероном. Однако этот ответ почти в 2 раза ниже, чем при комбинированной химиотерапии – предпочтительно известной программе COP, BLAM в сочетании с этопозидом. Высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток или костного мозга в лечении упомянутых 2 подтипов Т-клеточных лимфом в качестве первичного лечения, как и анапластической Т-крупноклеточной НХЛ, высокочувствительной к стандартной (как и при агрессивных В-клеточных лимфомах) и кортикостероидам, применима, главным образом, только при экстранодальных формах. В отличие от показаний к применению альфа, интерферона при индолентных Т-клеточных лимфомах, в особенности первичных кожных, когда в результате могут быть получены (без химиотерапии) от 30% до 85% ремиссий, использование этого цитокина в монотерапии при агрессивных Т-клеточных НХЛ, в том числе в сочетании с химиотерапией, не дает эффекта.

Лучевая терапия при агрессивных Т-клеточных лимфомах играет вспомогательную роль, в первую очередь при локализованных поражениях, когда облучению могут подвергаться не полностью регрессировавшие в результате химиотерапии очаги большого объема или первичные экстранодальные поражения (кожа, желудок, яичко, ЦНС).

Принципы лечения высокоагрессивных В-клеточных НХЛ относятся к лимфоме Беркитта и Т-клеточных – к лимфобластной. При лимфобластной НХЛ адекватной

представляется терапия, используемая при остром лимфобластном лейкозе, стандартная для агрессивных В-клеточных лимфом комбинированная химиотерапия по программе CHOP или CHOP+аспарагиназа с профилактикой поражения ЦНС (интратекальное введение метотрексата и цитарабина). При этом самым главным представляется в начале индукция, затем консолидация ремиссии и длительная поддерживающая терапия.

Методом выбора лечения лимфомы Беркитта независимо от стадии или локализации поражений является комбинированная химиотерапия, проводимая по алгоритмам для острого лимфолейкоза с профилактикой поражений ЦНС (без облучения головного мозга), как и при лимфобластной Т-клеточной лимфоме. Комбинированная химиотерапия

(одинаковая, в принципе, для детей и взрослых) включает циклофосфан, иногда в альтернирующем режиме с ифосфамидом или в сочетании с высокодозным метотрексатом, антрациклинами, винкристином, препаратами из группы эпиподофиллотоксинов (VM,26) и цитарабином (с интратекальным введением метотрексата и цитарабина), как это предусматривает так называемый Berlin, Frankfurt, Munster протокол 86, дает оптимальные результаты. В некоторых случаях лечебная тактика ограничивается химиотерапией высокими дозами циклофосфана от 1 г/м² до 3–8 г/м² или умеренными дозами метотрексата (системно и интратекально – в последнем случае в сочетании с цитарабином). Поддержка высокодозной химиотерапии аутоотрансплантацией костного мозга или препаратами колониестимулирующих факторов приносит в данном случае в равной степени разочаровывающие результаты.

Весьма сомнительно, что лучевая терапия при оптимальной комбинированной химиотерапии в случаях интрацеребральных поражений и вовлечения яичка улучшают результаты лечения, также, как и попытки паллиативных резекций больших опухолевых масс, что откладывает обычно срочное начало химиотерапии.

Рецидивы после достижения полной ремиссии являются практически неизбежным следствием адекватного лечения (химиотерапии) всех вариантов индолентных, агрессивных и высокоагрессивных НХЛ. При этом продолжительность безрецидивного периода варьирует от нескольких месяцев до лет в зависимости от степени злокачественности НХЛ и наличия неблагоприятных прогностических факторов, в том числе показателей МПИ. К ранним рецидивам, характеризующим неблагоприятное течение процесса.

Заключение

Несмотря на достижения современной противоопухолевой терапии (химиолучевой), проблема повышения эффективности лечения больных неходжкинскими лимфомами остается крайне актуальной. Некоторые варианты

заболевания, несмотря на интенсивное лечение до сих пор остаются фатальными, однако внедрение в практику новых таргетных и химиопрепаратов, позволяет улучшить результаты лечения пациентов с НХЛ.

Наряду с этим возникает проблема выбора оптимального режима ПХТ с учетом морфоиммунологических особенностей, прогностических факторов и рефрактерности опухолей.

В связи с этим мы в своей лекции постарались осветить все вопросы, касающиеся диагностики и лечения НХЛ.

Список использованной литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сетказина Г.Д., Махатаева А.Ж и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2010 год.
2. Клинические рекомендации ESMO по диагностике, лечению и наблюдению при первично-диагностированной крупноклеточной неходжкинской лимфоме//Минимальные клинические рекомендации Европейского общества медицинской онкологии (ESMO)/Ред. русского перевода С.А.Тюлядин, Н.И.Переводчикова, Д.А.Носов. – М.: РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, 2003. – С.25,27.
3. Короленко В.О., Гершанович М.Л., Тихонова В.В. Трехлетние результаты применения препарата мабтера (ритуксимаб) в лечении индолентных неходжкинских лимфом, резистентных к стандартной химиотерапии // Вопр. онкол.-2004. – Т.50, №4. – С.421-425.
4. Поддубная И.В. Неходжкинские лимфомы//Клиническая гематология: Руководство для врачей: Глава 23 / Под ред. М.А.Волковой. – М: Медицина, 2001. – С.336-375.
5. Поддубная И.В. Обоснование лечебной тактики при неходжкинских лимфомах // Современ. онкол. – 2002. – Т.4, №1. – С.3-7.
6. Поддубная И.В., Османов Д.Ш., Пробатова Н.А. и др. Новые возможности в терапии зрелоклеточных неходжкинских лимфом: препарат «Мабтера» – настоящее и будущее // Современ. онкол. – 2001. – Т.3, №2. – С.57-60.
7. Armitage J.O. Peripheral T-cell Lymphoma //The Lymphomas / Ed. by J.P.Canellas, T.A.Lister, J.L.Siclar. – Philadelphia, London etc.: W.B.Saunders Company, 1998. – P.439-448.

Биологические особенности отечно-инфильтративных форм рака молочной железы

Чичуа Н.А., Есентаева С.Е., Хамидуллина Г.А., Смагулова К.К.,

Абдрахманов Р.З., Мусаханова Ж.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии г.Алматы

УДК: 618.19-006.6:000.57

Отечно-инфильтративная форма рака (ОИФ) является одним из разновидностей местнораспространенного рака молочной железы (РМЖ). По данным Liau S.L. et al. (2004) и Panades M. et al. (2005) эта форма составляет около 6% от всех случаев рака молочной железы и характеризуется неблагоприятным прогнозом: быстрым, агрессивным течением и высоким метастатическим потенциалом. На момент установления диагноза у большинства больных обнаруживаются лимфоузлы регионарных зон и примерно у 30% - отдаленные метастазы (Honkoop A.H. et al., 1998, Kuerer H.M. et al., 1999).

Различают 2 типа ОИФ РМЖ: первичный и вторичный. Первичный тип характеризуется диффузной инфильтрацией всей молочной железы. Такая молочная железа быстро прогрессирует (до 2-3 месяцев), клинически - диффузно уплотнена, в 95% определяются увеличенные лимфоузлы регионарных зон, кожа гиперемирована и на маммограммах отсутствует истинный опухолевый узел.

Для пациенток с вторичным типом ОИФ РМЖ характерно более длительное развитие болезни (более 3 месяцев). Отек и инфильтрация кожи в молочной железе появляются позже обнаружения узлового образования в ней. В таких случаях на маммограммах определяется наличие узла, вокруг которого формируется отек и инфильтрация ткани.

Для больных ОИФРМЖ не характерно наличие какой-либо определенной гистологической формы опухоли. Опухоль молочной железы может быть представлена инфильтрирующим протоковым, дольковым, медуллярным, слизистым или другой гистологической формой рака. Однако большая часть больных ОИФРМЖ имеют высокую степень злокачественности опухоли в отличие от других форм РМЖ [5].

В последнее время в литературе возрастающее внимание уделяется биологическим и молекулярным характеристикам опухоли, в том числе рака молочной железы. Изучение молекулярных особенностей ОИФРМЖ могут оказать помощь как в диагностике этой формы, так и в разработке новых противоопухолевых препаратов и схем лечения.

При ОИФРМЖ чаще выявляется высокая фракция клеток S-фазы (SPF), высокий уровень PCNA (ядерный антиген пролиферирующей клетки), отсутствие экспрессии рецепторов эстрогена и/или прогестерона (РЭ/РП отрицательный статус), высокая степень злокачественности опухоли и гиперэкспрессия и мутация p53 белка [6]. В других исследованиях было показано, что ОИФРМЖ является высоко лимфогенной и ангиогенной опухолью. McCarthy N.J. и коллеги (2002г) выявили значительное увеличение внутриопухолевой микрососудистой плотности при ОИФРМЖ [7].

Несмотря на небольшие различия, у больных ОИФРМЖ при исследованиях ИГХ-методом отмечается гиперэкспрессия белков HER2-neu, EGFR и p53 [8,9]. Амплификация HER2-neu и p53 генов впоследствии была подтверждена с помощью microarrays-технологии анализа ДНК этих генов [10].

42 пациенткам с отечно-инфильтративными формами рака молочной железы (ОИФРМЖ) до начала лечения были проведены ИГХ исследования. ОИФРМЖ в 58,4% случаев характеризовались высокой степенью злокачественности - G3, инвазией сосудов - в 69%, высокой пролиферативной активностью - в 66,7% и преобладанием, в 71,4%, агрессивных форм заболевания по фенотипическому признаку: тройной негативный рак (28,6%) и опухоли с гиперэкспрессией Her-2/neu - 47,6%, среди которых люминальный. В тип рака зарегистрирован в 12 (28,6%) и Her2-позитивный - в 8 (19,0%) случаях. На долю люминального A типа опухоли приходится лишь 23,8%. Выявлена корреляционная зависимость степени злокачественности с фенотипом рака и пролиферативной активностью опухоли. Для наиболее агрессивных форм рака, а именно тройного негативного и Her-позитивного, на долю которых приходится около половины больных ОИФРМЖ (47,6%), характерна высокая пролиферативная активность опухоли - в 85,0% и гиперэкспрессия белка p53 - в 70,0%.

Biological features of edematous-infiltrative forms of breast cancer

Chichua N.A.

Immunohistochemical studies were provided 42 patients with edematous-infiltrative breast cancer before treatment. The high degree of malignancy was observed in 58,4% of cases, vascular invasion 69%, high proliferative activity of 66,7%, aggressive forms of phenotypic signs were 71,4%: 28,6% triple-negative and overexpression her2neu 47,6%. Luminal B type were in 28,6%, luminal A type were in 23,8%. Correlation of malignance degree was found with phenotype of cancer and proliferative activity. For the most aggressive form of cancer, triple negative and positive her2neu, which accounts for about half of patients with edematous-infiltrative cancer of breast (47,6%), characterized by high proliferative activity of tumor cells (85%) and overexpression of p53 protein (70%).

Таким образом, проведенные исследования показали, что ОИФРМЖ чаще является высоко злокачественной опухолью, отрицательной по рецепторному статусу, быстро пролиферирующей и гиперэкспрессирующей HER2-neu, EGFR и p53.

Лечение больных ОИФРМЖ является трудной задачей в связи с высокой злокачественностью опухоли, следствием которой являются как бурное местное развитие процесса, так и быстрая диссеминация. Лечение больных отечной формой рака молочной железы на ранних этапах развития онкологии, когда применялось только хирургический и лучевой метод, считалось мало перспективным. 5-летняя выживаемость редко достигала 5%. В последствии с

улучшением методов диагностики, лучевой терапии и, особенно, после совершенствования противоопухолевой лекарственной терапии удалось улучшить отдаленные результаты лечения больных ОИФРМЖ. Однако у некоторых врачей сохраняется пессимистический взгляд на перспективы лечения и прогноз у больных этой особой формой рака молочной железы. Разноречивы взгляды на необходимость проведения хирургического этапа в радикальном лечении местно распространенного ОИФРМЖ. Ряд авторов считает для этой категории больных необходимым проведение только консервативного лечения. Многие авторы подчеркивают необходимость срочного начала лечения при наличии клинических и гистологических данных ОИФРМЖ [11, 12]

Использование химиотерапии в лечение агрессивного отечного рака молочной железы позволяет влиять как на первичную опухоль, так и на субклинические очаги опухоли. В настоящее время используют комбинации химиопрепаратов с различным механизмом действия, что потенцирует противоопухолевый эффект и уменьшает риск развития лекарственной резистентности.

Несмотря на значительные успехи в развитии химиотерапии анализ литературы, посвященный лечению ОИФРМЖ, свидетельствует о низкой возможности получения длительных ремиссий с помощью одного или двух методов лечения, требуется использовать многоступенчатый подход с применением всех новых современных методов лечения. Однако до последнего времени нет единого мнения о целесообразности применения всех 3 основных методов лечения рака молочной железы – хирургического, лучевого и лекарственного. Наилучшие результаты получены при проведении комплексного лечения с включением неoadъювантной химиотерапии и при достижении положительного эффекта от этого лечения. До сих пор существуют разногласия по проведению локального лечения данных больных. Традиционно в связи с плохим прогнозом многие специалисты считают ОИФРМЖ не хирургическим заболеванием. Но с улучшением выживаемости после использования современных методик полихимиотерапии, роль хирургического этапа лечения была пересмотрена. Результаты, полученные различными авторами, оказались противоречивыми: в некоторых исследованиях было показано преимущество включения в лечение хирургического этапа, при других – это преимущество не было отмечено [13, 14].

Материалы и результаты исследования. Одной из задач нашего исследования была идентификация гистологических и ИГХ результатов ОИФРМЖ. С этой целью 42 пациентам с ОИФРМЖ до начала лечения были проведены ИГХ исследования по материалам трепан-биопсии.

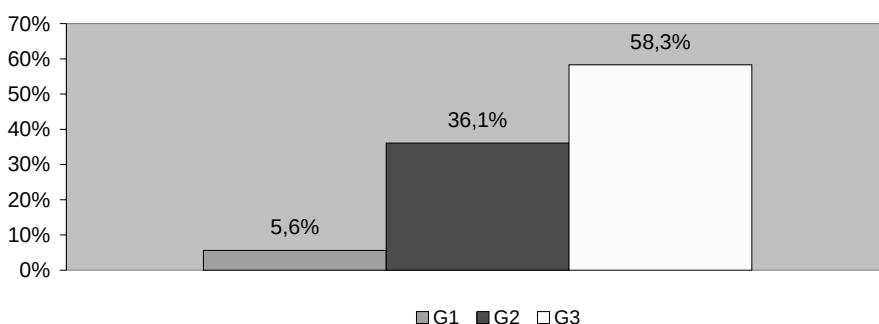
Анализ результатов гистологических исследований показал, что в большинстве случаев у больных ОИФРМЖ встречался инвазивный протоковый рак, на его долю пришлось 85,7% (36/42) случаев. У 2 (4,8%) пациенток был выявлен перстневидноклеточный рак, и по одному случаю диагностировались такие карциномы, как дольковая, воспалительная, тубулярная и медулярная (таблица 1).

Таблица 1 - Гистологические типы отечно-инфильтративного РМЖ

Гистологические типы опухоли	Частота встречаемости
Инвазивный протоковый рак	36 (85,7±5,4) %
Перстневидноклеточный рак	2 (4,8±3,3)%

Дольковый рак	1 (2,4±2,4)%
Воспалительный рак	1 (2,4±2,4)%
Тубулярный рак	1 (2,4±2,4)%
Медулярный рак	1 (2,4±2,4)%

У больных с редкими формами РМЖ определить степень гистологической злокачественности не представлялось возможным. Необходимо подчеркнуть, что 6 случаев с редкими гистологическими формами РМЖ, при которых определение злокачественности опухоли не представлялось возможным, встречались при следующих фенотипах рака: перстневидный рак был выявлен при тройном негативном и Her-позитивном типах, медулярный и воспалительный рак при тройном негативном, дольковый – у больной с гиперэкспрессией Her-2/neu, и тубулярный – при люминальном типе А.



Из 36 случаев инвазивного протокового рака у пациенток с ОИФРМЖ только у 2 (5,6±3,5)% опухоль соответствовала низкой степени злокачественности G1, в 13 (36,1±7,4)% случаях – G2, т.е. умеренной степени злокачественности. В большинстве случаев (58,3±7,6)% имел место рак с высокой гистологической степенью злокачественности G3 (рисунок 1).

Для получения более полной гистологической характеристики опухоли при ОИФРМЖ нами был проанализирован такой показатель, как опухолевая инвазия сосудов, которая может рассматриваться в качестве косвенного прогностического фактора течения заболевания. В настоящем исследовании этот показатель у больных ОИФРМЖ встречался в 29 (69,0±7,1)% случаях.

Анализ результатов ИГХ исследований рецепторного статуса опухоли показал, что среди первичных больных с ОИФРМЖ распределение по фенотипам рака было следующим: люминальный тип А встречался в 23,8±6,6% (10/42), люминальный тип В и тройной негативный рак с одинаковой частотой – в 28,6±7,0% (12/42) и Her-позитивный в 19,0±6,1% (8/42) случаев (рисунок 2).

Очевидно, что четыре рассматриваемых типа РМЖ встречались примерно в равных пропорциях, между тем на долю относительно благоприятного в прогностическом плане люминального А рака приходится только четверть больных (23,8%), оставшиеся ¾ пациентов, включенных в исследование, характеризуются более агрессивными формами заболевания.

Более подробный анализ рецепторного статуса показал, что среди 22 (52,4%) больных с люминальным типом РМЖ, к которому относятся опухоли с положительными рецепторами стероидных гормонов, только в 6 (27,3%) случаях опухоль характеризовалась положительным статусом по двум видам стероидных рецепторов (РЭ +), РП (+), у 16 (72,7%) больных – только один из рецепторов был положительным, при этом у 9 (40,9%) из них встречалась комбинация РЭ (+), РП (-), а у 7 (31,8%) – РЭ (-), РП (+).

При этом среди 9 больных с (РЭ+)/(ПР-) – статусом, в 2 случаях имела место отрицательная экспрессия Her-2/neu, у остальных 7 пациенток наблюдалась гиперэкспрессия рецептора фактора роста (таблица 2).

Судя по данным, представленным в таблице 2, мы можем предполагать, что только в 4 (9,5%) случаях ОИФРМЖ с (РЭ+), РП(+), Her2 (-) – статусом имеется благоприятный прогноз в плане течения заболевания.

Но для получения более полной картины необходимы дополнительные данные. Поэтому мы сопоставили полученные результаты гистологического и ИГХ исследований, а именно степень злокачественности и фенотип опухоли. Получены были следующие результаты: если у больных с люминальным типом опухоли степень злокачественности чаще оценивалась G1-G2, то при тройном негативном и Her-позитивном раках этот показатель оценивался как G3 (коэффициент корреляции $r=0,579$; $P<0,001$) (таблица 3).

Таблица 2 - Оценка рецепторного статуса ОИФРМЖ по данным иммуногистохимических исследований

Фенотип опухоли	Количество больных
Люминальный тип А	10 (23,8±6,6)%
РЭ(+), РП(+), Her2 (-)	4 (9,5±4,5)%
РЭ (+), РП(-), Her2 (-)	2 (4,8±3,3)%
РЭ (-), РП(+), Her2 (-)	4 (9,5±4,5)%
Люминальный тип В	12 (28,6±7,0)%
РЭ (+), РП(+), Her2 (+)	2 (4,8±3,3)%
РЭ (+), РП(-), Her2 (+)	7 (16,7±5,8)%
РЭ (-), РП(+), Her2 (+)	3 (7,1±4,0)%
Тройной негативный рак РЭ (-), РП(-), Her2 (-)	12 (28,6±7,0)%
Her-позитивный РЭ (-), РП(-), Her2 (+)	8 (19,0±6,1)%
Итого	42 (100%)

Таблица 3 - Изучение зависимости степени гистологической злокачественности и фенотипа опухоли у больных ОИРМЖ

Фенотип рака	Степень гистологической злокачественности по Элтон-Элису		
	G1	G2	G3
Люминальный А (n=9)	2 (22,2±13,8)%	6 (66,7±15,7)%	1 (11,1±10,5)%
Люминальный В (n=12)	-	4 (33,3±13,6)%	8 (66,7±13,6)%
Тройной негативн. (n=9)	-	1 (11,1±10,5)%	8 (88,9±10,5)%
Her-позитивный (n=6)	-	2 (33,3±19,2)%	4 (66,7±19,2)%

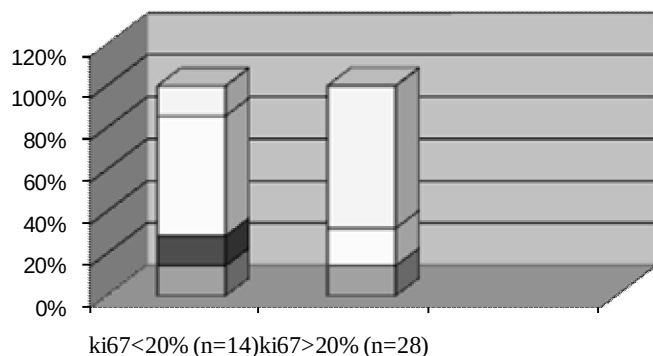


Рисунок 3 - Распределение больных ОИФРМЖ в зависимости от уровня пролиферативной активности и степени гистологической злокачественности

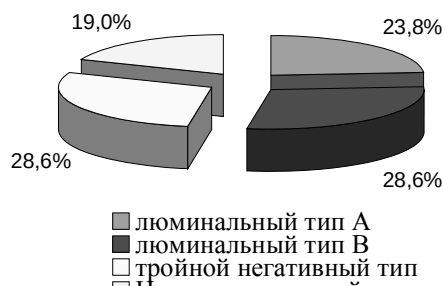


Рисунок 2- Распределение больных ОИФРМЖ по фенотипу опухоли

ИТОГО – n=36	2 (5,6±3,5)%	13 (36,1±7,4)%	21 (58,3±7,6)%
--------------	--------------	----------------	----------------

Для получения еще более полной картины нами были изучены молекулярно-биологические показатели пролиферации и апоптоза: экспрессия белка p53 и ki67.

Анализ результатов ИГХ исследований показал, что при ОИФРМЖ частота гиперэкспрессии белка p53 встречалась примерно у половины больных (47,6%), в то время как высокие показатели пролиферативной активности опухолевых клеток (ki67 больше 20%) были выявлены в 28 (66,7%) случаях.

При сопоставлении гистологической степени злокачественности с уровнем показателя пролиферации была получена высокая корреляционная связь: у больных с высокой пролиферативной активностью (ki67 больше 20%) в большинстве случаев, 67,9%, опухоль характеризовалась высокой степенью злокачественности, в то время как низкая экспрессия ki67 (менее 20%) встречалась у пациенток с умеренной и низкой степенью злокачественности, коэффициент корреляции $r=0,729$; $P<0,001$ (рисунок 3).

Сопоставление таких показателей как пролиферативная активность и экспрессия белка p53 у больных ОИРМЖ показало, что при высокой пролиферации ki67>20%, только у 39,3% (11/28) больных была выявлена высокая экспрессия белка p53, в остальных случаях она оценивалась, как низкая. В тоже время, низкая пролиферативная активность опухоли, имевшая место в 14 (33,3%) случаях, в 64,3% (9/14) сочеталась с гиперэкспрессией p53. Корреляционный анализ этих показателей не выявил между ними связи ($r=0,000191$).

Следующим этапом нашего исследования было изучение возможной зависимости между всеми, описанными выше ИГХ показателями. Мы постарались создать ИГХ-портрет различных фенотипов опухоли у больных ОИФРМЖ.

Для больных ОИФРМЖ с фенотипом А, число которых в настоящем исследовании составляет 10 (23,8%)

человек, были определены следующие характерные особенности: в 6 (60,0%) случаях опухоль отличалась низкой пролиферативной активностью (ki67 больше 20%), у этих пациенток степень злокачественности оценивалась как G1 в 2-х, G2 – в 4 случаях. Высокая пролиферация опухоли была выявлена в 4 (40,0%) случаях и соответствовала умеренной степени злокачественности (G2) у 2 больных и G3 у 1 пациентки, в 1 случае степень злокачественности была не определена. Гиперэкспрессия белка p53 наблюдалась у 2 (20%) больных с низкой пролиферативной активностью.

Для больных с люминальным типом В было установлено, что 7 (58,3%) из 12

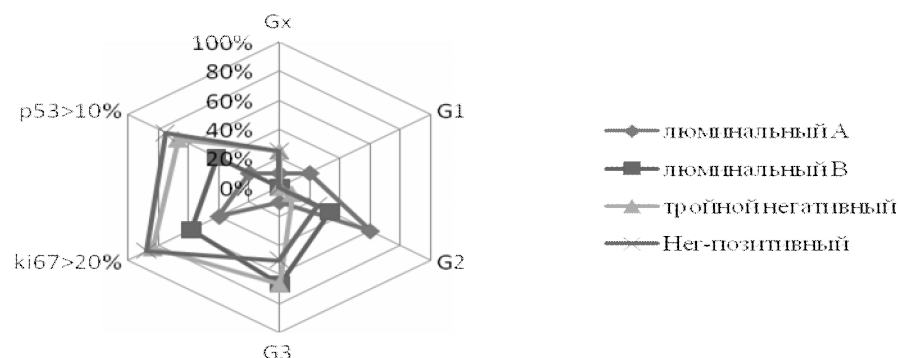


Рисунок 4 – Основные молекулярно-биологические характеристики ОИФРМЖ

опухолей характеризовались высоким пролиферативным индексом (ki67 больше 20%), что сочеталось с высокой степенью злокачественности G3. У 5 (41,7%) пациенток низкие показатели пролиферации (ki67 меньше 20%) соответствовали в 4 (33,3%) случаях степени злокачественности G2 и в 1 (8,3%) – G3. Гиперэкспрессия p53 при данном фенотипе была выявлена в 4 (33,7%) случаях, и в 1 (8,3%) сочеталась с высокой пролиферативной активностью и степенью злокачественности G3.

Тройной негативный РМЖ отличался тем, что для подавляющего числа опухолей, 83,3% (10/12), была характерна высокая пролиферация в 8 (80,0%) случаях сочетавшаяся с высокой степенью злокачественности G3, а в 2 (20,0%) – с Gx при перстневидноклеточном и воспалительном раках. В 1 (8,3%) случае низкий пролиферативный показатель (ki67 больше 20%) соответствовал умеренной степени злокачественности G2, а в другом (8,3%) – медулярному раку (Gx). Чаще, чем при других фенотипах наблюдалась гиперэкспрессия белка p53 – 66,7% (8/12), при этом в 6 (50,0%) случаях - в сочетании с высокой пролиферацией опухолевых клеток.

Нег-позитивный рак, как известно, относится к агрессивным и прогностически неблагоприятным формам РМЖ. Анализ полученных результатов ИГХ исследований показал, что для данной формы РМЖ так же характерен высокий показатель пролиферативной активности (ki67 больше 20%), который встречался в 87,5% (7/8) случаев у больных с высокой степенью злокачественности и низкодифференцированным перстневидноклеточным раком. Только у 1 (12,5%) пациентки уровень ki67 был меньше 20%. Высокая экспрессия белка p53, имевшая место в 6 (75,0%) случаях, в 5 (62,5%) наблюдалась при высокой пролиферации, и только в 1 (12,5%) – при ki67 меньше 20%.

Таким образом, если для опухолей с тройным негативным и Нег-позитивным статусом были характерны показатели высокой экспрессии ki67, мутантного белка p53 и высокая степень злокачественности G3, то при люминальном раке встречались опухоли с умеренной и низкой степенью злокачественности (G1, G2) и низкими показателями экспрессии изучаемых маркеров, ki67 и p53. Можно сказать, что морфологические и иммуногистохимические показатели тройного негативного и Нег-позитивного РМЖ практически идентичны и резко отличаются от аналогичных показателей у больных с люминальным А типом опухоли. В то время как молекулярные маркеры люминального В типа ОИФРМЖ занимают «промежуточное» положение (рисунок 4).

Таким образом, занимая особое положение, ОИФРМЖ в большинстве случаев характеризуется неблагоприятными прогностическими факторами, а именно высокой степенью злокачественности, G3, в 58,4% случаев, инвазией сосудов в 69%, высокой пролиферативной активностью (66,7%) и преобладанием, в 71,4%, агрессивных форм заболевания по фенотипическому признаку: тройной не-

гативный рак (28,6%) и опухоли с гиперэкспрессией Her-2/neu – 47,6%, среди которых люминальный В тип рака зарегистрирован в 12 (28,6%) и Her2-позитивный - в 8 (19,0%) случаях. На долю люминального А типа опухоли приходится только 23,8%. Выявлена корреляционная зависимость степени злокачественности с фенотипом рака и пролиферативной активностью опухоли. Для наиболее агрессивных форм рака, а именно тройного негативного и Нег-

позитивного, на долю которых приходится около половины больных ОИФРМЖ (47,6%), характерна высокая пролиферативная активность опухоли в 85,0% и гиперэкспрессия белка p53 в 70,0%.

Список использованной литературы

1. Liauw S.L., Benda R.K., Morris C.G. Inflammatory breast carcinoma. Outcomes with trimodality therapy for nonmetastatic disease // *Cancer*. - 2004. - Vol. 23. - P.920-928.
2. Panades M., Olivotto I.A. Evolving treatment strategies for Inflammatory breast cancer: a population-based survival analysis // *J. Clin. Oncol.* - 2005. - Vol.23. - P.1941-1950.
3. Honkoop A.H., van Diest P.J., de Jong J.S. Prognostic role of clinical, pathological and biological characteristic in patients with locally advanced breast cancer // *Br. J. Cancer*. - 1998. - Vol. 77. - P. 621-626.
4. Kuerer H.M., Newman L.A., Smith T.L. Clinical course of breast cancer patients with complete pathologic primary tumor and axillary lymph node response to doxorubicin-based neoadjuvant chemotherapy // *J. Clin. Oncol.* - 1999. - Vol. 17. - P.460-469.
5. Wingo P.A., Patricia M.J., Young J.L., Gargiullo P. Population-based statistics for woman diagnosed with inflammatory breast cancer (United States) // *Cancer Causes and Control*. - 2004. - N 15. - P.321-328.
6. McCarthy N.J., Yang X., Linnoila I.R. et al. Microvessel density, expression of estrogen receptor alpha, MIB-1, p53, and c-erbB-2 in inflammatory breast cancer // *Clin Cancer Res*. - 2002. - Vol. 8. - P.3857-3862.
7. Colpaert C.G., Vermeulen P.B., Benoy I. et al. Inflammatory breast cancer shows angiogenesis with high endothelial proliferation rate and strong E-cadherin expression // *Br. J. Cancer*. - 2003. - Vol. 88. - P.718-725.
8. Turpin E., Bieche I., Passa L.F. et al. Increased incidence of ERBB2 overexpression and TP53 mutation in inflammatory breast cancer // *Oncogene*. - 2002. - Vol.21. - P.7593-7597.
9. Sawaki M., Ito Y., Akiyama F. et al. High prevalence of Her-2/neu and p53 overexpression in inflammatory breast cancer // *Breast Cancer*. - 2006. - Vol.13, № 2. - P.172-178.
10. Van den Eynden G.G., Van der Auwera I., Van Laere S. et al. Validation of a tissue microarray to study differential protein expression in inflammatory and non-inflammatory breast cancer // *Breast Cancer Res Treat*. - 2004. - Vol. 85. - P.13-22.
11. Дабаева В.О., Бадмаева Г.С. Эффективность различных методов лечения больных с отечно-инфильтративными формами рака молочной железы в Республиканском онкодиспансере за 5 лет в период с 1993-1997гг. // *Актуальные проблемы клинической онкологии*. - Улан-уде, 1999. - С.212-213.
12. Чхиквадзе Т.В. Отёчный рак молочной железы, особенности клинического течения, проблемы диагностики и лечения.
13. De Boer R.H., Allum W.H., Ebbs S.R. et al. Multimodality therapy in inflammatory breast cancer: is there a place for surgery? // *Ann Oncol*. - 2000. - Vol. 11, № 9. - P.1147-1153.
14. Panades M., Olivotto I.A., Speers C.H. et al. Evolving treatment strategies for inflammatory breast cancer: A population based survival analysis // *J. Clin. Oncol.* - 2005. - Vol.23, № 9. - P.1941-1950.

Рак легкого в географическом регионе «Нахичевань» Азербайджана

Солтанов А.А.

Национальный центр онкологии МЗ Азербайджанской Республики
(генеральный директор - академик РАМН РФ и НАНА Д.А.Алиев)

Рак легкого - наиболее распространенное по всему миру онкологическое заболевание [7,9], но распределение географически неоднородно [2,3]. Показатели заболеваемости рака легкого резко меняются между различными областями мира. Самые высокие показатели заболеваемости рака легкого у мужчин отмечены в Европе, особенно в центральной и Восточной Европе, и в северной Америке. В пределах Европы самые высокие мужские показатели заболеваемости отмечены в Венгрии и Польши, а самые низкие в Швеции и Мальте [4].

Отношение встречаемости рака легкого в двух отдельных регионах мира может составлять более 4 среди мужчин, и 5 среди женщин [8]. Из-за различий в регистрации онкологических заболеваний между странами, необходима предосторожность в интерпретации этих данных. Однако заметная разница не может быть объяснена низким уровнем диагностического обследования и профилактики.

Рак легкого в большинстве случаев характерен для развитых стран, а точнее для Северной Америки и Европы, и редко встречается в развивающихся странах, а именно в Африке и Южной Америке [5]. Имеется географическая изменчивость в тенденциях показателей заболеваемости и смертности рака легкого для мужчин и женщин. Более высокие показатели и более медленные снижения были замечены на Юге и Среднем Западе Америки. Среди мужчин показатель смертности рака легкого уменьшился в 43 из 50 государств и в округах Колумбии с 1996 по 2005, тогда как среди женщин, показатель смертности рака легкого уменьшился только в трех, и увеличился в 13 штатах [6].

Некоторые американские исследования [1] отмечают, что выбор методики проводимого исследования влияет на их конечные результаты. Анализ работ в различных штатах США выявил отсутствие зависимости частоты и формы злокачественных заболеваний от географии, социально-экономического статуса, этнической и половой принадлежности. Однако специалисты отмечают, что ведущим этиологическим фактором для злокачественных заболеваний легких является загрязнение атмосферного воздуха [10].

Изучение вопросов географии рака легких нельзя считать полностью законченными, и исследования в этом направлении оправданы. В связи, с чем изучена особенности рака легкого в отдельных 5 регионах республики, из которых «Нахичевань» является автономной республики Азербайджана (Нахичеванская АР) и расположено отдельно от основной территории Азербайджана, на границе с Турцией, Ираном и Арменией. Резко континентальный климат и сложный рельеф создают трудности для развития сельского хозяйства. Основу промышленности составляет производство продуктов питания. Эта отрасль представлена предприятиями по разливу минеральных вод, вина, плодоовощных консервов, мясомолочных продуктов, мукомольной промышленностью, добычей соли.

Рак легкого в географическом регионе «Нахичевань» Азербайджана

А.А.Солтанов

Национальный центр онкологии МЗ Азербайджанской Республики

Рак легкого наиболее распространенное по всему миру онкологическое заболевание, но распределение географически неоднородно. Показатели заболеваемости рака легкого резко меняются между различными областями мира.

В связи, с чем изучена особенности рака легкого в отдельных регионах республики Азербайджан. Анализированы данные истории болезни 982 больных раком легкого. Выявлено, что в регионе «Нахичевань» большинство 59,5% больных были сельскими жителями. Рак легкого часто 83,7% диагностированы в возрастных группах 50-69 лет независимо от клинко-анатомического роста опухоли. Самым частым гистологическим типом в этом регионе независимо пола больных раком легкого оказался плоскоклеточный рак, который отмечен у 55,6% больных. У большинства 78% больных диагностируются поздние стадии рака легких. Показатели заболеваемости и общие коэффициенты смертности рака легкого в регионе «Нахичевань» были больше общереспубликанских цифр.

Lung cancer in geographical region of Azerbaijan – Nakhichevan.

A. Soltanov

National Center of Oncology, Ministry of Public Health, Baku, Azerbaijan

Lung cancer is the most spread cancer around the world but its geographical distribution is not homogeneous. The morbidity values are sharply changing between different regions.

We studied lung cancer spread along Azerbaijan Republic. 982 case reports were analyzed. It was revealed that in Nakhichevan region the majority of patients – 59,5% were villagers. In 83,7% cases patients were 50-69 years old independently on clinical and anatomical features of the tumor. The most frequent histological type was squamous cell cancer – at 55,6% patients, 78% had late stage lung cancer. Morbidity and overall mortality rates of lung cancer in the region “Nakhichevan” were higher than republican rates.

Материалы и методы

Материалами исследования явились данные истории болезни 982 больных обследованных по поводу рака легкого в Национальном Центре Онкологии (НЦО) и Бакинском городском онкологическом диспансере (ГОД) с 1995 по

2003 г.г. Из-за малого числа больных в двух регионах, были дополнительно включены в исследование больные, обследованные в 2004-2010г.г. этих регионов. Для сбора информации использован единый кодификатор, который включал в себе 41 признак включающих ряд социально – медицинских показателей. Больные были распределены по 5 регионам, согласно их месту жительства. Статистическую обработку полученных данных проводили с применением пакета программ *STATISTICA-6 Base* (Basic Statistical Analysis Methods) с использованием 2-Way table summary.

Для изучения показателей частоты заболеваемости, летальности и общие показатели смертности регионов был использован официальный статистический отчет Минздрава Азербайджанской Республики злокачественных новообразований за 2007 год. Официальный статистический отчет представлен Формой №7, которая утверждена указом № 43/5 от 27.11.2007 Государственным Комитетом Статистики Азербайджанской Республики. Учитывались количество первичных больных раком легкого, число населения и умершие от рака легкого в течение одного года за 2007 год.

Показатели заболеваемости, летальности и общий коэффициент смертности по отдельным регионам вычислены применяемыми формулами с помощью программы EXCELL и Windows на персональном компьютере.

Результаты и обсуждение

Из 982 больных раком легкого 656 (66,8%) были жителями региона «Большой Кавказ», 129 (13,1%) региона «Куринская межгорная низменность», 67 (6,8%) региона «Малый Кавказ», 93 (9,5%) региона «Ленкорань», остальные 37 (3,8%) изучаемого региона «Нахичевань». (Табл.№1).

Из 37 больных этого региона 31 (83,8%) были лица мужского пола, 6 (16,7%) лица женского пола. 15 (40,5% из 37) больных этого региона были жителями городов, 22 (59,5% из 37) больных сельскими жителями. У 8 (21,6% из 37) больных были в анамнезе контакт вредными веществами на производствах или на рабочих местах, 29 (78,4% из 37) отрицали таких факторов.

Из 37 больных 10 (27%) были служащими, 12 (32,4%) пенсионерами, 13 (35,1%) не работали. 1 (2,7%) был водителем. Из 37 больных раком легкого этого региона 5 (20,8%) работали в административно - управленческих работах.

В возрастной градации моложе 40 лет был 1 (2,7%) больной, 40-49 лет 4 (10,8) больных, 50-59 лет 13 (35,1%) больных, 60-69 лет 18 (48,67%) больных, старше 70 лет 1 (2,7%) больной. (Табл.№2).

Независимо место жительства, в обеих группах преобладали больные в возрастной градации 60-69 лет (среди городских жителей 46,7%, среди сельских 50% больных).

Большинство 27 (73%) больных раком легкого этого региона были курильщиками. 17 (63%) из них помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки. Только 10 (10,8%) больных отрицали вредные привычки в анамнезе как курения и употребления спиртных напитков. При анализе материала выявлено, что большинство 18 (48,6%) больных раком легкого с вредными привычками как курение и употребление спиртных напитков были сельскими жителями. (Таблица 3).

Как среди больных раком легкого городских жителей, так и сельских жителей большинство (соответственно: 60% и 81,8%) больных были курильщиками. Те, которые помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки,

Табл.№1. Распределение больных раком легкого по полу и регионам Республики.

Пол болн.	«Большой Кавказ»	«Куринская межгорная низменность»	«Малый Кавказ»	«Нахичевань»	«Ленкорань»	Итого
муж.	585	120	60	31	84	880
	59,6%	12,2%	6,1%	3,2%	8,5%	89,6%
жен.	71	9	7	6	9	102
	7,2%	0,9%	0,7%	0,6%	0,9%	10,4%
Итого	656	129	67	37	93	982
	66,8%	13,1%	6,8%	3,8%	9,5%	100%

Табл.№2. Распределение больных по административно – территориальным принадлежностям и по возрастным градациям

Регион «Нахичевань»		Моложе 40 лет	40-49 лет	50-59 лет	60-69 лет	Старше 70 лет	Итого
Город. жители	Абс.числа	-	2	6	7	-	15
	В %	-	13,3	40	46,7	-	40,5
Сельск. жители	Абс.числа	1	2	7	11	1	22
	В %	4,6	9,1	31,8	50	4,5	59,5
Итого	Абс.числа	1	4	13	18	1	37
	В %	2,7	10,8	35,1	48,6	2,7	100

Табл.№3. Распределение больных по административно – территориальным принадлежностям и по наличию вредных привычек

Регион «Нахичевань»		Курит	Одновременно употр. спиртных нап. и табака	Вредн. привычки отрицают	Итого
Город. жители	Абс.числа	3	6	6	15
	В %	20	40	40	40,5
Сельские жители	Абс.числа	7	11	4	22
	В %	31,8	50	18,2	59,5
Итого	Абс.числа	10	17	10	37
	В %	27	45	27	100

Табл.№4. Распределение больных по административно – территориальным принадлежностям и по клинко-анатомическим формам роста опухоли

Р е г и о н «Нахичевань»		Централь ный рак	Перифери ческий рак	Атипичес кий рак	Итого
Город. жители	Абс.чис	9	6	-	15
	В %	60	40	-	40,5
Сельские жители	Абс.чис	14	6	2	22
	В %	63,6	27,3	9,1	59,5
Итого	Абс.чис	23	12	2	37
	В %	62,2	32,4	5,4	100

составили среди больных городских жителей 40%, среди сельских жителей 50%.

Центральный рак легких диагностирован у 23 (62,2%), периферический рак у 12 (32,4%), атипический рак у 2 (5,4%) больных этого региона. При сравнении групп больных раком легкого сельских и городских жителей выявлено, что в большинстве случаев диагностирован центральный рак легкого. Центральный рак диагностирован в 60% случаев среди городских жителей, 63,6% среди сельских больных (9 из 15 и 14 из 22 соответственно). Среди самих групп городских, и сельских больных периферический рак легких отмечено неодинаково часто. (Табл.№4).

Среди больных раком легкого этого региона у 8 (21,6%) диагностировано II стадия опухолевого процесса, у 19 (51,3%) III стадия и у 10 (27%) IV стадия опухолевого

процесса.

III стадия рака легкого диагностирована у 9 (60%) среди городских, у 10 (45,4%) среди сельских больных. IV стадия опухоли диагностированы одинаково часто как среди городских, так и среди сельских (у 4 (26,7%) среди городских, у 6 (27,3%) среди сельских) больных этого региона. (Табл.№5).

Табл.№5. Распределение больных по административно – территориальным принадлежностям и по стадиям опухолевого процесса.

Регион «Нахичевань»		II стадия	III стадия	IV стадия	Итого
Город. жители	Абс.числа	2	9	4	15
	В %	13,3	60	26,7	40,5
Сельские жители	Абс.числа	6	10	6	22
	В %	27,3	45,4	27,3	59,5
Итого	Абс.числа	8	19	10	37
	В %	21,6	51,3	27,1	100

Независимо места жительства большинство 19 (78,4%) больных обратились за медицинской помощью в специализированные онкологические учреждения в поздние III и IV стадии рака легкого этого региона, что делает необходимой повышения онкологической настороженности врачей общей лечебной сети.

Табл.№6. Распределение больных по административно – территориальным принадлежностям и по гистологическим типам опухолевого процесса.

Регион «Нахичевань»	П л о с к о - клет. рак	Аденокарцинома	Мелкоклет. рак	Др. виды	Итого
Город. жители	5	5	4	1	15
	33,3%	33,3%	26,7%	6,7%	41,7%
Сельские жители	15	1	1	4	21
	71,4%	4,8%	4,8%	19%	58,3%
Итого	20	6	5	5	36
	55,6%	16,7%	13,9%	13,9%	100%

У большинства 72,2% больных раком легкого этого региона была диагностирована плоскоклеточный рак и аденокарцинома легких. Как среди больных раком легкого городских жителей, так и среди больных сельских жителей плоскоклеточный рак отмечен часто. Среди больных раком легкого городских жителей у 5 (33,3%) установлен плоскоклеточный рак. Среди больных раком легкого сельских жителей плоскоклеточный рак был установлен у 15 (71,4%), недифференцированный рак, объединенный в группу «другие виды рака» у 4 (19%) больных. Так среди больных плоскоклеточным раком 25% были городские жители, остальные 75% сельские жители. Считаем, что, как и в других регионах, так и в этом регионе часто встречаемая гистологическая форма остается плоскоклеточный рак легкого. (Табл.№6).

Также были изучены показатели заболеваемости, летальности и смертности рака легкого по регионам республики. За 2007 год в этом регионе количество первичных больных раком легкого, которые состояли на учет, были 43, умершие в течение одного года 16, число умерших во

время отчета составило 34. Число населения за этот год составило 374632. Показатель заболеваемости для региона «Нахичевань» был больше общереспубликанских цифр, и составил 10,9 на 100 тыс. населения. Общий показатель летальности региона «Нахичевань» был низким общереспубликанских цифр и составил 39%. Общий коэффициент смертности для региона «Нахичевань» составил 0,09 на 100.тыс. населения, чуть больше общереспубликанских цифр.

Выводы

Основная часть 22 (59,5%) больных этого региона были сельскими жителями, 15 (40,5%) больных жителями городов.

Центральный рак легкого одинаково часто диагностирован у городских и сельских больных региона «Нахичевань» (60% и 63,6% соответственно).

Больные раком легкого этого региона часто (78%) обращались за медицинскую помощь в поздних - III и IV стадиях опухоли.

Независимо от пола в этом регионе часто (55,6%) диагностирована плоскоклеточная форма рака легкого.

Рак легкого часто (83,7%) в этом регионе диагностированы в возрастных группах 50-69 лет независимо от клинко-анатомического роста опухоли.

Показатель заболеваемости и общий коэффициент смертности для региона «Нахичевань» были больше, а общий показатель летальности был ниже общереспубликанских цифр.

Список литературы

1. Заридзе Д.Г. Эпидемиология и профилактика рака // Вопросы онкологии. -2001. -№9. -С.6-14.
2. Солтанов А.А. Показатели заболеваемости, летальности и общие коэффициенты смертности по регионам Азербайджана. Материалы VI съезда онкологов и радиологов стран СНГ. г.Душанба 2010. сmp. 29
3. Bliss A, Cobb N, Solomon T, et al. Lung cancer incidence among American Indians and Alaska Natives in the United States, 1999-2004. Cancer 2008;113(5 Suppl):1168-78
4. Ferlay J., Autier P., Boniol M., Heanue M., Colombet M., Boyle P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006 Ann Oncol. 2007 Mar;18(3):581-92
5. Ghafoor A, Jemal A, Cokkinides V, et al. Cancer statistics for African Americans. CA Cancer J Clin. 2002;52:326-341.
6. Jemal A, Thun MJ, Ries LAG, et al. Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1975-2005, Featuring Trends in Lung Cancer, Tobacco Use and Tobacco Control. Journal of the National Cancer Institute; Published online Nov. 25, 2008 Print issue Dec. 2, 2008. Vol. 100, No. 23.
7. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics, 2009. CA Cancer J Clin 2009;59:225-49.
8. National Cancer Institute (NCI), Cancer Statistics Branch, Division of Cancer Prevention, and Control. Cancer rates and risks. 1996 National Institutes of Health Bethesda, MD.
9. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. Unit of Descriptive Epidemiology, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France. CA Cancer J Clin. 2005 Mar-Apr;55(2):74-108.
10. Toyooka S, Maruyama R, Toyooka KO, McLerran D, et al. Smoke exposure, histologic type and geography-related differences in the methylation profiles of non-small cell lung cancer. Int J Cancer. 2003 Jan 10;103(2):153-60.

Оптимизация скрининга заболеваний молочной железы

Ватанха В.С.

Национальный центр онкологии Минздрава Азербайджанской Республики

Проблема своевременной диагностики и лечения онкологических заболеваний на сегодня остается, пожалуй, одной из наиболее болезненных тем для медицины. Во многом это обусловлено тем, что современные методы диагностики и лечения злокачественных образований достаточно сложны и специфичны, а значит их использование, как правило, сопряжено со значительными финансовыми затратами. В Азербайджане в силу известных социально-экономических условий особенно остро стоит вопрос обеспечения права всех пациентов на гарантированный доступ к существующим в настоящее время методикам диагностики и лечения злокачественных новообразований, которые соответствуют всем современным стандартам, на качественную медицинскую, социальную и психологическую помощь. В этом смысле не является исключением и такая онкологическая патология, как рак молочной железы, которая занимает лидирующие позиции в структуре смертности женщин от злокачественных новообразований во всем мире.

Введение

Согласно имеющимся на сегодня данным МЗ Азербайджанской Республики, в 2010 году абсолютное число зарегистрированных случаев рака молочной железы в Азербайджане составило 1221, из них 9 – у мужчин. Безусловно, в сравнении с данными о заболеваемости раком молочной железы в Азербайджане 5-6 лет назад, можно констатировать улучшение показателей диагностики рака молочной железы I-II стадии согласно классификации TNM: в настоящее время заболевание в этих стадиях выявляют у 47,2% пациентов. Как известно, снижение смертности от рака молочной железы и успехи в лечении, во многом, определяются ранней диагностикой заболевания: при I стадии 5-летний срок переживают 90-95% больных; при IV – менее 10%. Однако, большинство заболевших сами обнаруживали у себя опухоль; выявленные таким путем новообразования, к сожалению, не соответствовали ранним стадиям процесса. Очевидно, что для улучшения результатов диагностики и лечения скринингу (массовому обследованию здорового населения) нет альтернативы.

Выявление РМЖ во время профилактических осмотров в целом по стране остается низким, а показатель запущенности (IIIБ - IV ст.), который является ведущим критерием качества диагностики, наоборот - высоким. Реальный путь улучшения результатов лечения опухолей молочной железы - ранняя, а в ряде случаев - доклиническая диагностика. Решить эту проблему можно только при условии применения комплексных методов диагностики [1].

По нашим данным, большинство заболевших раком молочной железы (93,5%) обратились к врачу лишь после обнаружения у себя опухоли в молочной железе. Это связано с отсутствием в нашей стране системы скрининговых обследований. Диспансерное наблюдение, регулярное обследование женщин специалистами с применением современных диагностических методов позволит значительно улучшить показатели раннего выявления и лечения заболеваний молочной железы.

Сүт безі ауруларының скрининг әдісін оңтайландыру

Онкология ауруларын диагностикалау және емдеу проблемалары қазіргі заманда да болып отыр, өкінішке орай, онкология медицинаның ең ауыр салаларының бірі. Көбінесе байқалатын жағдай, жаңа әдіспен диагностикалау және өспелерді емдеу барында қиын және спецификалы, яғни ем қолдану дұрысын айтқанда ақиалай көп шығынды талап етеді. Әзербайжанда әлеуметтік-экономикалық жағдай белгілі күш салады, әсіресе алға қояр мәселе барлық пациенттердің құқығын қамтамасыз ету, қатерлі өспелерді қазіргі заманғы әдістермен диагностикалау және емдеуге мүмкіндік жасау. Жаңа стандарттарға сәйкес сапалы медициналық, әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету. Осы тұрғыдан қарағанда онкологиялық патологияда, сүт безі рагінің қатерлі өспелері бүкіл дүние жүзі бойынша алдыңғы орында және әйелдері өлім-жітімге жеткізіп отыр.

Проблема своевременной диагностики и лечения онкологических заболеваний на сегодня остается, пожалуй, одной из наиболее болезненных тем для медицины. Во многом это обусловлено тем, что современные методы диагностики и лечения злокачественных образований достаточно сложны и специфичны, а значит их использование, как правило, сопряжено со значительными финансовыми затратами. Согласно имеющимся на сегодня данным Минздрава Азербайджанской Республики, в 2010 году абсолютное число зарегистрированных случаев рака молочной железы в Азербайджане составило 1221, из них 9 – у мужчин. Скрининг рака молочной железы предполагает массовое профилактическое обследование здоровых женщин с целью выявления у них ранней стадии заболевания. Для проведения таких обследований Национальным центром онкологии был закуплен первый в Азербайджане передвижной маммографический комплекс. Если ресурсы адекватны, методом выбора для скрининга с целью раннего выявления рака молочной железы является маммография. Это единственный метод раннего выявления, эффективность которого подтверждена с соблюдением принципов доказательной медицины.

Nowadays the problem of early diagnostics and treatment of oncological diseases remains as painful subject in medicine. It is mostly caused by the fact that the up-to-date methods of diagnostics and treatment are difficult and typical, so the application of them is joined by considerable financial cost. According to the data of the Ministry of Public Health of Azerbaijan for today, the absolute number of registered cases of breast cancer in Azerbaijan in 2010 has been 1221 and 9 of them were men. The screening of breast cancer considers massive prophylactic examination of healthy women for

Скрининг должен отвечать следующим требованиям: обладать высокой чувствительностью и специфичностью, приносить минимальный вред здоровью обследуемых; оборудование должно быть простым в эксплуатации и содержании, стоимость затрат должна быть приемлемой. Указанным требованиям соответствует маммографический скрининг, позволяющий выявить значительный спектр новообразований – от микрофокусов *carcinomae in situ* до крупных инвазивных очагов поражения. Установление размера диагностируемых опухолей является важным критерием оценки качества скрининга и определения возможностей маммографии выявлять не пальпируемые опухоли. Проведение маммографического скрининга показано с периодичностью один раз в два года в возрасте 40 и более лет, так как именно в этой возрастной группе отмечена наиболее высокая заболеваемость [5].

До 1980-х гг. рост заболеваемости и смертности от рака молочной железы наблюдался как в развивающихся, так и в экономически развитых странах. Затем, по мере внедрения маммографического скрининга, улучшения результатов диагностики и лечения в экономически развитых странах Запада произошло замедление, а затем и снижение смертности (IARC, 2002), в то время как в странах Восточной Европы и Латинской Америки, напротив, смертность от рака молочной железы продолжала возрастать [9].

В странах Западной Европы и Северной Америки достигнута возможность выявления I стадии заболевания у 70-80% и, соответственно, выздоровления от рака молочной железы – 60-80% женщин. Маммографический скрининг, таким образом, позволил уменьшить смертность от рака молочной железы на 30% через 5-7 и на 20% – через 15-20 лет от начала скрининга [13].

В настоящее время очевидно, что основное внимание должно быть сосредоточено на ранней диагностике рака молочной железы. К сожалению, нам пока недоступна реализация широкомасштабных скрининговых программ, подобных таковым в европейских странах, т. к. наше государство не готово к этому не только технически, но и, прежде всего, организационно. Очевидно, что покупка, к примеру, одного маммографа на целый регион абсолютно не в состоянии решить проблему организации скрининга. На сегодня обследование на предмет выявления рака молочной железы – это целый комплекс четко отработанных мероприятий, который, помимо всего прочего, подразумевает и современное техническое, программное и кадровое обеспечение процесса обработки данных, необходимое для учета количества населения того или иного региона в целом, лиц, прошедших скрининг, и находящихся в группе риска развития данного новообразования.

Скрининг – сложное и дорогое мероприятие, поэтому его проведение осуществимо лишь в странах, обладающих адекватно обеспеченной системой здравоохранения. Для эффективного скрининга необходимы подготовленные сотрудники маммографических кабинетов, способные должным образом оценивать неизбежные (в 4-12% случаев) рентгенонегативные опухоли молочных желез, а также опухоли «интервальные», выявляемые (в 15-25% случаев) в интервалах между обследованиями скрининга. Ложноположительные и ложноотрицательные результаты маммографии составляют 5-25% и 10-25%, соответственно.

Проведение маммографического скрининга предполагает решение многих организационных задач. Кроме обеспечения финансирования, необходимо добиться активного и добровольного участия в скрининге самих женщин [9]. Следует отметить существенные различия в психологии обследуемых в странах Западной Европы и Северной Америки, сравнительно с «установками» пациенток в Азербайджане. В отличие от рационального,

detecting early stage of the disease. For carrying out such examination the National centre of oncology has purchased mobile mammographic complex, which is for the first time in Azerbaijan. This is the only method of early detecting, efficiency of which is proved by following the principles of evidence based medicine.

прагматичного отношения к своему здоровью на Западе, наш контингент обследуемых часто не уделяет должного внимания состоянию здоровья, не осознает важности, значимости своевременной диагностики и лечения (в том числе – и по стоимости затрат на обеспечение здоровья). Важнейшая мотивация активного и добровольного участия в профилактических обследованиях – сохранение собственной жизни и здоровья – не укрепляется в сознании граждан средствами массовой информации (телевидение, радио, пресса).

Не менее важным вопросом организации такого обследования является надлежащая подготовка врачей-рентгенологов, способных квалифицированно анализировать результаты маммографического исследования, и рентгенолаборантов, обеспечивающих высокое качество подготовки к использованию оборудования для маммографии и проведения самого процесса исследования. Не секрет, что в нашей стране специальность врача-рентгенолога сложно отнести к разряду престижных, хотя в Европе подготовке этих специалистов уделяют очень большое внимание. Исходя из мирового опыта, для реализации программ скрининга рака молочной железы в Азербайджане необходимо также создать реально действующий и финансируемый в достаточном объеме Национальный комитет по скринингу, в который вошли бы ведущие отечественные специалисты.

Маммографический скрининг состоит из трех звеньев. Первое из них – городская поликлиника, которая организует диспансеризацию женского населения на закрепленной территории, формирует активный вызов и направление на скрининг, а также проводит учет его результатов. Второе звено скрининга – это маммографический кабинет, где выполняется маммографическое обследование в стандартной косой проекции. В случае выявления патологических изменений больная направляется для прохождения заключительной, (третьей) диагностической части скрининга – в окружное маммологическое отделение и онкологическую сеть для уточняющей диагностики и лечения.

Проводившиеся ранее обследования, которые ограничивались лишь осмотром и пальпацией молочных желез, были сопряжены со значительной частотой (до 28-30%) диагностических ошибок. При этом, частота выявления I стадии не превышала 13-16% случаев, что приводило к неоправданно большому числу хирургических вмешательств с диагностической целью.

Внедрение в клиническую практику специальных рентгеновских маммографов позволило выявлять до 70% непальпируемых злокачественных опухолей. При этом, достигнуто снижение дозовых нагрузок за счет специальных кассет, усиливающих экранов и растров. В целом, точность диагностики повысилась до 80-90%. Применение ультразвуковой техники дало возможность дополнить клинкорентгенологическую информацию и на 20% снизить число предположительных заключений. Доплеросонография дополнила сведения о кровотоке опухоли, тем самым, способствовала уточненной дооперационной диагностике раннего рака. Новая магнитно-резонансная техника обеспечила радиационную безопасность высокоэффективного исследования. Стала более совершенной технология пункционной биопсии.

Создание современной рентгеновской и ультразвуковой

техники дало возможность разработать новые инвазивные технологии, в частности, пункционные и дрель-биопсии молочной железы, позволяющие получать высокоинформативный материал для цитологического и гистологического исследований, что в большинстве случаев исключает необходимость проведения секторальных резекций с диагностической целью и дает возможность устанавливать точный диагноз до операции [8].

Материалы и методы

Скрининг рака молочной железы предполагает массовое профилактическое обследование здоровых женщин с целью выявления у них ранней стадии заболевания. Для проведения таких обследований Национальным центром онкологии Минздрава Азербайджанской Республики был закуплен первый в Азербайджане передвижной маммографический комплекс. Комплекс оснащен современным диагностическим оборудованием в соответствии с европейскими стандартами качественного маммографического обследования.

За 5 лет работы мобильного маммологического комплекса обследовано 1250 тысяч женщин в различных регионах Азербайджана. Из числа обследованных 95% проживали в пригороде и небольших поселках, где не было возможности проведения специализированного обследования. Таким образом, создание выездных маммографических комплексов стало одной из форм ранней диагностики рака молочной железы в условиях Азербайджана, приблизило специализированную помощь населению районов, удаленных от профильных медицинских учреждений.

Процент выявляемости из общего количества обследованных (1250 человек) составил 15% - 187 человек, из которых у 40% было подозрение на злокачественный процесс. Подобная ситуация описана во всех международных скрининговых программах при обобщении первого опыта скрининга, что связано с повышением выявляемости опухолей в популяции обследованных.

Достижение убедительных результатов скрининга, во многом, объясняется высоким качеством осуществляемой программы. Следует отметить, что проведение маммографического скрининга предусматривает формирование групп квалифицированных специалистов, включая онколога, рентгенолога, патоморфолога; также как и соответствующее техническое и научное обеспечение их работы, надлежащее обучение и тренинг медицинского персонала.

Очевидно, что программа скрининга не может быть действительно успешной без реальной долгосрочной государственной поддержки. Скрининг рака молочной железы – это, в первую очередь, серьезная государственная проблема здравоохранения, требующая принятия ответственных организационных решений.

Самообследование молочной железы с целью выявления злокачественного новообразования неэффективно. Рандомизированные исследования, проведенные в Китае с участием 267 тысяч женщин, не выявили разницы в смертности от рака молочной железы между опытной (скрининговой) и контрольной группами. Такие же результаты получили ученые в Англии, Москве и Санкт-Петербурге [7].

Риск рака молочной железы повышен у здоровых женщин, находящихся в менопаузе, при отягощенном семейном анамнезе (в случаях рака молочной железы с одним и более родственниками первой, или двумя и более родственниками второй степени родства), при гиперплазии (дисплазии) эпителия молочной железы, при семейном анамнезе носительства BRCA-1 и BRCA-2 (Breast Cancer), и некоторых других состояниях.

Кроме того, у больных, которым уже проведено

лечение по поводу рака молочной железы, повышен риск возникновения множественной (второй) опухоли в контралатеральной железе. По данным литературы, вероятность заболеть (повторно) раком молочной железы у имеющих рак молочной железы в анамнезе в 5 раз превышает риск заболевания у здоровых женщин (данные регистра Национального противоракового института США – Surveillance Epidemiology End Results).

Предраковые состояния – это морфологические изменения, которые могут прогрессировать в инвазивный рак. Проплиферативные изменения эпителия молочной железы аналогичны дисплазии в других органах. Таким образом, выявление предопухолевого состояния молочной железы возможно при исследовании пунктата ее ткани. Для получения цитологического материала в НЦО Минздрава Азербайджанской Республики отработана методика жидкостной цитологии.

Результаты цитологических исследований (и определение риска заболевания, относительно пациенток без факторов риска (ОР)) оцениваются следующим образом:

1) Непролиферативное состояние. Риск не повышен (ОР=0,85).

2) Пролиферация без атипии. Незначительно повышенный риск (ОР=1,9).

3) Атипическая пролиферация. Умеренно повышенный риск (ОР=4,4). При дальнейшей прогрессии развивается рак in situ [7].

Наиболее интересным скрининговым исследованием, проведенным под руководством Европейской ассоциации онкологов, является определение мутаций генов BRCA 1 и 2 у женщин с целью раннего выявления рака молочной железы. Данные белки, по результатам исследований, ответственны за 30–40% случаев наследственной предрасположенности к раку молочной железы. По рекомендациям седьмой конференции по адъювантной терапии рака молочной железы (Ст.-Галлен, Швейцария, февраль 2001 года), в данной группе женщин более приемлемы такие профилактические меры, как двухсторонняя мастэктомия (снижение риска развития рака молочной железы более чем на 90%) и двухсторонняя овариэктомия (снижение риска на 50–70%). Однако, этическая сторона подобных профилактических мер остается нерешенной [7].

Большой интерес для современной онкологии представляет использование полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определения изменений различных генов в плазме крови с целью раннего выявления злокачественных новообразований различной локализации, профилактики развития рака, а также формирования групп риска для динамического наблюдения.

ООО «Центром молекулярно-генетической диагностики Сабирова А.Х.» был проведен профилактический осмотр с использованием полимеразной цепной реакции 837 работников газодобывающей компании. Были выявлены изменения генов у 358 (42,8%) пациентов. У 18 (2,2%) пациентов при дальнейшем наблюдении диагностированы I и морфологически подтверждены в онкологических центрах России различные формы рака на 0 (in situ) и I стадиях опухолевого процесса. Временные интервалы от момента выявления изменений некоторых генов до момента диагностики значимых форм рака были различными и составили от 4 до 15 месяцев. Данные пациенты пролечены в онкологических центрах России. Остальной группе пациентов проведена соответствующая терапия. У 34 удалось добиться ингибирования мутаций. Оставшиеся 295 пациентов внесены в группу риска.

Учитывая высокую эффективность ПЦР-скрининга, его необходимо ввести в повседневную клиническую практику как рутинное исследование, что уже сделано во многих развитых странах. Скрининг злокачественных

опухолей и предраков имеет важное значение не только для увеличения продолжительности жизни онкологических больных, но и для уменьшения заболеваемости. В связи с чем разработка новых методов скрининга, в первую очередь, молекулярно-генетических, имеет существенное социально-экономическое значение [8].

В 1975 г. Эд Саузерн использовал меченую нуклеиновую кислоту для выявления специфической последовательности среди фрагментов ДНК, иммобилизованных на твердой подложке, - это был первый ДНК-чип, названный по имени автора «Саузерн блот». В настоящее время активно развиваются ДНК-технологии, позволяющие не только определять наличие того или иного признака, но и одновременно проводить дифференциальный секвенинг (определение точечных мутаций, полиморфизма известных участков генома, изучение экспрессии гена и определение функции гена). Технология ДНК-чипов основана на гибридизации неизвестной нуклеотидной последовательности с расположенными в определенном порядке известными ДНК-последовательностями, иммобилизованными на поверхности стекла или кремния. Результат детектируется по флуоресценции зонда, предварительно меченого флуорофором и гибридизованного с одной из иммобилизованных проб [11].

С помощью биологических чипов можно определять:

- онкомаркеры;
- генетическую предрасположенность к различным заболеваниям, в частности наследственную форму рака молочной железы и рака яичников;
- индивидуальную чувствительность к лекарствам;
- наличие и тип мутаций.

Многoletнее наблюдение за десятками тысяч женщин, подвергавшихся ежегодной маммографии в США, Швеции, Голландии с 1963 по 1980 гг., подтвердило, во-первых, высокую эффективность и чувствительность этого метода, обеспечивающего выявление, в основном, ранних стадий рака молочной железы, и, во-вторых, практически, полную безопасность его за счет сверхнизких доз облучения при исследовании. И, очевидно, самое главное достижение такого обследования заключается в том, что в группе женщин, принимавших участие в маммографическом скрининге (ежегодно или один раз в два года), смертность от рака молочной железы оказалась на 30-50% ниже, чем среди женщин, не подвергавшихся такому регулярному обследованию [14].

Поэтому в странах, где скрининг испытан всесторонне, оценена его стоимость и эффективность, уже сейчас рекомендуется ежегодная маммография женщинам 50 лет и старше, а также женщинам 35-40 лет, если кто-то из их кровных родственников болел раком молочной железы или обнаружены атипичские изменения в эпителии молочной железы при биопсии. Женщинам 40-49 лет рекомендуется маммография один раз в два года, женщинам от 35-40 лет - одна исходная маммография. Если, при этом, не выявлено рака молочной железы, следующую маммографию следует выполнять после 40 лет.

Несмотря на громадное значение маммографии для раннего выявления рака молочной железы, она не лишена существенных недостатков. Имеются специфические формы рака молочной железы, не улавливаемые маммографией при ежегодном ее выполнении. Более же частое регулярное использование этого метода может оказаться опасным и дорогим для женщин. Единственной практической альтернативой, восполняющей этот пробел, остается какое-то ежемесячное обследование, например, самообследование молочных желез.

Результаты подобных исследований, проведенных в Швеции и Англии, показали, что методика самообследования женщин требует определенной организации. Так, в

Швеции в эту процедуру было вовлечено 56000 женщин с доброкачественными изменениями в молочной железе, особенно у женщин моложе 50 лет.

Всем им были вручены памятки, содержащие основные данные о раке молочной железы, описание приемов самообследования, признаки доброкачественных заболеваний и рака молочной железы, имя, телефон и адрес врача, к которому следует обратиться при подозрении на опухоль.

Дополнительная информация распространялась через радио, телевидение и прессу. Каждая женщина получила специальный календарь с инструкцией и вопросником. Наблюдение осуществлял 21 врач. Оказалось, что 75% указанных женщин регулярно проводили самообследование, по сравнению с 1-2% женщин, не вовлеченных в программу. В течение 3 лет выявлено ровно вдвое большее число заболеваний раком молочной железы, чем ожидалось, причем, число внутрипротоковых (наиболее благоприятных) форм было в 2,6 раза выше, чем обычно, и в более молодом (на 2,5 года ранее) возрасте.

Затраты на выявление рака молочной железы оказались в 20 раз меньше, чем при массовом профилактическом осмотре. Не было отмечено случаев канцерофобии, и больные с симптомами рака молочной железы так же охотно контактировали с врачом, как и остальные [14].

Регулярное самообследование особенно важно женщинам из групп высокого риска, тем, чьи матери, бабушки или сестры болели раком молочной железы, женщинам, у которых первый менструальный цикл начался рано (до 12 лет), или тем, у которых поздно (после 50 лет) прекратилась менструальная функция, а также нерожавшим женщинам или впервые рожавшим после 30 лет, и женщинам, страдающим ожирением.

В связи с высокой заболеваемостью раком молочной железы, наличием определенного опыта в проведении программ ранней диагностики рака молочной железы, отсутствием широкого распространения среди населения метода самообследования исследование рекомендовано было провести Научно-исследовательскому институту онкологии им. профессора Н.Н.Петрова (Санкт-Петербург) и Всесоюзному онкологическому научному центру (Москва). Оно начато в 1983 г. и завершено в 2005 г.

В течение ряда лет в исследование в Москве и Санкт-Петербурге включены около 230 тыс. женщин в возрасте 40-64 лет. Обучение технике самообследования, разъяснение необходимости его выполнения и целесообразности ранней диагностики рака молочной железы проводится в группах до 20 человек с вручением памяток и календарей по самообследованию (последние в течение трех лет ежегодно обмениваются).

Таким образом, проведение данного исследования позволило получить научно обоснованную информацию об эффективности метода самообследования для ранней диагностики рака молочной железы. Последний анализ результатов выполнения программы (2005 г.) не подтвердил достоверного снижения смертности от рака молочной железы в группах обученных самообследованию (СМЖ), но наблюдалась тенденция к повышению показателей 15-летней выживаемости. Кроме того, лучшая осведомленность женщин в группе СМЖ о проблеме рака молочной железы служила важным мотивирующим фактором обращения их к онкологам и выполнения регулярной маммографии.

Комплексное ультразвуковое исследование молочной железы в современной онкологической практике относится к основным методам скрининговой диагностики. Этот метод, который включает традиционное исследование в В-режиме, а также цветное доплеровское картирование, разрешает не только оценить структуру новообразования, но и его отношение к окружающим анатомическим структурам, а также особенности внутриопухолевой васкуля-

ризации. Информативность, безвредность, возможность многократного применения определяют лидерство данного метода в скрининговой диагностике. В маммологии метод является незаменимым для:

- Исследования «рентгенологически плотных» молочных желез у молодых женщин;
- Дифференциальной диагностики кистозных и солидных образований;
- Изучения структуры и васкуляризации внутриполостных вегетаций;
- Выявления степени распространения процесса на лимфатические узлы;
- Исследования локализации опухолевого очага в недоступных для рентгеновской маммографии участках молочной железы.

Весьма перспективным и высокоинформативным методом диагностики является магнитно-резонансная томография (МРТ), однако, из-за дороговизны у нас в стране она не получила широкого применения при первичной диагностике, а, в основном, применяется для оценки степени распространенности заболевания, в целом.

Одно из важных мест занимает иммунорадиоферментная диагностика - выявление опухолевых маркеров. Изменение их концентрации зависит от возникновения и роста злокачественной опухоли. К ним относятся белки группы СА (Carbohydrate Antigen) СА 15-3; PEA (раково-эмбриональный антиген); MPA (муциноподобный раково-ассоциированный антиген) и др.

Завершающим этапом диагностики является цитологическое и морфологическое (гистологическое) исследование. Морфологическая верификация необходима при любом подозрении на злокачественный процесс в молочной железе. Сегодня наиболее информативным является выполнение трепан-биопсии опухолевого образования в молочной железе.

Биологические факторы также имеют существенное прогностическое значение и разрешают прогнозировать ответ на лечение. К биологическим факторам относятся возраст или состояние репродуктивной функции, количество пораженных региональных лимфоузлов, состояние рецепторов эстрогенов и прогестерона, количество пролифелирующих раковых клеток и экспрессия HER 2/neu. На стадиях I, II, IIIA биологические факторы дают иногда более точную прогностическую информацию, чем размеры опухоли. На современном этапе рядом с традиционным большое значение отводится иммуногистохимическому стадированию РМЖ.

В основе метода иммунодиагностики злокачественных опухолей молочной железы лежит специфика экспрессии ряда генов, которые присущи только эпителиальным клеткам [7].

Современным и важным методом является иммуногистохимическая диагностика. При РМЖ практическое значение имеет определение эстрогеновых рецепторов (ER), прогестероновых рецепторов (Pg), HER-2/neu (c-erb-2) (аналог рецепторов к факторам роста, продукт онкогена), мутации генов-супрессоров p53, BRCA-1, BRCA-2 (Breast Cancer genes). Метод разрешает прогнозировать течение заболевания и обосновать целесообразность применения гормонотерапии, химиотерапии и дополнительного противоопухолевого лечения.

Специализированная гамма визуализация для маммологии (BSGI) дает возможность увидеть изменение активности клеточного метаболизма, помогая дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования. Исследование на аппарате Dilon 6800 – дополнительная процедура, представляющая собой постмаммографическое уточняющее исследование.

Использование технологии BSGI - это инновационный

научный прорыв в области скрининговых исследований молочной железы, позволяющий эффективно справляться с подозрительными и трудными для интерпретации случаями. В случаях, где маммография малоэффективна в определении поражений, BSGI, наоборот, эффективна, особенно когда у пациента:

- Плотная ткань молочной железы;
- Множественные подозрительные поражения;
- Пальпируемые (прощупываемые) поражения, неопределяемые при помощи маммографии или ультразвука;
- Гормонозаместительная терапия;
- Пост-хирургическая или пост-терапевтическая масса;
- Имплантат.

Метод маммографического исследования имеет хорошую чувствительность, но недостаточную специфичность, что подтверждается большим количеством отрицательных биопсий. BSGI имеет сравнимые с рентгеновским излучением характеристики гораздо более высокой специфичности. Два этих метода исследования дают в руки врача уникальную возможность более точной и своевременной диагностики заболеваний молочной железы.

Метод термографии основан на выявлении с помощью инфракрасных лучей температуры разных участков молочной железы. Различие в температуре симметричных участков молочной железы на 2,50С свидетельствует о злокачественном процессе. С появлением в последнее время тепловизоров, позволяющих регистрировать и количественные перепады температуры (реометрическое исследование), возможности метода термографии значительно расширились.

В последние годы в диагностике рака молочной железы и ДЗМЖ с успехом применяется метод радиотермометрии, основанный на исследовании излучения глубоко лежащих тканей тела в дециметровом диапазоне длин волн. Интенсивность этого излучения пропорциональна абсолютной температуре тканей. Поскольку изменение температуры тканей предшествует структурным изменениям, имеется принципиальная возможность обнаружения рака молочной железы и дисгормональных изменений на ранних стадиях. Во время этого исследования регистрируется ряд признаков: расположение, интенсивность, размеры, форма, структура участков, значение температурного градиента.

В последние годы для решения проблем, требующих построения математических моделей в задачах распознавания образов, часто используют метод нейросетевого моделирования, доказавший свою эффективность при решении задач диагностики, классификации и прогнозирования в медицине.

Нейросетевое моделирование позволило выявить 4 факторных признака, которые в наибольшей степени определяют риск развития РМЖ (признаки перечисляются в порядке убывания их влияния): возраст, болезненность молочных желез перед месячными, отсутствие или нерегулярная половая жизнь, наличие доброкачественных заболеваний молочных желез в сочетании с гипертонической болезнью. На выделенном наборе признаков построена математическая модель прогнозирования риска развития РМЖ (выражается формулой).

Чувствительность модели составляет 78,8%, специфичность – 79,0%.

Научно обоснованный подход к проведению скрининга был введен в клиническую практику еще в 1975 г. двумя врачами общей практики, P.S. Frame и S.J. Carlsen, которые предложили способы выявления некоторых заболеваний при плановом физикальном обследовании. Их предложения были переработаны, дополнены и узаконены Канадской

комиссией по периодическим профилактическим обследованиям в ее первом докладе, опубликованном в 1979 г. С изменениями их одобрила и Американская комиссия по профилактическим мероприятиям. Эти публикации, а также распространение методов клинической эпидемиологии послужили толчком к дальнейшей разработке доказательного подхода к проведению скрининга, в которую включились многие исследовательские группы [12].

На сегодняшний день большинство рекомендаций по скрининговым исследованиям основывается на сравнении эффективности лечения после скрининга и в отсутствии скрининга. Степень обоснованности доказательств определяется методологическим уровнем опубликованных исследований. Эффективность раннего лечения оценивают, сравнивая смертность от исследуемой причины в группе скрининга и в контрольной группе.

Показателями точности теста обычно служат его чувствительность и специфичность. На практике основное внимание следует уделять количеству ложноотрицательных и ложноположительных результатов, полученных в разных популяциях (например, в разных возрастных, этнических группах или в группах риска). Практически, все рекомендации по проведению скрининга у взрослых подразумевают повторение теста, поэтому однократное получение ложноположительных или ложноотрицательных результатов несет мало информации о том, чего следует ожидать при повторном скрининге спустя большой промежуток времени. Следовательно, необходимо определять общее число ложноположительных результатов, полученных по крайней мере за 10 лет, но подобные наблюдения проводятся крайне редко. Нужно также учитывать негативные последствия ложноположительных результатов, например, дополнительные исследования и другие медицинские процедуры (и их стоимость), неблагоприятное психологическое воздействие (и возможные скрытые затраты на медицинское обслуживание). В немногочисленных исследованиях оценивалась эмоциональная реакция больных на сообщение о том, что результаты скринингового теста оказались «не вполне удовлетворительными». Выводы этих исследований очень тревожны, особенно если их перенести на популяцию, в целом.

Другая важная задача — анализ экономической эффективности. Почти всегда группы экспертов-ученых вырабатывают в процессе обсуждения четкие рекомендации. Но должны ли ученые этим заниматься на самом деле? Возможно, пора предоставить право решать, проводить или не проводить скрининговый тест тем, кого в большей степени затрагивают последствия принятого решения, т.е. больным и страховым компаниям. Задача исследователей — определить научные принципы и методы, используемые для обоснования скрининга, и разъяснить его возможные последствия. На основании их отчетов должностные лица (государственные чиновники, работники здравоохранения) и больные смогут составить собственное мнение и решить, хотят ли они платить определенную сумму за определенный результат, с учетом побочных эффектов лечения и возможности ложноположительных результатов. Несмотря на одинаковые сведения, полученные от экспертов, окончательное решение, скорее всего, будет разным в разных группах населения в зависимости от социально-экономического положения.

Ключевая концепция скрининга — это обнаружение настолько раннего заболевания, что проводимое далее лечение изменяет его прогноз и дальнейшее «естественное» клиническое течение. Однако, РМЖ представляет собой гетерогенное многоликое заболевание, что может существенно повлиять на эффективность скрининга. Модели скрининга РМЖ обычно основаны на том, что большинство выявляемых опухолей представляют собой инвазивные

раки в ранней стадии прогрессии.

Когда популяция женщин подвергается скринингу, далеко не все случаи РМЖ выявляются при первоначальном раунде скрининга, некоторые опухоли диагностируются уже в постскрининговом периоде с помощью клинического метода (пальпации). Это так называемые «интервальные» или межскрининговые РМЖ, обнаруженные у женщин с негативными результатами скрининга. Обычно пропорция интервальных РМЖ колеблется от 15% до 25%. Чем выше частота интервальных (пропущенных при скрининге) РМЖ, тем меньше оснований ожидать снижения смертности в данной популяции. Вероятность выявления рака при скрининге зависит от продолжительности «времени до-клинического обнаружения» опухоли (length time detectable preclinically), то есть от «sojourn time». Чем дольше «sojourn time», тем больше шанс обнаружения опухоли. Таким образом, многие опухоли, обнаруженные при скрининге, характеризуются медленным ростом и хорошим прогнозом. Это «отклонение» скрининга получило название «length time bias».

А пока маммография остается основной составляющей скрининга. Рентгеномаммография как скрининговый тест была всесторонне изучена и оценена в рандомизированных испытаниях, в которых женщины с ранее диагностированным РМЖ были исключены из числа участников. Почти во всех испытаниях (в 7 из 8) было показано, что эффект раннего обнаружения инвазивного рака проявляется через 5–7 лет от начала скрининга. Иными словами, снижение смертности от РМЖ отсрочено даже при хорошо организованном и качественно проведенном скрининге. Позитивный эффект может проявиться и значительно позже, если женщины, участвующие в скрининге, моложе 50 лет (Tabar, 1997), как это наблюдалось в Шведском исследовании.

Эффективность использования маммографии в качестве основного теста скрининга проверена в многочисленных рандомизированных испытаниях, проведенных в США (Shapiro, 1966), Шотландии (Alexander, 1999), Канаде (Miller, 1992), Швеции (Tabar, 1999; Andersson, 1997; Nystrom, 2002), Финляндии (Hakama, 1997). Наряду с несомненной пользой маммографии, заключающейся, в конечном итоге, в снижении смертности от РМЖ, имеются и некоторые проблемы. Среди них и упоминавшаяся выше «сверхдиагностика» (over diagnosis), т.е. обнаружение случаев РМЖ, которые никогда бы не были найдены без скрининга на протяжении всей жизни (до 80–90 лет) пациента. Сверхдиагностика увеличивает стоимость скрининга, усложняет оценку программ, но не приносит пользу пациенту, так как выявленное заболевание не угрожает его здоровью. От 5% до 25% выявленных при маммографии опухолей можно отнести к разряду «сверхдиагностики».

В связи с проблемой сверхдиагностики, прежде всего, рассматриваются неинвазивные РМЖ, в частности, протоковая карцинома in situ. Ретроспективные исследования показали, что клинически определяемая (пальпируемая) форма DCIS прогрессирует в инвазивный рак в 65% случаев (B.B. Семиглазов, 2001; 2003; Holland, 2004). Как часто переходят в инвазивный рак непальпируемые DCIS, выявляемые только с помощью маммографии, остается неясным. Результаты испытаний Канадского скрининга показали, что обнаружение и последующее лечение DCIS не привело к сокращению частоты возникновения инвазивного РМЖ на протяжении 11 лет наблюдения [12]. Современные работы свидетельствуют о том, что прогноз DCIS в значительной мере определяется степенью ее злокачественности. Поэтому скрининг может представлять большую пользу женщинам с определенными формами DCIS, например, с опухолями 2-3 степеней злокачественности. Для других форм DCIS остается открытым вопрос, перевешивает ли потенциальная польза их обнаружения

при скрининге побочный эффект (тревога, ненужная операция, лучевая терапия).

Анализ типа «стоимость-эффективность» различных программ скрининга показал, что стоимость «спасенного года жизни» колеблется от 3 до 8 тыс. евро, если скрининг касается женщин 50-69 лет и повторяется каждые два года.

В странах с низкими ресурсами злокачественные новообразования обычно не считаются приоритетной проблемой здравоохранения, поскольку основную угрозу общественному здоровью в этих условиях представляют инфекционные болезни. Ресурсы здравоохранения все же тратятся на лечение злокачественных новообразований, когда больные обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания. Преграды на пути совершенствования онкологической помощи разнообразны. Среди них недостаточные знания и осведомленность населения, социальные и культурные барьеры, трудности организации здравоохранения и недостаток ресурсов.

В странах с высокими ресурсами сформулированы и распространены рекомендации, разработанные с соблюдением принципов доказательной медицины, очерчивающие основные подходы к раннему выявлению, диагностике и лечению рака молочной железы [2].

В странах с высокими ресурсами маммография - основной метод обследования при объемных образованиях молочных желез с любыми клиническими проявлениями. Маммография - метод выбора при обследовании женщин в возрасте 30 лет и старше с пальпируемыми объемными образованиями молочных желез. В странах с высокими ресурсами ультразвуковое исследование (УЗИ) применяется в дополнение к маммографии для прицельного изучения очаговых изменений, выявленных при маммографии или клиническом исследовании молочных желез. Проведение УЗИ молочных желез в рамках скрининга (исследование обеих молочных в отсутствие клинических проявлений их патологии) обычно не рекомендуется, поскольку данных для определения эффективности и рентабельности этого метода в рамках скрининга недостаточно.

С другой стороны, в странах с низкими ресурсами УЗИ молочных желез обычно становится доступно до того, как находит широкое применение маммография. Последняя является узкоспециализированным методом лучевой диагностики, который гораздо дороже УЗИ. Напротив, УЗИ обычно доступно в условиях любых ресурсов, поскольку оборудование может применяться для исследования разных органов и не требует пленки. Ультразвуковые аппараты могут использовать различные датчики, что делает их применимыми для разных исследований.

В странах с низкими ресурсами применение УЗИ молочных желез на первом этапе обследования может быть более целесообразным. Этот метод особенно полезен для визуализации объемных образований молочных желез, может применяться для дифференциальной диагностики солидных и содержащих жидкость кистозных образований, позволяет судить о форме и структуре солидных образований. Все это помогает выявлять больных с пальпируемыми образованиями молочных желез, которые с большей вероятностью имеют патологию, требующую биопсии.

Заключение

Если ресурсы адекватны, методом выбора для скрининга с целью раннего выявления рака молочной железы является маммография. Это единственный метод раннего выявления, эффективность которого подтверждена с соблюдением принципов доказательной медицины. Поскольку увеличение размеров опухоли ухудшает прогноз, лучше выявлять клинически проявляющуюся опухоль

молочной железы меньших размеров. Однако, следует принять во внимание, что в некоторых регионах мира программы маммографического скрининга неосуществимы из-за отсутствия ресурсов. Кроме того, во многих из этих регионов у большинства больных диагностируют опухоли III-IV стадии, что предполагает наличие огромных возможностей для ранней диагностики без дорогостоящих методов визуализации. В этих обстоятельствах приоритетом является наличие на местах учреждений, обеспечивающих неотложную диагностику и хирургическое лечение. После появления этой возможности можно сосредоточить усилия на раннем выявлении. Следует иметь в виду, что в некоторых регионах с низкими ресурсами большинству больных недоступно никакое другое лечение, кроме хирургического. Следовательно, в этих обстоятельствах расширение возможностей для выявления заболевания на стадии, когда заболевание можно излечить хирургическим методом, становится еще более необходимым.

С точки зрения раннего выявления следует пропагандировать осведомленность о патологии молочной железы среди всех женщин. Оптимизация базовых ресурсов должна включать следующее: эффективное обучение соответствующего персонала лечебно-профилактических учреждений проведению клинического исследования молочных желез как у предъявляющих жалобы, так и у не предъявляющих жалобы женщин; несистематический скрининг с помощью клинического исследования молочных желез; демонстрационные проекты или исследования систематического скрининга с помощью клинического исследования молочных желез или самообследования молочных желез; наконец, исследования возможностей проведения маммографического скрининга. В идеале для полноты оценки результатов эти проекты требуют регистрации случаев смерти больных раком молочной железы и определения стадии выявленных опухолей.

Женщин из группы риска следует выявлять с помощью вопросников или при несистематических опросах при обращении за медицинской помощью по другим поводам. Эта стратегия также требует тщательной оценки, поскольку на Западе программы, учитывающие риск и охватывающие женщин с известными факторами риска, не выявляют значительную часть не связанных с ними случаев рака молочной железы [2].

Основная цель диагностики рака молочной железы в странах с ограниченными ресурсами, как и в странах с достаточными ресурсами, — точно дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования молочной железы, а также неинфильтрирующий и инфильтрирующий рак, чтобы своевременно оказывать надлежащую помощь.

Перед глобальным медицинским сообществом стоит растущая проблема рака молочной железы. Все более единодушным становится мнение, что давно пора любыми возможными способами применять на практике уроки, полученные в течение нескольких последних десятилетий, чтобы снизить заболеваемость раком молочной железы поздних стадий во всем мире. Хотя дополнительные исследования необходимы, они должны быть недлительными и иметь потенциал быстрого внедрения оказавшихся эффективными стратегий. Кроме того, необходимо объединение усилий организаций здравоохранения из разных стран в рамках международного консорциума для осуществления долгосрочной целевой программы глобальной борьбы с раком молочной железы.

Список литературы

1. Алиев Д.А., Мамедов М.К., Марданлы Ф.А. Повышение заболеваемости злокачественными опухолями как издержки

научно-технического и социально-экономического прогресса // Азербайджанский журнал онкологии и гематологии.- 2009.- №2.- С.3-8.

2. Бенджамин О., Андерсон М.Д. Рак молочной железы в странах с ограниченными ресурсами / Обзор рекомендаций Глобальной инициативы «Здоровье молочной железы», 2005.

3. Мазо М.П. Роль радиологических и молекулярно-генетических методов исследования в дифференциальной диагностике образований аксиллярной области // Вестник РНЦРР МЗ РФ.- 2005.- №8.

4. Семиглазов В.Ф., Нургазиев К.Ш., Арзуманов А.С. Опухоли молочной железы (профилактика и лечение).- Алматы, 2001ю-344 с.

5. Семиглазов В.Ф. Скрининг рака молочной железы // Материалы VIII Российского Онкологического Конгресса.- М., 2004.

6. Семиглазов В.В. Рак in situ. Опухоли молочной железы (лечение и профилактика). –Алматы.- 2001.-С.103-125.

7. Смоланка И.И., Скляр С.Ю. Современный взгляд на проблему диагностики и лечения рака молочной железы // Жіночий лікар.-

2008.-№5.-С.8.

8. Шабалова И.П., Джангирова Т.В. Новые технологии для оптимизации цитологической диагностики //Справочник заведующего клинко-диагностической лабораторией.- 2010.- №5.

9. IARC handbooks of cancer prevention. WHO. Breast cancer screening. IARC Press, Lyon, 2002.- 229 p.

10. Fletcher S.W. Evidence-based screening: What kind of evidence is needed? // ACP J .Club.- 1998.

11. Hakama M. Implementation of screening as a public health policy //J.Med.Screen.- 1999.- vol.6 .-P.209-216.

12. Miller A. The Canadian national breast cancer screening study // J. Natl. Cancer Inst.- 2000.-vol. 92.- P.1490-1499.

13. Tabar L. The natural history of breast carcinoma – what have we learned from screening? // Cancer.- 1999.- vol. 86.-P.449-462.

14. Tabar L. Update of the Swedish two county program of mammographic screening for breast cancer // Radiol. Clin. N. Am.- 1992.- vol.30.- P.187-210.

Анализ результатов хирургического лечения колоректального рака в онкохирургическом отделении

Досан Б.О.

Центральная больница г. Жезказган

В структуре злокачественных опухолей по частоте встречаемости колоректальный рак находится на 4-ом месте, уступая раку легких, желудка и молочной железы. На долю злокачественных новообразований ободочной кишки приходится до 20%, в то время, как опухоли прямой кишки занимают 80% в структуре колоректального рака (1).

Частота локализации рака в различных отделах ободочной кишки неодинакова. В силу этиопатогенетических моментов 50% приходится на сигмовидную кишку. Раком толстой кишки заболевают преимущественно люди в возрасте 40-46 лет. Частота рака кишки у мужчин и женщин примерно одинакова.

Радикальным методом лечения рака толстой кишки является хирургический. Пятилетняя выживаемость после оперативного лечения колоректального рака не превышает 50%. Основной причиной высокой смертности от рака толстой кишки является поздняя диагностика, из-за чего 70% больных поступает в стационар с распространенным опухолевым процессом. Вместе с тем, известно, что при ранних стадиях развития опухоли 90-100% оперированных живут от 5 до 15 лет (1).

Цель исследования

– анализ результатов хирургического лечения колоректального рака по данным ЦБ г.Жезказгана.

Материалы и методы

Проведен анализ результатов хирургического лечения больных раком ободочной и прямой кишки за 1999-2009 г.г., состоящих на диспансерном учете в ЦБ. Всего 93 пациента, мужчин – 51, женщин – 42. Распределение больных по возрасту представлено в таблице № 1.

Со II ст опухолевого процесса было 27 больных, с III стадией – 46 и IV – 20 пациентов. Распределение боль-

Таблица 1 – Распределение больных раком ободочной и прямо кишки

Пол	Всего	По возрасту				
		До 30 лет	30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет	60 и более
Мужчины	51	2	9	16	13	11
Женщины	42	1	7	12	14	8
Итого	93	3	16	28	27	19

Таблица 2 - Распределение больных колоректальным раком по возрасту в зависимости от стадии опухолевого процесса

Стадия	Всего больных	По возрасту			
		30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет	60 и более лет
II	27	3	9	7	8
III	46	4	10	15	17
IV	20	2	11	3	4
Итого	93	9	30	25	29

Анализ результатов хирургического лечения колоректального рака в онкохирургическом отделении

Досан Б.О., к.м.н

Проведенный анализ результатов хирургического лечения колоректального рака показал высокий процент послеоперационных осложнений (26%) и летальности (12%), подтвердил прямую зависимость отдаленных результатов от степени распространенности опухолевого процесса. 5 – летняя выживаемость снижается вдвое при III стадии заболевания по сравнению со II стадией.

ных по возрасту в зависимости от стадии представлено в таблице 2.

В таблице 3 перечислены виды оперативных вмешательств, выполненных по поводу колоректального рака.

Полученные результаты и обсуждение

Показатель послеоперационных осложнений при операциях на толстой кишке составил по нашим данным 26%. Основной причиной детальных исходов явился перитонит,

Таблица 3 - Характер выполненных операций при колоректальном раке

№	Вид операции	Кол-во больных
1	Гемиколэктомия справа	9
2	Гемиколэктомия слева	11
3	Резекция поперечно-ободочной кишки	7
4	Резекция сигмовидной кишки	13
5	Операция Гартмана	12
6	Передняя резекция прямой кишки	14
7	Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки	16
8	Паллиативные операции	11
	Всего	93

Таблица 4 - Отдаленные результаты хирургического лечения колоректального рака

Пол	Всего	По возрасту			
		До 3-х лет	3-5 лет	5-10 лет	10 и более лет
Мужчины	51	17	9	14	11
Женщины	42	15	7	12	8
Итого	93	32	16	26	19

Таблица 5 - Отдаленные результаты оперативного лечения рака толстой кишки в зависимости от стадии

Стадии	Всего	Отдаленные результаты			
		До 3-х лет	3-5 лет	5 и более лет	10 и более лет
II	27	-	1	19	7
III	46	12	15	7	12
IV	20	20	-	-	-
Итого	93	32	16	26	19

возникший на почве несостоятельности швов соустья в 15% случаев. Меньший удельный вес занимают осложнения со стороны сердечно – сосудистой системы, легких и другие, на их долю пришлось 11%. Общая послеоперационных летальность после хирургического лечения колоректального рака составила 12%.

Продолжительность жизни является основным критерием эффективности лечения онкологических больных. В таблице 4 даны показатели выживаемости больных колоректальным раком после оперативного лечения.

Более 5 лет из 51 мужчин живут 25 больных, что составляет 49,0 %, а из 42 женщин – 20 больных, что составляет 47,6%.

В таблице №5 представлены отдаленные показатели оперативного лечения рака толстой кишки в зависимости от стадии.

Из больных колоректальным раком, оперированных со II стадией заболевания, более 5 лет живут 26 пациентов, что составило 96,3% от всех больных данной группы. с III стадией заболевания более 5 лет живут 19 больных, на их долю пришлось 41,3% от всех пациентов с III стадией.

Таким образом, проведенный анализ результатов хирургического лечения колоректального рака показал высокий процент послеоперационных осложнений (26%) и летальности (12%), подтвердил прямую зависимость отдаленных результатов от степени распространенности опухолевого процесса. 5 – летняя выживаемость снижается вдвое при III стадии заболевания по сравнению со II стадией.

Список использованной литературы

1. Рак ободочной и прямой кишки / Под ред. В.И. Кныш. – М.: Медицина, 1997-304 с.

Результаты реконструктивно-пластических операций при раке молочной железы в КазНИИОиР

Талаева Ш.Ж., Ли И.Н., Кайбуллаев Б.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Актуальность

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным онкологическим заболеванием женского населения. По данным ВОЗ, в мире каждый год регистрируется более 1 000 000 новых случаев РМЖ. В Республике Казахстан РМЖ представляет не менее актуальную проблему, что связано с высокой, постоянно возрастающей заболеваемостью и смертностью больных. Рак молочной железы занимает 2-е место в структуре всех злокачественных опухолей и 1-е – в структуре женской онкопатологии. Удельный вес женщин, больных РМЖ, в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) составляет 20,5%000, удельный вес смертности от РМЖ – 8,5%000. РМЖ характеризуется чрезвычайной вариабельностью клинического течения от агрессивного до относительно доброкачественного. Значительная часть больных РМЖ фактически имеет системный характер заболевания, потенциально излечимое только с помощью эффективной медикаментозной терапии, дополняющей локальное хирургическое и лучевое лечение. Осмысление этого взгляда привело к двум наиболее существенным изменениям в тактике лечения РМЖ. Первое коснулось вытеснения радикальной мастэктомии при относительно небольших опухолях в пользу внедрения органосохраняющего лечения. Второе заключается во все более широком применении адъювантной химио- и гормонотерапии сразу после хирургического вмешательства, а также более активного использования этих методов в предоперационном периоде для уменьшения размеров опухоли и создания возможности органосохраняющего лечения. Онкопластическая хирургия молочной железы – новое направление, сочетающее в себе базовые принципы пластической хирургии и онкохирургии с целью достижения оптимального результата как в онкологическом, так и в эстетическом аспектах.

Цель исследования

– изучение влияния реконструктивно-пластических операций на качество жизни больных раком молочной железы.

Материалы и методы

С мая 2010 года в отделении опухолей молочных желез КазНИИОиР проведено оперативное лечение с одномоментной пластикой 35 больным раком молочной железы T1-2N0-2M0 стадиями. Двое больных без предварительного лечения, две пациентки получили комплексное лечение (им была произведена отсроченная реконструктивно-пластическая операция ТДЛ и TRAM-лоскутом), 31 женщина – после проведения 4 курсов неоадъювантной полихимиотерапии (НАПХТ). Кожесберегающая мастэктомия в комбинации с имплантом была произведена 19 больным (54,3%), пластика торакодорзальным лоскутом в комбинации с имплантом была произведена 7 (20%) пациенткам, пластика TRAM-лоскутом – 4 (11,4%) больным,

КазОжР ғылыми-зерттеу институтында сүт безі рагіне жасалған реконструктивті - пластикалық операциялардың қорытындысы.

Талаева Ш.Ж., Ли И.Н., Кайбуллаев Б.А.

Мақалада берілген қорытындылар науқастарды сүт безі рагінен емдеуде қолданылған реконструктивті-пластикалық хирургия. Сапалы өмірдің құндылығы үшін Опросник MOS -36, осылардың критери көрсеткіштері сенімді болды негізгі топтан жоғары ($P<0,01$). Реконструкті операциялардың жасалуы маңызды дәрежеде науқастардың пайдасын арттырады, сүт безінен айрылған науқастар үшін ауыр эмоциялы соққы болмайды, қалыптасқанға дейін біршама жағдай тудырады.

Результаты реконструктивно-пластических операций при раке молочной железы в КазНИИОиР

Талаева Ш.Ж., Ли И.Н., Кайбуллаев Б.А.

Целью нашего исследования стал поиск наиболее эффективных режимов неоадъювантной терапии местно-распространенных форм рака молочной железы. В сравнении со стандартной FAC-схемой химиотерапии, применение таксотера с 5-ФУ является приемлемой и альтернативной схемой у больных, имеющих противопоказание к антрациклиновым антибиотикам. Применение герцептина у больных с гиперэкспрессией Her-2 нец позволяет улучшить показатели объективного эффекта на 19,5% по сравнению с больными, не получавшими герцептин.

In this article were shown the results of treatment of patients with breast cancer with using oncoplastic surgery. We used the questions of MOS SF-36. The patients with breast cancer after reconstruction will be live as well as without disease.

мастэктомия в комбинации с имплантом Becker – 5 (14,3%) женщинам. Осложнения в виде краевых некрозов ткани молочной железы и частичного отторжения импланта наблюдались в 3 (8,6%) случаях (два из группы кожесберегающей мастэктомии, один при пластике торакодорзальным лоскутом). Последнее отмечалось у больных, которым в предоперационном периоде проводились курсы НАПХТ, и, по всей видимости, связано со снижением механизмов иммунной защиты. Контрольную группу составили 35 больных раком молочной железы T2-3N2M0 стадиями, которым после проведения 4 курсов НАПХТ была произведена радикальная мастэктомия.

Результаты лечения

Для оценки качества жизни использовался Опросник MOS SF-36 (Medical Outcomes Study 36-item Short Form

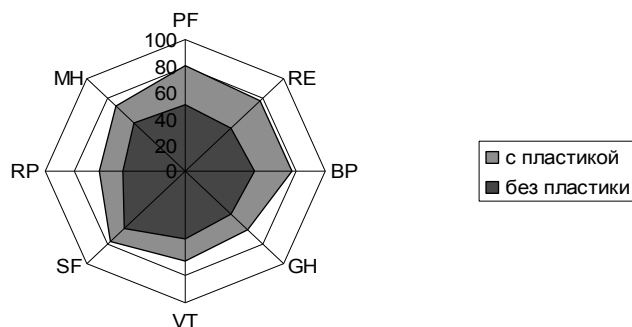


Рис. 1 - Влияние реконструктивных операций на качество жизни пациенток с раком молочной железы

Health Survey) по которым оценивался ряд критериев: General Health (GH), Physical Functioning (PF), Role-Physical (RP), Role-Emotional (RE), Social Functioning (SF), Bodily Pain (BP), Vitality (VT), Mental Health (MH). Все критерии оценивались по 10-балльной шкале, при этом в группе с пластикой молочной железы показатели PF, RE, BP, SF были $(79,6 \pm 0,8)$, $(79,5 \pm 0,9)$, $(79,4 \pm 0,9)$, $(79,6 \pm 0,8)$ баллов, показатель MH – $(73,96 \pm 1,3)$ баллов, показатели RP, VT, GH – $(59,3 \pm 0,9)$, $(59,5 \pm 0,8)$, $(59,4 \pm 0,9)$ баллов. В контрольной группе эти показатели составили $(39,5 \pm 0,6)$, $(39,4 \pm 0,7)$, $(39,3 \pm 0,77)$, $(39,5 \pm 0,6)$, $(34,1 \pm 0,8)$, $(29,4 \pm 0,7)$, $(29,5 \pm 0,7)$, $(29,4 \pm 0,7)$ баллов соответственно. Показатели критериев оказались достоверно выше в основной группе ($p < 0,01$) (рис. 1).

Выводы

Методика мастэктомии с сохранением кожи, покрывающей молочную железу, позволяет получить наилучший эстетический результат реконструктивной операции, не увеличивая вероятности местного рецидива. Психологические преимущества заключаются в снижении степени выраженности психологической травмы, когда отсутствует временной период жизни женщины без молочной железы и не формируются адаптационные механизмы, мешающие восприятию реконструированной железы при ее отсроченном восстановлении. Важным показателем успешной реконструкции может служить восприятие пациенткой реконструированной молочной железы как части собственного тела. Эстетические преимущества очевидны, так как реконструктивные вмешательства выполняются на неизмененных тканях, без рубцовых деформаций. С другой стороны, во время мастэктомии существует возможность сохранения большей площади кожи и субмаммарной складки, что оказывает значительное влияние на окончательные эстетические результаты. Практические преимущества включают в себя уменьшение количества оперативных вмешательств, снижение количества койко-дней и уменьшение себестоимости реконструкции в целом. Реконструктивно-пластические операции в свою очередь не влияют на течение опухолевого процесса больных раком молочной железы, существенно улучшая качество жизни.

Выполнение реконструктивных операций позволит в значительной степени увеличить долю больных, для которых потеря молочной железы не будет сопровождаться тяжелым эмоциональным стрессом, создавая условия для максимальной адаптации.

Роль лимфодиссекции и механических сшивающих аппаратов в хирургическом лечении рака прямой кишки

Абдужаппаров С.Б., Наврузов Б.С., Акбаров Э.Т., Исламов Х.Д.
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз,
Научный Центр колопроктологии МЗ РУз

Цель исследования

- изучить возможности выполнения одномоментных радикальных операций при раке прямой кишки с применением лимфодиссекций и наложения низких и ультранизких колоректальных анастомозов.

Материал и методы

У 35 пациентов раком прямой кишки выполнены радикальные операции с лимфодиссекцией в объеме Д2 и Д3 в зависимости от высоты расположения опухоли. Восстановительный этап операции выполнялся с применением низких и ультранизких колоректальных анастомозов при помощи циркулярно-сшивающих аппаратов фирмы Этикон. Результаты: Осложнений в послеоперационном периоде не наблюдались. Сроки наблюдения составили 1 год. Рецидив и метастазов не отмечено. Заключение: Предварительные данные позволяют сделать выводы о целесообразности выполнения данных типов операций с применением циркулярно-сшивающих аппаратов и лимфодиссекцией.

Ключевые слова: лимфодиссекция, циркулярно-сшивающие аппараты, «низкие» и «ультранизкие» колоректальные анастомозы, рак прямой кишки.

Актуальность

Злокачественные опухоли прямой кишки характеризуются медленным ростом. Соответственно и метастазирования по лимфатическим путям возникают после достижения опухоли определенных размеров. Лимфодиссекция при хирургическом лечении рака прямой кишки играет ведущую роль в прогнозировании дальнейшего течения опухолевого процесса. Основываясь на этой особенности рака прямой кишки, расширения объема лимфодиссекции может снизить показатели рецидивирования опухоли [2;3]. Различают три типа лимфодиссекции при раке прямой кишки: ограниченная, стандартная и расширенная. Показатели 5-ти летней выживаемости при стандартной и расширенной лимфодиссекции у разных авторов имеют различие. Основными недостатками расширенных лимфодиссекций является нарушение мочеполовой функции пациентов, которые доходят до 45-50% случаев [1;4;5].

Наложение так называемых «низких» и «ультранизких» колоректальных анастомозов после резекции прямой кишки имеют свои показания и противопоказания. Если при «низких» резекциях прямой кишки еще можно выполнять ручной способ наложения колоректальных анастомозов, то после «ультранизких» резекциях становится очевидным невозможность выполнения данного способа. Разработанные циркулярно-сшивающие аппараты, где головка степлера повторяет ход прямой кишки, позволяет наложить колоректальные анастомозы на короткой культ.

Морфологические исследования большинства авторов обосновали с точки зрения онкологического радикализма возможность «ультранизких» колоректальных анастомозов [7;9]. Данный факт является важным не только с точки зрения уменьшения этапности лечения в хирургии рака прямой кишки, но также несомненным социальным и экономическим фактором.

Материал и методы исследования

В отделение колопроктологии РОНЦ МЗ РУз у 35 пациентов раком прямой кишки выполнена низкая и ультранизкая резекция прямой кишки с лимфодиссекцией в различном объеме (Д2, Д3). Лимфодиссекция в объеме Д2 подразумевает удаление следующих лимфоколлекторов: параректальные, по ходу нижнебрыжечных сосудов, по ходу общей и внутренней подвздошных сосудов. При лимфодиссекции в объеме Д3 дополнительно проводится удаление лимфоузлов в бассейне запирающей ямки.

Стадия Т3-4 N0 M0 было у 17 пациентов, Т3-4 N1 M0 - у 13 больных. Мужчин было 12, женщин – 18. Возраст больных составил 62,4±4,6 лет.

Для включения в данное исследование, нами определены следующие критерии: расположение опухоли прямой кишки на высоте 5-16см от края зубчатой линии; морфологически верифицированный диагноз аденокарциномы; стадия опухолевого процесса должна соответствовать II-III стадии по Dukes.

Кишечный тракт восстанавливался путем применения коло-ректальных анастомозов при помощи циркулярно-сшивающих аппаратов фирмы «Ethicon» с рабочим объемом головки 29,31 и 33. После наложения колоректального анастомоза для декомпрессии кишечника проводили трансанальную интубацию толстой кишки. У 25 пациентов оперативное лечение проводилось одноэтапно, а у 10 больных операция разделена на два этапа в следствии наличия у пациентов явлений кишечной непроходимости. Первым этапом проводили «низкую» или «ультранизкую» резекцию прямой кишки с выведением колостомы. Через 8-12 месяцев проводился реконструктивно-восстановительный этап с наложением колоректальных анастомозов циркулярно-сшивающими аппаратами. Проводился морфологические и иммуногистохимические исследования (окраска на цитокератины), следующих групп лимфоузлов, удаленных во время операции: параректальные, по ходу подвздошных сосудов, нижнебрыжечных сосудов, из запирающей ямки.

Больным в зависимости от высоты расположения опухоли прямой кишки проводили низкую или ультранизкую резекцию с наложением колоректального анастомоза. Если высота расположения опухоли прямой кишки соответствовала от 11 до 16см (19 пациентов), выполнялся низкая резекция прямой кишки со стандартной лимфодиссекцией. При расположении опухоли от 5 до 10см (16

больных) проводили ультранизкую резекцию прямой кишки с расширенной лимфодиссекцией

Результаты и обсуждение

При изучении непосредственных и ближайших результатов оперативного лечения получены следующие: продолжительность всей операции составило $180 \pm 25,6$ мин. При этом, этап лимфодиссекции при проведении стандартном ее варианте составило $42,5 \pm 8,4$ мин, при расширенном варианте – $64,3 \pm 6,3$ мин. Кровопотеря составила $256 \pm 35,7$ мл.

При морфологическом исследовании макропрепаратов во всех случаях выявлена аденокарцинома кишечника различной степени дифференцировки: у 16 пациентов средне-дифференцированная, у 17 больных высокодифференцированная аденокарцинома. Большое значение имело изучение лимфатических узлов для прогнозирования и определения дальнейшей тактики лечения (химио- или лучевой терапии).

При этом у 3 пациентов выявлены метастазы до 3-х лимфатических узлов (N1). У 2 больных в более 3-х лимфоузлах выявлены метастатические изменения (N2). Используя иммуногистохимический метод (окраска на цитокератины лимфатических узлов - по методике фирмы Дако), дополнительно в 7 случаях выявлены метастазы в лимфатических узлах. Это говорит о высокой информативности данной методики при изучении метастатического поражения лимфатических узлов. При исследовании радикальности оперативного лечения остаточных опухолевых клеток в зонах разреза не выявлено. У больных с метастазами в лимфатических узлах в адьювантном режиме проведено химиотерапия по схеме FOLFOX-4.

Осложнений со стороны колоректальных анастомозов отмечено у одного больного, у которого отмечены явления частичной несостоятельности колоректального анастомоза, который купирован путем проведения консервативных мероприятий. У одной больной через 3 месяца после операции возник рецидив опухоли в зоне колоректального анастомоза. Больная повторно госпитализирована и произведено экстирпация прямой кишки с колоректальным анастомозом и выведением одноствольной колостомы. Больная в настоящее время получает в адьювантном режиме химиотерапию.

Выводы

1. При расположении опухоли прямой кишки на высоте 5-10 см и при отсутствии явлений кишечной непроходимости операций выбора может быть передняя резекция прямой кишки с расширенной лимфодиссекцией в объеме Д3 и наложением «ультранизкого» сигма-ректального анастомоза.

2. При расположении опухоли прямой кишки на высоте 11-16 см рекомендуется выполнение передней резекции со стандартной лимфодиссекцией в объеме Д2 и наложение «низкого» сигма-ректального анастомоза.

3. Необходимо иммуногистохимические исследования групп лимфоузлов для определения прогноза заболевания и определении тактики лечения.

Список литературы

1. Егоров В.И., Счастливцев И.В., Турисов Р.А., Баранов А.О. «Механические напряжения под нитью кишечного шва как причина нарушений микроциркуляции в области соустья» // *Анналы хирургии* — 2002. — №3, С. 66 — 73.
2. Лаерик А.С., Ващенко А.Е., Беляский Л.С., Тывончук А.С «Новые технологии в реконструктивной хирургии желудочно-кишечного тракта» // *Съезд хирургов Украины, 19—и: Материалы. Харьков, 2000, С. 88-89.*
3. Дамбаев Г.Ц., Соловьев М.М., Фатюшина О.А. и др. Новые методики формирования компрессионных анастомозов. Биосовместимые материалы и имплантаты с «памятью» формы. Northampton, Томск: STT 2001; 54-60.
4. Данзанов Б.С., Жигаев Г.Ф., Цыбиков Е.Н. и др. К вопросу о кишечных швах при операциях на толстой кишке. Материалы конференции колопроктологов. Ростов-на-Дону 2001; 121.
5. Мысливцев С.В. Разработка и клиническая апробация аппарата для колоректального компрессионного анастомоза: Дис.... канд. мед. наук. Тюмень 2000; 150.
6. Одарюк Т.С., Воробьев Г.И., Шелыгин Ю.А. Хирургия рака прямой кишки. -Москва. -2005. -с345.
7. Царков П.В., Одарюк Т.С., Сергеева О.Н. Лимфаденэктомия при раке прямой кишки. —Хирургия.-№3.-2000.-С.54-59.
8. Takahahi T., Veno M., Azekura K., Ota H. The lymphatic spread of rectal cancer and effect of dissection. Japanese contribution and experience. In: Soreide O., Norstein J. Rectal cancer surgery. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 1997. 164-180
9. Wullstein C., Gross E. Compression anastomosis (AKA-2) in colorectal surgery: results in 442 consecutive patients. Br J Surg 2000; 87: 8: 1071-1075

Некоторые аспекты применения ингаляционной анестезии в онкохирургии

Мухамадиев Б.Т., Раев Г.Б., Сазанов Е.О., Муканова М.Б., Нурманова А.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Актуальность

Современная многокомпонентная ингаляционная анестезия показана при оперативных вмешательствах, сопровождающихся нарушением внешнего дыхания, кровообращения и требующих активного управления анестезиологом жизненно важными функциями организма у онкологических больных. В онкохирургии применяют низкпоточную анестезию севофлюраном в сочетании с наркотическим анальгетиком фентанилом. Настоящая работа посвящена исследованию эффективности такой методики при операциях у онкологических больных

Цель исследования

-оптимизация анестезиологического пособия в онкохирургии.

Материалы и методы

В исследование были включены 35 пациентов в возрасте 26-64 года- 11 женщин (31,4%) и 24 мужчин (68,6%), оперированных по поводу злокачественных опухолей органов малого таза, головы и шеи, костей и мягких тканей. Физический статус этих больных соответствовал: 1 классу по ASA у 5 больных, 2-му у 26 и 3 у 4 пациентов. Все больные накануне вечером получили премедикацию (грандаксин 50 мг per os). На операционном столе после премедикации (атропин 0,3-0,5 мг, димедрол 10 мг, промедол 20 мг в/м), индукции (пропофол 1,5-2,0 мг/кг и фентанил 5,0 мкг/кг) и введения мышечных релаксантов (листенон 2 мг-кг, ардуан 0,4 мг/кг) проводилась интубация трахеи и перевод на ИВЛ. Общий наркоз поддерживали ингаляцией паров севофлюрана (2,0-4,0 об.%) в потоке кислородно-воздушной смеси (0,4:0,6 л/мин) аппаратом Fabius GS, Dreger. Перед разрезом вводили 10,0 мкг/кг фентанила, в течение операции- 500 мкг/час. Миоплегия поддерживалась ардуаном по 1 мг дробно каждые 1,5-2 часа. На этапе ушивания подкожной клетчатки, с целью потенцирования действия наркотических анальгетиков и снижения болевого синдрома в ближайшем послеоперационном периоде, вводился один из препаратов НПВС (кетопрофен, лорноксикам). Интраоперационную инфузионную терапию проводили с учетом кровопотери и соответственно показателям АД, ЧСС, индекса перфузии, ЦВД, диуреза. Основными инфузионными средами были: NaCl 0,9%, венофундин, полиглюкин. На этапах анестезии регистрировали АД, ЦВД, ЧСС, ЭКГ, SpO₂, IP, EtCo₂, FiO₂

Зерттеу мақсаты онкохирургияда анестезиологиялық көмекті қолайлылығын анықтау. Зерттеуге жамбас қуысында сүйек. Әртүрлі қатерлі ісікпен ауыратын науқастарда севофлюранды қолданып өткізілген ингаляциялық анестезия жүргізген 35 науқас алынды. Зерттеу нәтижесінде біз онкологиялық науқастарда севофлюранды қолданып өткізілген ингаляциялық анестезия сенімді, қауыпсыз және басқарылатын анестезиялық қорғанысты қамтамасыз етеді деген шешімге келдік.

Целью исследования является оптимизация анестезиологического пособия в онкохирургии. В исследование были включены 35 пациентов, оперированных по поводу злокачественных опухолей органов малого таза, головы и шеи, костей и мягких тканей, которым была проведена ингаляционная анестезия на основе севофлюрана. В результате данного исследования было сделано заключение, что ингаляционная анестезия на основе севофлюрана обеспечивает надежную, безопасную и управляемую анестезиологическую защиту у онкологических больных.

The aim of the study is to optimize the anesthetic management in oncology. The study included 35 patients operated on for malignant tumours of the pelvic organs, head and neck, bone and soft tissue, which was carried out on inhalation anesthesia on sevofluran. As a result of this study, we found that inhalation anesthesia on sevofluran provides reliable, secure and manageable anesthetic protection in cancer patients.

(таблица 1).

Результаты исследования

Продолжительность операций составила в среднем 236±34 мин. Операционная кровопотеря составляет от 500 до 2500 мл. Течение анестезии и раннего послеоперационного периода характеризовались стабильностью гемодинамики без достоверных колебаний АД, ЧСС.

Использованный метод анестезии способствовал восстановлению сознания и самостоятельного дыхания в ближайшие 10-20 минут после прекращения подачи анестетика. 16 (45%) больных были экстубированы на операционном столе, 19 (55%) – в течение 10-25 минут в палате пробуждения либо в палате реанимации и ин-

Таблица 1 - Изменение показателей гемодинамики в течение анестезии

Параметры	Исходные данные	После интубации	На разрез	Травматичный этап	В конце операции	После экстубации
АД сист., мм.рт.ст.	130±20	120±10	110±10	100±10	110±10	130±15
АД диаст., мм.рт.ст.	90±10	85±5	70±10	65±5	70±5	80±5
ЧСС, уд.в минуту	84±8	80±5	70±6	68±4	70±5	82±8

тенсивной терапии, все больные не нуждались в проведении послеоперационной ИВЛ. В среднем, через 40 минут после отключения испарителя севофлюрана признаков остаточной седации не было ни у одного больного. Интенсивность болевых ощущений по словесной шкале Tursky оценена как «легкая» у 8 (22,8%) и «умеренная» у 27 (77,2%) пациентов.

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:

1. Ингаляционная анестезия на основе низкотоchnого наркоза севофлюраном обеспечивает надежную, безопасную и управляемую анестезиологическую защиту у онкологических больных.
2. Применение ингаляционной анестезии позволяет экстубировать больных на операционном столе либо в ближайшие 25 минут после окончания операции.

Список использованной литературы

1. *Руководство по анестезиологии, под редакцией Бунятяна А.А.-М.: Медицина, 1997.*
2. *Суслов В.В., Лоскутов О.А., Мазур А.П. Современная анестезия. Оптимальные возможности.*
3. *Павел Терек. Основы ингаляционной анестезии низким потоком свежих газов. Low-flow-анестезия.- Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2007.*
4. *Hanley P.J. Ter Keurs H.E, Cannell M.B. Excitation-contraction coupling in the heart and the negative inotropic action of volatile anesthetics //Anesthesiology. -2004.-Vol. 101. – P. 999-1014.*

Правила оформления рукописей для журнала «Онкология и радиология Казахстана»

- Формат рукописи - А4.
- Текст должен быть написан в программе Word с использованием шрифта Times New Roman, кеглем 14, с пробелами полуторными.
- Статья подается на CD-диске со вкладышем, на котором обозначается имя автора и название статьи.
- Объем рукописи: научная статья - до 5 стр, случай из практики - 3-4 стр.; обзор, лекция - не более 8 стр.
- Список литературы - минимально необходимый.
- Рукопись визируется руководителем учреждения (кафедры), научным руководителем, скрепляется печатью.
- К рукописи прилагается резюме на казахском, русском, английском языках, ключевые слова, УДК.
- В конце рукописи - сведения об авторах: степень, должность, количество имеющихся публикаций.
- Адрес, телефоны (можно и мобильный), электронная почта.
- Рукопись подписывается лично автором как свидетельство полной аутентичности данных материала, ответственности автора за содержание рукописи.

Сравнительная оценка общей анестезии у онкологических больных высокого сердечно-сосудистого риска

Мухамадиев Б.Т., Раев Г.Б., Сазанов Е.О., Муканова М.Б., Нурманова А.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Актуальность

Проведение общей анестезии в онкохирургии, у больных пожилого и старческого возраста, ввиду частой встречаемости сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, представляет собой актуальную и сложную проблему[1]. Задача врача-анестезиолога минимально нарушать ауторегуляцию кровообращения, предупреждать значимые гемодинамические сдвиги во время операции и в раннем послеоперационном периоде[4]. Настоящее исследование направлено на выявление преимуществ и недостатков разных методов анестезии для обеспечения онкологических оперативных вмешательств у этого контингента больных.

Цель исследования

- снижение числа интра- и послеоперационных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у онкологических больных.

Материалы и методы исследования

Обследовано 48 пациентов, в возрасте 60-79 лет, оперированных по поводу злокачественных опухолей органов брюшной полости и малого таза. Все больные имели сопутствующую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы в виде ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности 0-1 и/или артериальной гипертензии 1-2 степени, по поводу которых на диспансерном учете не состояли и, соответственно, не получали регулярно кардиотропную терапию. Физический статус этих больных соответствовал III классу по ASA. Больные разделены на две равные группы, сопоставимые по возрасту, виду, продолжительности оперативного вмешательства и объему кровопотери. 1-я группа включала в себя 24 пациента, которым введение в наркоз и поддержание анестезии проводилось севофлюраном[2], во 2-ой группе (24 пациента) проводилась тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола. Все больные накануне вечером получили премедикацию (грандаксин 50 мг per os). Перед операцией премедикация включала в себя димедрол 10 мг, промедол 20 мг в/м, и, по показаниям, атропин 0,3-0,5 мг в/м. Индукция в 1-ой группе проводилась севофлюраном болюсным методом (8 об.%), во 2-ой использовался пропофол 1,5-2,0 мг/кг, бризепам 0,2 мг/кг и фентанил 5 мкг/кг. Миоплегия в обеих группах достигалась введением мышечных релаксантов (листенон 2 мг/кг, ардуан 0,4 мг/кг), после чего проводилась интубация трахеи и перевод на ИВЛ. Режим вентиляции и параметры ИВЛ подбирались соответственно массе тела, ЖЕЛ, концентрации CO₂ на выдохе и уровнем CO₂ в артериальной крови.

Соответственно, у пациентов первой группы основным компонентом общей анестезии был анестетик севофлюран (2-4 об.%) в составе кислородно-воздушной смеси 1:1, при этом поток свежих газов составлял 1,0-1,5 л/мин, Fi O₂ 35-50%. Анальгезия поддерживалась болюсным введением

Зерттеуге 2 топ егде жастағы қосымша жүрек және қан-тамыр жетіспеушілігі бар науқастар алынды. Барлығына құрсақ пен жамбас қуысына радикалді операциялар жасалынды. 1-ші топта индукция мен анестезия севофлюранмен, 2-ші топта жалпы көк тамыр ішілік анестезия өткізілді. Зерттеу мақсаты: аталған анестезия түрлерінің операция және операциядан кейінгі жақын уақытта жүрек және қан-тамыр жүйесіне әсерін анықтау.

Исследовано 2 группы пациентов пожилого возраста, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, которым были выполнены радикальные оперативные вмешательства на органах брюшной полости и малого таза. Цель исследования -изучение влияния этих видов анестезий на сердечно-сосудистую систему во время операции и раннем послеоперационном периоде. Результаты. В 1-ой группе больных проводилась индукция и поддержание анестезии проводились севофлюраном, во 2-ой группе – тотальная внутривенная анестезия.

Studied 2 groups of elderly patients with concomitant cardiovascular disease, who underwent radical surgical interventions on the abdominal and pelvic organs. In the first group induction and maintenance of anesthesia were sevoflurane, in the second group - total intravenous anesthesia. The aim is to study the effects of these anesthetics on the cardiovascular system during surgery and early postoperative period.

фентанила 5-10мкг /кг/ час.

Во второй группе в качестве основного гипнотического компонента использовали пропофол виде инфузии со скоростью 4-8 мг/кг/час, для потенцирования гипнотического эффекта вводился бризепам дробно по 10 мг каждые 1,5-2 часа. Анальгезия также проводилась фентанилом 8-12 мкг/кг/час.

Мониторинг ЧСС, НАД, ЭКГ, SpO₂, EtCO₂ осуществляли в непрерывном режиме. Экспресс- методом оценивали показатели газообмена, кислотно-основного состояния, гемоглобина, уровня глюкозы, лактата и электролитов плазмы крови. Регистрировали общий объем кровопотери, инфузионно - трансфузионную терапию, мочеотделение.

Этапы измерения: I- исходные данные, II- индукция в анестезию, III-начало операции, IV- на высоте операционной травмы (в период мобилизации опухоли и активной кровопотери), V- в конце вмешательства на этапе ушивания операционной раны [3].

Результаты исследования

Всем исследованным пациентам были успешно вы-

полнены операции в запланированном объеме. При поступлении в операционную у большинства пациентов (39/48) на фоне эмоционального стресса отмечалась умеренная синусовая тахикардия 95 ± 8 , у 9/48 была нормосистолия 80 ± 4 . В первой группе больных динамика АДсист характеризовалась снижением на этапе индукции на 25-30 %. Показатели АД быстро возвращались к нормальным физиологическим значениям с началом оперативного вмешательства, но тенденция к гипотензии (АДсист 92 ± 5 мм. рт. ст.), не требующей коррекции, сохранялась на всей протяженности анестезии и операции. В этой группе показатели ЧСС не колебались и составляли в среднем 68 ± 8 уд. в мин. Показатели КОС и метаболиты на этапах анестезии и операции сохранялись в пределах физиологических значений. Осложнений во время анестезии и в раннем послеоперационном периоде не отмечалось.

Во 2-й группе АДсист во время индукции снижалось на 15-20 %, с дальнейшим возвратом и поддержанием на исходном уровне на этапах операции. Показатели КОС и уровень метаболитов также находились в пределах допустимых величин. Необходимости в коррекции АД не возникало, но некоторым пациентам потребовалась коррекция ЧСС: у 2-х больных в течении 1-го часа возникли частые желудочковые экстрасистолы, у 1-го больного во время индукции в анестезию развилась тахисистолическая форма фибрилляции предсердий. Нарушения ритма были купированы медикаментозно и в дальнейшем не возобновлялись. У одного пациента данной группы на 2-е сутки после операции развилась безболевая форма ишемии миокарда, которая купировалась приемом нитратов за 2-е суток.

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:

1. У пациентов высокого сердечно-сосудистого риска могут с успехом применяться как и ингаляционная анестезия на основе севофлюрана, так и тотальная внутривенная анестезия.
2. При выборе метода анестезии следует учитывать характер сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.
3. Сбалансированная тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола, брьюзепама, фентанила может использоваться у тяжелого контингента больных, в том числе со сниженной сократительной способностью миокарда, без риска развития критических нарушений деятельности сердца и кровообращения.
4. Применение общей анестезии на основе севофлюрана показала значительно лучшие результаты, данный ингаляционный анестетик оказывает минимальное влияние на атриовентрикулярную проводимость, обладает кардиопротективным действием, позволяет минимизировать дозу опиоидных анальгетиков и миорелаксантов, что способствует быстрой посленаркозной реабилитации, особенно важной для пожилых пациентов.

Список использованной литературы

1. *Руководство по анестезиологии, под редакцией Бунятына А.А. - М.: Медицина, 1997.*
2. *Суслов В.В., Лоскутов О.А., Мазур А.П. Современная анестезия. Оптимальные возможности // Анестезиология и реаниматология. - 2009. - №2. С. 27-31.*
3. *Hanley P.J., Ter Keurs H.E., Cannell M.B. Excitation-contraction coupling in the heart and the negative inotropic action of volatile anesthetics // Anesthesiology. - 2004. - Vol. 101. - P. 999-1014.*

Влияние некоторых анестезиологических препаратов на CD95-зависимый апоптоз и пролиферативную активность лимфоцитов у больных с разлитым гнойным перитонитом

Гасанова Л.В., Исаев Г.Б.

Научный центр хирургии им. акад. М.А.Топчибаева, г.Баку

Методом выбора у больных с разлитым гнойным перитонитом (РГП) является многокомпонентная общая анестезия с искусственной вентиляцией легких на фоне тотальной миорелаксации, при этом анестезиологическое пособие должно быть безопасным и эффективным [2,4]. Однако общая анестезия, так же как и хирургический стресс, влияет на основные компоненты иммунной системы: фагоцитоз, гуморальный иммунитет, клеточный иммунитет, систему цитокинов [5,8,9]. Даже транзиторная депрессия иммунной системы может иметь серьезные последствия, особенно у таких «иммунокомпрометированных» больных как больные с перитонитом [5].

В настоящее время из литературных данных известно, что пролиферирующий клеточный ядерный антиген является индуктором митоза и по существу отражает наличие пролиферативной активности клетки. Уже в первые сутки после операции, как правило, уменьшается число Т-лимфоцитов с одновременным снижением их функциональной активности, способности к пролиферации и синтезу ряда цитокинов [1,6].

Наряду с пролиферацией апоптоз является одним из основных механизмов функционирования иммунной системы. В лимфоцитах при их активации происходит индукция апоптоза [1,7].

Учитывая тот факт, что почти половина лимфоцитов периферической крови в здоровом организме находятся в активированном состоянии, готовом к апоптозу и несет на себе маркер CD95+ (Fas/APO – 1), можно предполагать особую значимость влияния анестезиологических препаратов (АП) на процесс запрограммированной гибели клетки. Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования явилось определить влияние АП на CD95+/Fas – зависимый апоптоз и пролиферативную активность лимфоцитов в серии нагрузочных тестов *in vitro* у больных с разлитым гнойным перитонитом.

Материалы и методы исследования

Влияние АП на маркер апоптоза CD95+ определено у 15 больных с РГП. Состояние больных оценивалось как II степени тяжести согласно Мангеймскому индексу перитонита (МИП) – (средний балл – 23,6±1,26). Влияние АП на пролиферативную активность лимфоцитов было исследовано у 12 больных с РГП (средний балл 23,5±1,45). Забор крови для исследований производили до вводной анестезии.

Влияние АП на мембранный маркер CD95+ и пролиферативную активность лимфоцитов определяли по предложенному нами способу. Лимфоциты из суспензии клеток выделяли центрифугированием в градиенте плотности раствора фиколл-верографина (ДИАМ, Швеция). Свежевыделенные лимфоциты использовали для определения рецептора CD95+. Параллельно проводились две

The effect of anesthesiologist agents on membrane marker of CD95+ and proliferative activity of lymphocytes in vitro in patients suffering from diffuse purulent peritonitis

Hasanova L.V., Isayev H.B.

In our study, we wanted to assess the effect of anesthesiologist agents (AA) on CD95-Fas-dependent apoptosis (15) and proliferative activity in patients with diffuse purulent peritonitis (DPP) (12). Regarding the percentage of lymphocytes ready for apoptosis in the experiments using AA to percentage of CD95+ in control tests not using AA, we determined a stimulation index (SI) of apoptosis and proliferation index (PI). However, it is important to note that in vitro system in practically normal subjects and in patients suffering from DPP the more low SI showed sibazon that indicated to the inhibition of CD95+ marker activity under its action. The highest SI showed droperidol and morphine, namely this drugs are induces CD+95 marker activity. The highest PI showed sibazon, and lowest PI showed morphine. Moreover, as different from that of practically normal subjects, patients suffering from DPP showed the highest SI for morphine. It was on average 1.07, and most likely morphine induces CD95+ activity like as droperidol.

серии опытов. Лимфоциты инкубировали в течение 3-х часов при температуре 4°C в присутствии и без АП, наиболее часто используемых при общей анестезии в нашей клинике: промедол, морфин, омнопон, фентанил, сибазон, дроперидол, калипсол, тиопентал-натрий, пропофол, натрия оксibuтират. Концентрация препарата рассчитывалась с учетом 5 мкл на 50 мкл взвеси лимфоцитов (опыт), т.е. с расчетом 1:10.

Для исследования маркера апоптоза применяли метод люминесцентной микроскопии с использованием моноклональных антител CD95+, меченых флуоресцеин изотиоцианатом, производства «Сорбент» (Россия). Индекс стимуляции апоптоза оценивали по соотношению процента готовых к апоптозу лимфоцитов в опыте с АП к процентному содержанию CD95+ в контрольных пробах без АП. Аналогичным образом в пробах опыт – контроль изучалось влияние АП на пролиферативную активность лимфоцитов. Индекс пролиферации определяли по соотношению процента пролиферации с АП (опыт) к контрольной пробе (без препарата). Подсчет blastopodобных клеток проводили с помощью световой микроскопии (увеличение 7х100) при просмотре 100 лимфоцитов. За blastopоды принимали клетки с диаметром 15-20 мкм с большим гиперхромным ядром и узким ободком цитоплазмы.

Результаты исследования обрабатывали на компьютере с использованием пакета прикладных программ Excel.

Определяли среднюю арифметическую вариационного ряда (M), среднее квадратичное отклонение ($\pm\sigma$), среднюю ошибку средней арифметической ($\pm m$). Достоверность различий параметров определяли по t -критерию Стьюдента для зависимых выборок. При этом в каждой группе наблюдений с отдельным препаратом рассматривали разницу (d) между двумя измерениями (контроль и после опыта). Вычитая первые значения из вторых, расчеты проводили по формуле $t = \frac{d}{\sigma_d}$, где N – число больных [3].

Результаты исследований и их обсуждение

Полученные результаты о влиянии АП на экспрессию маркера CD95+ лимфоцитов *in vitro* у больных с РГП представлены на рис.1.

На основании сравнительного анализа и статистической обработки полученных данных у больных с РГП в системе *in vitro* выявлено различное влияние АП на апоптоз лимфоцитов. Более выраженное ингибирующее действие на активность маркера CD95+ оказывал сибазон. Индекс стимуляции под его действием был самым низким и в среднем составлял 0,96. По данным t -критерия Стьюдента, для зависимых выборок снижение уровня CD95+ под влиянием сибазона было статистически достоверным ($p < 0,05$). Индекс стимуляции был самым высоким в опытных пробах с применением дроперидола (1,16) и морфина (1,07). Повышение активности маркера CD95+ под действием данных препаратов было статистически значимым ($p < 0,05$).

Показатели, отражающие состояние пролиферативной активности лимфоцитов *in vitro* при их инкубации с АП представлены на рис.2.

Как видно из рис. 2, самые низкие индексы пролиферации были выявлены у морфина – 0,82 и у дроперидола – 0,87. При чем по данным t -критерия Стьюдента для зависимых выборок морфин статистически значимо ($p < 0,05$) ингибировал пролиферативную активность лимфоцитов, в то время как для дроперидола данный показатель был статистически недостоверным ($p > 0,05$). Статистически значимое индуцирующее влияние на пролиферацию мононуклеарных клеток периферической крови оказывали сибазон и тиопентал натрия. У данных препаратов были самые высокие индексы пролиферации: у сибазона в среднем – 1,73 ($p < 0,001$) и у тиопентал натрия – 1,54 ($p < 0,05$).

Таким образом, наши исследования выявили, что АП влияют на мембранный рецептор CD95+ и на пролиферативную активность лимфоцитов и помогают более точно оценить состояние иммунного статуса у больных с перитонитом. Полученные данные необходимо учитывать при проведении общей анестезии у больных с перитонитом.

Выводы

1. Препараты, применяемые при общей анестезии оказывают различное влияние на CD95- зависимый апоптоз и пролиферативную активность лимфоцитов *in vitro*.
2. У больных с РГП отмечают статистически значимые ($p \leq 0,05$) высокие индексы стимуляции маркера CD95+ для морфина (1,07) и дроперидола (1,16); высокий индекс пролиферации для сибазона (1,73).
3. Рекомендуется ограничить применение морфина и дроперидола при проведении общей анестезии и в послеоперационном периоде у больных с перитонитом.
4. Следовало бы также не применять дроперидол во время общей анестезии, а тем более применение и

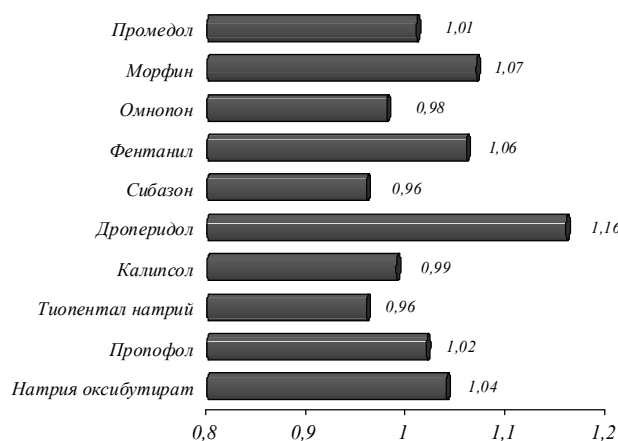


Рис. 1 Индекс стимуляции (опыт/контроль) уровня CD95+ под воздействием АП у больных с РГП

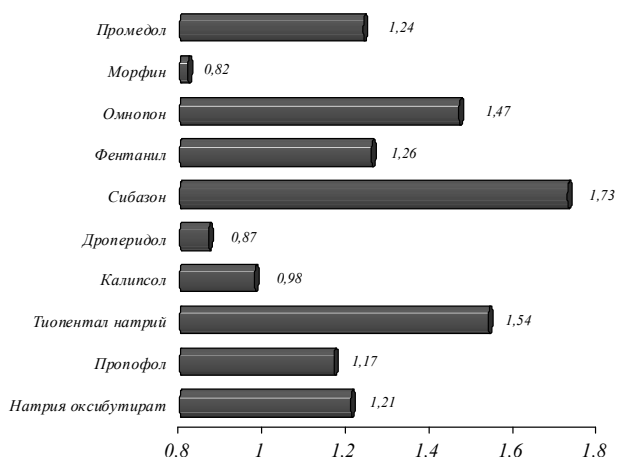


Рис. 2 Индекс пролиферации (опыт/контроль) лимфоцитов под воздействием АП у больных с РГП

дроперидола и морфина у данной категории пациентов.

Литература

1. Барышников А.Ю., Шишкин Ю.В. Иммунологические проблемы апоптоза.-М.: Эдиториал УРСС, 2002, 320 с.
2. Векслер Н.Ю., Бояринов Г.А., Макаров Н.А. и др. Тактика ведения больных с диффузным перитонитом с позиций анестезиолога-реаниматолога // Вестник интенсивной терапии, 2004, №5, с. 178-180
3. Зайцев В.М., Лифляндский В.Г., Маринкина В.И. Прикладная медицинская статистика СПб.: Фолиант, 2003, 432 с.
4. Исмаилов И.С. Выбор метода общей анестезии у больных с разлитым гнойным перитонитом // Azərbaycan Tibb Jurnalı, 1997, №2, с.20-25
5. Кутиашвили И.З., Буров Н.Е. Влияние интраоперационных факторов на иммунореактивность (обзор литературы) // Клиническая анестезиология и реаниматология, 2005, т.2, №3, с.9-17
6. Шиффман Ф. Дж. Патифизиология крови Пер с англ. - М.-СПб.: «Издательство БИНОМ» - «Невский диалект», 2000, 448 с.
7. Elmore S. Apoptosis: a review of programmed cell death // Toxicologic Pathology, 2007, v.35, №4, p.495-516
8. Procopio M.A, Rassias A.J., DeLeo J.A. et al. The In Vivo Effects of General and Epidural Anesthesia on Human Immune Function. Anesth Analg 2001, v.93, p.460-465
9. Schneemilch C., Hachenberg T., Ansorge S., Ittenson A., Bank U. Effects of different anaesthetic agent on immune cell function in vitro // Eur J Anaesthesiol., 2005, v.22, № 8, p.616-623

Опыт применения препарата Септонест в местной анестезии при малых гинекологических операциях.

Ли В.В., Абдулаханова Р.Р.

Медицинский центр «КАУ», г.Алматы,

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

Актуальность

Лечение больных с доброкачественными заболеваниями влагалищных частей шейки матки является одной из основных проблем гинекологии. Важность этой проблемы обусловлена сравнительно большой частотой заболеваний, недостаточной эффективностью лечения, а также определённой вероятностью злокачественного перерождения. Патология шейки матки наблюдается у 38,8% женского населения и у 49% гинекологических больных.

В настоящее время так называемые малые гинекологические операции, преследующие диагностическую и лечебную цель, представлены в виде различных видов коагуляции и конизации тканей, ножевой биопсии тканей шейки матки, вульвы, влагалища, аспирационной биопсии эндометрия, диагностического выскабливания цервикального канала и т.д. Все хирургические вмешательства нуждаются в адекватном обезболивании.

Традиционным методом анестезии в амбулаторно-поликлинических условиях является местная парацервикальная новокаиновая блокада. В результате блокируется висцеральная сенсорная иннервация шейки матки и верхней части влагалища на уровне околошеечного сплетения. При проведении широких радикальных диатермохирургических вмешательств (высокая конизация шейки матки, широкая плоскостная эксцизия) для достижения должного эффекта анестезии увеличивается доза вводимого новокаина до 20-40 мл., что создаёт определённые технические неудобства при выполнении манипуляции. Нередки случаи индивидуальной непереносимости новокаина и центральные отложенные реакции: заторможенность, сонливость.

Прослеживая аналогию в строении слизистой оболочки, подслизистого слоя, волокнистых элементов и кровеносных сосудов полости рта и слизистой влагалищной части шейки матки, недостаточный местноанестезирующий эффект новокаина, нами предлагается альтернативный метод местного анестезиологического пособия. Анестетики, широко и с большим успехом, применяющиеся в стоматологии могли бы быть эффективны при проведении малых гинекологических операций.

В качестве местных анестетиков, нами предлагаются препараты из группы амидов: лидокаин, тримикаин, артикаин, подавляющие рецепторную возбудимость и блокирующие проведение импульсов по нервным волокнам. Из препаратов артикаиновой ряда большой опыт применения имеет препарат типа септонест в стандартном разведении 1:100 000 и 1:200 000. Септонест, обладая высокой липидной растворимостью, проявляет выраженный анестезирующий эффект, а высокий уровень связывания с протеинами обуславливает низкую токсичность препарата. Септонест обладает рядом преимуществ при его использовании:

- удобная система карпульного шприца с определённым необходимым объёмом картриджа или количества препарата

- малые дозы препарата позволяют достигнуть хорошего обезболивающего эффекта; достаточно объёма одного картриджа 1,7 мл септонеста против 10-20 мл 0,5% рас-

Опыт применения препарата септонест в местной анестезии при малых гинекологических операциях

Лечение больных с доброкачественными заболеваниями влагалищных частей шейки матки является одной из основных проблем гинекологии. Важность этой проблемы обусловлена сравнительно большой частотой заболеваний, недостаточной эффективностью лечения, а также определённой вероятностью злокачественного перерождения.

В качестве анестетика предлагается препарат септонест, который проявляет выраженный анестезирующий эффект и низкую токсичность.

Цель исследования - оценка целесообразности применения анестетика типа септонест в гинекологической практике.

Материалы и методы: В исследование включены 2096 пациенток с фоновыми и предраковыми заболеваниями женских половых органов, которым проводились малые гинекологические хирургические и диагностические вмешательства в амбулаторно-поликлинических подразделениях г. Алматы с 1995 по 2010 год.

При отсутствии аллергических реакций в течение 3-5 минут, анестетик вводится в нескольких точках удаляемой или резецируемой тканей. При выполнении широких диатермоконизаций или диатермоэксцизий, предпочтительными точками введения препарата является участки шейки матки, свободные от обильного кровоснабжения: предположительно 9,11,15,17 часов условного циферблата.

Результаты показали, что препарат можно рекомендовать в качестве местноанестезиологического пособия в гинекологической практике.

Experience in use of the drug septonest in local anesthesia for small gynecological operations.

Treatment of patients with benign diseases of the vaginal part of the cervix is a major problem gynecology. The urgency of this problem is caused by the relatively high frequency of diseases, insufficient treatment efficacy, and also specific probability of malignant transformation

The purpose of the study - assessment of the feasibility of anesthetic type septonest in gynecological practice

Material Methods: The study included 2,096 patients with background and precancerous diseases of female genital mutilation, which were minor gynecological, surgical and diagnostic interventions in the outpatient departments poliklieicheskikh Almaty from 1995 to 2010. As an anesthetic drug septonest proposed, which exhibits a pronounced anesthetic effect and low toxicity. The results showed that the drug can be recommended as a locally anesthesia in gynecological practice.

твора новокаина

- отсутствие практически побочных реакций, хорошая переносимость

- гемостатический эффект, за счёт резкого сужения сосудов на местном уровне, с достижением высокой концентрации анестетика локально и профилактикой подслизистых кровоизлияний

- быстрый последующий обратимый эффект ингибирования чувствительности вегетативных, сенсорных и моторных нервных волокон.

Перечисленные позитивные возможности препарата септонест могут явиться альтернативой при его применении в гинекологической практике при обезболивании хирургических вмешательств на слизистых оболочках репродуктивных органов.

Цель исследования

Оценка целесообразности применения местного анестетика типа септонест в гинекологической практике для улучшения возможностей местной анестезии.

Материалы и методы

В исследование включены 2096 пациенток с фоновыми и предраковыми заболеваниями женских половых органов, которым проводились малые гинекологические хирургические и диагностические вмешательства в амбулаторно-поликлинических подразделениях г. Алматы с 1995 по 2010 год. Пациентки были представлены всеми возрастными группами (табл.1)

Таблица 1 - Распределение больных с доброкачественной патологией гениталий по возрасту

Репродуктивный возраст до 40 лет	1560	74,4%
Климактерический период 41-50 лет	332	15,8%
Ранний менопаузальный возраст 50 лет и старше	204	9,7%
	2096	

Во всех возрастных группах, при выполнении хирургических манипуляций на шейке матки, цервикальном канале, вульве, влагалище и т.д., в качестве местного анестетика использовался препарат септонест в стандартном разведении.

Септонест - комбинированный препарат для местной анестезии, с действующим началом атракаин, обладающий высоким анестезирующим эффектом и хорошей переносимостью. Действие препарата начинается через 3-4 минуты после инъекции, с продолжительностью анестезирующего эффекта в мягких тканях не менее одного часа. Стандартное разведение препарата 1:100 000 для обеспечения более длительного эффекта анестезии и 1:200 000 при малых объемах лечебных и диагностических вмешательств.

Для введения препарата используется система карпульного шприца, применяемого, в основном, в стоматологии. Для определения индивидуальной чувствительности к препарату, рекомендуется сублингвальная или внутрикожная проба. При отсутствии аллергических реакций в течение 3-5 минут, анестетик вводится в нескольких точках удаляемой или резецируемой тканей. При выполнении широких диатермокоагуляций или диатермоэксцизий, предпочтительными точками введения препарата является участки шейки матки, свободные от обильного кровоснабжения: предположительно 9,11,15,17 часов условного циферблата. Анестетик вводится в стандартной дозе 1,7 мл (1 картридж), с помощью карпульного шприца, в подслизистый слой, на границе поражения, в пределах здоровой ткани.

Скорость введения препарата: 1,7 мл в течение 1 минуты. С целью исключения подэпителиальных кровоизлияний рекомендуется аспирационный контроль. Через 2-3 минут проба электродом на болевую реакцию и при её отсутствии дальнейшие необходимые местные вмешательства. Доза препарата может индивидуализироваться в зависимости от объёма патологической ткани и индивидуальной чувствительности пациентки.

Результаты исследования

При клиническом исследовании 2096 пациенток, которым проводились малые гинекологические операции и диагностические манипуляции с применением местного анестетика типа септонест, виды хирургических вмешательств были распределены следующим образом (табл.2)

Таблица 2 - Виды мало гинекологических операций и диагностических манипуляций.

Диатермохирургические вмешательства	1829	87,26%
Прицельная биопсия	75	3,57%
Удаление кондилом, папиллом, эндометриоидных кист	28	1,3%
Аспирационная биопсия	36	1,7%
Окклюзия цервикального канала	20	1%
Полипэктомия с выскабливанием ложа	34	1,6%
Биопсия слизистой цервикального канала	33	1,6%
Введение ВМС	41	1,95%
	2096	

В подавляющем большинстве случаев (87,26%) септонест в качестве местного анестетика использовался при диатермохирургических вмешательствах по типу диатермокоагуляция, диатермоэксцизия, диатермокоагуляция шейки матки. Во всех случаях произведённых диатермохирургических операций отмечалось отсутствие болевых реакций и ощущений на фоне местной анестезии септонестом. Для купирования болевого синдрома при взятии аспирационной биопсии эндометрия у 36 женщин (1,7%) расширении цервикального канала при его окклюзии у 20 (1%) женщин и т.д., применение септонеста позволило более качественно провести эти вмешательства с наибольшим комфортом для пациентки, с продолжительным обезболивающим эффектом.

Септонест при малых хирургических вмешательствах на гениталиях переносился хорошо и практически без побочных эффектов. От 0,05-0,3% (1-7 случаев) отмечались тахикардия, тошнота, связанные больше с поведенческими реакциями, лабильностью и эмоциональностью пациенток. В нашей практике дозирование местного анестетика проводилось индивидуально: для купирования окклюзии цервикального канала достаточно Уг стандартной дозы препарата, а при большом объёме патологического очага и большей длительности вмешательства, применялось до 1,5 картриджей.

Таким образом, учитывая:

- выраженный, продолжительный обезболивающий эффект препарата в сочетании с достаточно хорошей переносимостью

- практическое отсутствие побочных эффектов

- возможность широкого применения в амбулаторных условиях при малых гинекологических и диагностических манипуляциях

- использование малого количества анестетика без каких-либо технических неудобств, способствующих более комфортному исполнению вмешательств и обеспечивающих качественный диагностический, лечебный и косметический эффект, можно рекомендовать данный

метод местноанестезиологического пособия в гинекологической практике

Список использованной литературы

1. Рудакова О.Б. Псевдозерозия шейки матки. Автореф. дисс. д.м.н.- Омск, 1996.

2. Новикова М.Ю. Лейкоплакия шейки матки. Авторефер. Дисс. к.м.н.-1995.

3. Шаров Д.В.. Стоматология. –М.: ВладосПресс, 2005.

4. Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н., Орехова Л.Д. Терапевтическая стоматология.- М.: Медицина, 2002.

5. Mathilde E. Boon, Albert J.H. Suurmeijer. The Pap Smear, Leiden, 1991.

Комбинация Таксотера и Герцептина в лечении больных местно-распространенных форм рака молочной железы с гиперэкспрессией HER2/NEU

Ли И.Н., Талаева Ш.Ж., Кайбуллаев Б.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы

Актуальность

При проведении химиотерапии у больных местно-распространенным процессом более 25 лет «золотым стандартом» является схема FAC (доксорубин+циклофосфан+5-фторурацил) [1,2]. В 1990-е годы таксаны продемонстрировали большую эффективность при проведении второй линии химиотерапии, чем доксорубин. Наилучший ответ был получен при лечении таксотером, который на сегодняшний день считается наиболее эффективным препаратом при лечении РМЖ [3,4]. Весьма важное свойство таксотера – отсутствие перекрестной устойчивости с другими лекарствами – доксорубином, цисплатином и др. При этом таксотер в сочетании с большинством препаратов способен приводить к синергизму опухолевого ответа, что позволило изучить многочисленные комбинационные режимы на его основе, в которых показана эффективность таксотера в режиме 100 или 75 мг/м² 1 раз в 3 недели у больных, получавших химиотерапию с включением антрациклинов [3,4]. Наиболее агрессивной формой заболевания считается HER-2 положительная опухоль молочной железы, когда на поверхности опухолевых клеток присутствует повышенное количество HER-2 белка. Также показана меньшая чувствительность HER-2+ опухолей к системной терапии (химиотерапии, эндокринотерапии) [5]. В связи с этим в последние годы интенсивно изучаются таргетные препараты, блокирующие факторы роста опухоли. Герцептин (трастузумаб) – рекомбинантные моноклональные антитела, которые специфически связываются на поверхности клеток с рецепторами HER-2. Помимо прямого антипролиферативного действия Герцептин способен инициировать выраженную реакцию антителозависимой клеточной цитотоксичности, специфически направленную на опухолевые клетки с гиперэкспрессией HER-2 [6,7]. При этом не выявлено зависимости клинической эффективности Герцептина от рецепторного статуса опухоли, количества пораженных лимфатических узлов, режимов используемой адъювантной химиотерапии [8]. Однако наиболее впечатляющими являются результаты его клинического применения в комбинации с цитотоксической химиотерапией. Показана высокая эффективность комбинации Паклитаксела с Герцептином, Доцетаксела с Герцептином при местно-распространенном и диссеминированном раке молочной железы [5-8]. Между тем, некоторые новые высокоэффективные режимы химиотерапии и эндокринотерапии в комбинации с Герцептином пока не изучены. Проблемой является комбинация Герцептина с антрациклинами, которые широко применяются при лечении местно-распространенного рака молочной железы и в адъювантных режимах после операции [5,6]. Однако комбинация Доксорубина с Герцептином повышает риск развития сердечной недостаточности. В связи с этим необходимой представляется разработка новых лечебных режимов химиотерапии без использования антрациклинов для лечения больных раком молочной железы с гиперэкспрессией HER-2.

Сүт безі рагінің жергілікті-жайылған түрімен ауырған науқастарға таксотер мен герцептинді қосып емдеу гиперэкспрессиямен HER2/NEU

Біздің зерттеу мақсатымыз сүт безі рагінің жергілікті-таралған түріне неоадъювантты терапияның режимдерінің неғұрлым тиімді жолын іздеу. Стандартты FAC- химиотерапия кестесімен салыстырғанда таксотер 5-ФУ құптауға болатын және альтернатив кесте болып табылады, әсіресе антрациклинді антибиотиктерге қарсы көрсеткіші бар науқастар үшін герцептинді қолданған 5 науқас гиперэкспрессия HER-2/neu көрсеткішінің тиімді әсерін 19,5% ке жақсартты, герцептин алған науқастармен салыстырғанда.

Целью нашего исследования стал поиск наиболее эффективных режимов неоадъювантной терапии местно-распространенных форм рака молочной железы. В сравнении со стандартной FAC-схемой химиотерапии, применение таксотера с 5-ФУ является приемлемой и альтернативной схемой у больных, имеющих противопоказания к антрациклиновым антибиотикам. Применение герцептина у больных с гиперэкспрессией HER-2/neu позволяет улучшить показатели объективного эффекта на 19,5% по сравнению с больными, не получавшими герцептин.

In this article were shown the results of using of Herceptine in complex treatment of advanced breast cancer, and the results of treatment are better on HER-2/neu positive tumor. In the case of using of Taxotere is given the best results than standards FAC-regimen.

Цель исследования

– оценка эффективности комбинированного использования таксотера с 5-ФУ в сочетании с Герцептином в неоадъювантном режиме химиотерапии у больных с гиперэкспрессией HER2/neu.

Материал и методы исследования

В исследование включено 58 больных местно-распространенным раком молочной железы в возрасте от 26 до 70 лет, средний возраст 49,4±8,9 лет. Больных репродуктивного возраста было 23, предклимактерического – 13, климактерического – 8, постклимактерического периода – 14. В процессе клинического обследования у 23 пациенток (39,6%) выявлена патология сердечнососудистой системы, проявлявшаяся нарушениями ритма (предсердная и желудочковая экстрасистолия) на ЭКГ и хронической сердечной недостаточностью I-III класс по NYHA.

Распределение больных по стадиям: T2N1M0 – 13 (22,4%), T2N2M0 – 10 (17,2%), T3N1M0 – 12 (20,7%), T3-4N1-

2M0 – 23 (39,7%). С целью морфологической верификации перед началом лечения проводилась трепан-биопсия опухоли. В 37 (63,8%) случаях выявлен инфильтративный протоковый рак, в 18 (31,0%) – инфильтративный дольковый рак и в 3 (5,2%) случаях – смешанный протоковый и дольковый рак. Кроме того, при гистологическом исследовании определяли степень злокачественности по Элстону-Элису: у 7 (12,1%) пациенток выявлена 1 степень злокачественности, у 23 (39,6%) – 2 степень, у 28 (48,3%) – 3 степень злокачественности.

ИГХ исследование HER2/neu-статуса было проведено всем больным. У 17 из 58 исследованных больных была выявлена гиперэкспрессия Her2/neu. Критерием назначения Герцептина явилось наличие высокой экспрессии HER2/neu (3+). В зависимости от режима неoadъювантной химиотерапии все больные были разделены на 4 группы:

1 группа (21 больная) получала неoadъювантную химиотерапию по схеме FAC (5-фторурацил 500 мг/м² в/в 1 день, доксорубин 50 мг/м² в/в 1 день, циклофосфан 500 мг/м² 1 день), повторение курса каждые 3 недели, оценка эффективности лечения после 4 курса;

2 группа (20 больных) получала схему TF (таксотер 75 мг/м² в 1 день + 5-фторурацил 500 мг/м² 1,2,3 дни), повторение курса каждые 3 недели, оценка эффективности лечения после 4 курса;

3 группа (8 больных) – неoadъювантная химиотерапия по схеме TF (таксотер 75 мг/м² в 1 день + 5-фторурацил 500 мг/м² 1,2,3 дни), курс лечения повторяли каждые 3 недели, эффективность лечения оценивалась после 4 курса.

4 группа (9 больных) получила лечение по схеме TF в сочетании с Герцептином в стандартном режиме – 4 мг/кг 1 доза, со второго введения – 2 мг/кг, еженедельно, до завершения 4 курсов лечения.

Хирургический этап лечения после неoadъювантной химиотерапии выполнялся через 2 недели после последнего курса. Качество жизни пациенток оценивалось по шкале Карновского до и после лечения.

Результаты лечения

Общее состояние больных во всех группах после завершения курсов химиотерапии улучшилось. Необходимо отметить, что показатели качества жизни, оцененные 0 степенью, повысились в 1,3 раза, а количество больных, состояние которых до начала лечения оценивалось 3 степенью, уменьшилось в 4,5 раза (таблица 1).

В результате проведенного лечения положительный объективный эффект в 1 группе больных (получавших лечение по схеме FAC) в целом был отмечен у 12 (57,1%) из 21 пациентки, из них полная регрессия наблюдалась в 2 (9,5%), а частичная – в 10 (47,6%) случаях. В группе с режимом TF общий ответ был получен у 17 (85%) из 20 женщин, при этом полная регрессия получена у 6 (30%),

Таблица 1 - Качество жизни больных раком молочной железы (по шкале Карновского)

Методы лечения	Этап	Степень активности			
		0	1	2	3
1 группа FAC – Her2/neu (-) (n=21)	до лечения	5 (23,8±9,2)%	9 (42,9±10,7)%	4 (19±8,5)%	3 (14,3±7,6)%
	после лечения	7 (33,3±10,2)%	9 (42,9±10,7)%	3 (14,3±7,6)%	2 (9,5±6,3)%
2 группа TF – Her2/neu (-), (n=20)	до лечения	6 (30±10,2)%	8 (40,0±10,9)%	3 (15±7,9)%	3 (15±7,9)%
	после лечения	8 (40±10,9)%	9 (45±11,1)%	3 (15±7,9)%	0
3 группа - TF – Her2/neu (+) (n=8)	до лечения	2 (25±19,2)%	3 (37,5±15,2)%	1 (12,5±15,2)%	2 (25±19,3)%
	после лечения	3 (37,5±19,2)%	4 (50±20,4)%	1 (12,5±15,2)%	0
4 группа. TF+ Герцептин – Her2/neu (+) (n=9)	до лечения	4 (44,4±18,7)%	3 (33,3±17,1)%	1 (11,1±13,2)%	1 (11,1±13,2)%
	после лечения	5 (55,6±18,7)%	4 (44,4±18,7)%	0	0
Итого (n=58)	до лечения	17 (29,3±5,9)%	23 (39,7±6,4)%	9 (15,5±4,7)%	9 (15,5±4,7)%
	после лечения	23 (39,7±6,4)%	26 (44,8±6,5)%	7 (12,1±3,9)%	2 (3,4±2,3)%

частичная – у 11 (55%) пациенток. В группе пациенток, не получавших Герцептин в неoadъювантном режиме положительный ответ отмечен более чем у половины больных (69,4%), тогда как в группе с включением Герцептина – в 8 случаях из 9 (88,9%) (таблица 2).

Таким образом, неoadъювантная химиотерапия у больных с местно-распространенным РМЖ, проведенная по стандартной схеме FAC (доксорубин + 5-фторурацил + циклофосфан) обеспечивает как улучшение качества жизни на 9,5%, так и нормализацию общего состояния, и в 57,1% случаев – регрессию опухоли на 50% и более. В тоже время применение схемы таксотер+5-фторурацил в неoadъювантном режиме у больных с местно-распространенным РМЖ позволило улучшить качество жизни на 15% и получить положительный эффект в 85%. Добавление герцептина в схему терапии пациенток с гиперэкспрессией HER-2/neu, позволило повысить объективный ответ на 19,5%, при этом у 3 больных добиться полной регрессии опухоли.

Чрезвычайно важной стороной комбинированной химиотерапии является переносимость ее больными. Поэтому одной из задач нашего исследования было изучение побочных эффектов используемых схем неoadъювантной химиотерапии. Токсичность комбинаций FAC и TF оценена у всех 58 больных согласно критериям ВОЗ. В целом обе схемы лечения переносились больными относительно хорошо, лишь в единичных случаях была редукция доз препаратов в связи с токсическими эффектами, но ни в одном случае лечение не было прекращено из-за развития побочных эффектов. Следует отметить, что переносимость обоих режимов была удовлетворительной. Из гематологических осложнений в основном встречались

Таблица 2 - Показатели эффективности неoadъювантной химиотерапии у больных с местно-распространенным РМЖ

Схема лечения	Число больных (n)	Степень регрессии абсолютные значения (%±m)			
		100 %	≥ 50 %	Стабилизация	Прогрессирование
1 группа FAC – Her2/neu (-)	21	2 (9,5±6,3)%	10 (47,6±10,8)%	8 (38,1±10,5)%	1 (4,8±1,1)%
2 группа TF – Her2/neu (-)	20	6 (30±10,2)%	11 (55±11,1)%	3 (15±7,9)%	-
3 группа TF – Her2/neu (+)	8	2 (25±15,3)%	3 (37,5±17,1)%	3 (37,5±17,1)%	-
4 группа TF+ Герцептин – Her2/neu (+)	9	3 (33,3±2,7)%	5 (55,6±16,5)%	1 (11,1±10,4)%	-

Таблица 3 - Оценка гематологической токсичности при неоадьювантной химиотерапии у больных с местно-распространенным РМЖ

Побочный эффект	FAC – 84 курса химиотерапии (n=21)			TF – 156 курсов химиотерапии (n=37)		
	Токсичность					
	общая	1-2 степени	3-4 степени	Общая	1-2 степени	3-4 степени
лейкопения	40 (47,6±5,4)%	23 (27,4±4,8)%	17 (20,2±4,3)%	98 (62,8±3,8)%	63 (40,4±3,9)%	35 (22,4±3,3)%
нейтропения	43 (51,2±5,4)%	31 (36,9±5,1)%	12 (14,3±3,8)%	81 (51,9±4,0)%	59 (37,8±3,8)%	22 (14,1±2,7)%
анемия	13 (15,5±3,9)%	11 (13,1±3,6)%	2 (2,4±1,6)%	33 (21,1±3,2)%	30 (19,2±3,1)%	3 (1,9±1,1)%
тромбоцитопения	3 (3,6±2,0)%	3 (3,6±2,0)%	-	6 (3,8±1,5)%	6 (3,8±1,5)%	-

лейкопения, причем более выраженное снижение лейкоцитов наблюдалось в группе больных, получивших лечение по схеме таксотер+5-фторурацил. Частота анемии и тромбоцитопении была умеренной, но чаще встречалась такая же, как при режиме FAC. Однако ни в одном случае гематологическая токсичность не явилась причиной прекращения лечения (табл. 3).

Из негематологической токсичности для больных из группы TF наиболее характерными были симптомы, связанные с мукозитами – стоматит, диарея, которые наблюдались в 32,7 и 17,9% случаев соответственно, в основном при развитии нейтропении. Так же в данной группе больных чаще развивались симптомы астении (60,9%), мышечные и/или суставные боли (16%), отеки (8,3%) и нейротоксичность (28,2%). Тошнота сопровождала около половины курсов химиотерапии Таксотером и 5-фторурацилом, но была контролируемой и только во время 9 (5,8%) циклов лечения была оценена 3-4 степенью токсичности, что потребовало проведения дополнительной антиэметической и дезинтоксикационной терапии. Эпизоды рвоты были единичными.

В группе больных с гиперэкспрессией Her2/neu функция миокарда тщательно мониторировалась на протяжении всего периода лечения. При включении в схему неоадьювантного лечения таргетного препарата Герцептин в группе 4 случаи изменений со стороны миокарда за время наблюдения зафиксированы не были.

Выводы

Применение таксотера с 5-ФУ в неоадьювантном режиме химиотерапии у больных с местно-распространенным

раком молочной железы позволяет получить противоопухолевый эффект в 78,6% случаев. Этот показатель на 21,5% выше по сравнению с показателями, полученными при проведении стандартной химиотерапии по FAC-схеме, что делает режим таксотер+5ФУ вполне приемлемым и альтернативным у больных, имеющих противопоказания к антрациклиновым антибиотикам.

Включение герцептина в схему химиотерапии, проводимую в неоадьювантном режиме у больных с местно-распространенным раком молочной железы с гиперэкспрессией HER-2/neu, обеспечивает возможность улучшения показателей объективного эффекта на 19,5% по сравнению с больными, не получавшими герцептин.

Список использованной литературы

1. Манзюк Л.В., Комов Д.В., Хайленко В.А. Комбинированное лечение местно-распространенного РМЖ // Вопросы онкологии. - 2001. - Т.47, №6. - С. 740-743.
2. Максимов К.В., Высоцкая И.В. и др. Лечение РМЖ Т3-4N0M0 стадий. Опухоли женской репродуктивной системы // Маммология. - 2008. - №1. - С. 20-27.
3. Семиглазов В.Ф. Применение таксотера в адьювантной и неоадьювантной терапии рака молочной железы // Современная онкология. - 2006, экстравыпуск.
4. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В. Таксаны в адьювантном и неоадьювантном лечении рака молочной железы // Вопросы онкологии. - 2004. - Т.50, №2ю. - С. 243-249.
5. Romond E., Perez E.A. Применение трастузумаба в сочетании с адьювантной химиотерапией у пациентов с операбельным HER-2/neu-положительным раком молочной железы // Фарматека. Онкология. - 2006. - №18/133. - С. 66-75.
6. Ганьшина И.П. Применение Герцептина в неоадьювантном и адьювантном лечении больных РМЖ с гиперэкспрессией HER-2 // Фарматека – ASKO. - 2007. - С. 13-14.
7. Ганьшина И.П. Гиперэкспрессия HER-2/neu – новые возможности в лечении рака молочной железы // Рак мол. железы. - 2005. - Т.13, №23. - С. 869-874.
8. Рукерт С., Руел И. Моноклональные антитела в лечении РМЖ: Трастузумаб // РМЖ. - 2005. - Т. 13, №23. - С. 1557-1567.

Лучевая терапия в алгоритмах комбинированных методов лечения больных раком прямой кишки

Кулиева Н.Г.

Национальный центр онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики

Актуальность

Несмотря на заметную тенденцию к росту выживаемости больных раком прямой кишки (РПК) в большинстве европейских стран, обусловленную совершенствованием хирургических методов, все заметнее усиливаются позиции комбинированных и комплексных видов лечения [2, 6, 7]. Обе эти тенденции обусловлены общемировым техническим прогрессом, открывающим возможности как к осуществлению радикальных, расширенных хирургических вмешательств, так и к внедрению новых технологий и программ при реализации курсов лучевой терапии (ЛТ), а также совершенствованию и расширению спектра применяемых при данной патологии химиопрепаратов. При этом особо актуализируется выбор адекватной тактики лечения, с наиболее обоснованной и рациональной последовательностью применения каждого из его компонентов [3, 5]. Это представляется реальным только при наличии лечебных схем, построенных на основании как теоретических, так и практических обобщений накопленного опыта в лечении данного контингента больных [1, 4, 5, 8].

Материал и методы

В течение последних двадцати лет в Национальном центре онкологии проводится мониторинг результатов комбинированных методов лечения больных РПК при различных объемах оперативных вмешательств, неотъемлемым компонентом большинства из которых является ЛТ. Проанализированы результаты лечения 750 больных РПК, среди них – 124 пациентам осуществлялось только оперативное лечение, а 626 – различные варианты комбинированного и комплексного. Соответственно, 84 больным РПК были произведены различные виды радикальных оперативных вмешательств, а 40 – паллиативных. В силу различных причин этим пациентам консервативная терапия не проводилась, и их данные послужили группой контроля. Средний возрастной состав больных колебался в пределах от 35 до 74 лет, отмечалось 412 мужчин и 338 женщин. Диагноз был гистологически верифицирован в 100% случаев, у большинства больных выявлена аденокарцинома. Исходя из постулата, что при сочетании двух и более методов лечения применение каждого из компонентов, а также их последовательность должны быть строго аргументированы, оценены различные варианты предоперационной ЛТ, послеоперационной – при радикальных операциях и при неудаленной опухоли, сочетания их с радиомодификацией и химиопрепаратами.

Исходя из объема основного метода – хирургического, больные были распределены на 2 группы: 478 больным была произведена радикальная операция, а 272 больным – паллиативная. В свою очередь, в зависимости от компонентов комбинированного метода данные группы больных РПК подразделялись на подгруппы. В первой группе контрольную подгруппу, в которой проводилось только оперативное лечение, составило 84 больных РПК, а во второй – 40. Дистанционная лучевая терапия проводилась в статическом режиме на аппаратах «РОКУС-М», «ТЕРАГАМ», «CLINAK», в большинстве случаев – с 4-х

В результате проведенного исследования выявлен ряд закономерностей, позволяющих на основании интегративной оценки клинических особенностей каждого пациента прогнозировать эффективность планируемого лечения. Учитывая мировую тенденцию к стандартизации, это позволит разработать адекватные программы для больных РПК, с координацией последовательности всех вышеуказанных видов лечения.

Radiotherapy in combined treatment modalities of patients with rectal cancer.

N.H.Quliyeva

National center of oncology, Ministry of health, Azerbaijan Republic

Results of this research revealed a number of regularities based on integrative assessment of clinical features of each patient what allows to predict efficacy of treatment. Taking into account the tendency to standardization this let us to work out adequate treatment programs for patients with rectal cancer.

полей, по «box» методике, ей предшествовало топодозиметрическое планирование с использованием систем «ХЮ», а в последние годы в ряде случаев – «FocalSim», с виртуальной симуляцией и обеспечением системы контроля пространственного распределения полей облучения, в том числе и с помощью системы «PORTAL VISION».

Таблица №1. Комбинированные методы лечения больных рпк при радикальных операциях

Группы	Число больных	Методы лечения
I	84	Радикальная операция
II	76	Лучевая терапия + радикальная операция РОД – 5,0Гр. * 5 – izoef. СОД – 40,0Гр.
III	72	СВЧ – гипертермия + лучевая терапия + радикальная операция РОД – 5,0Гр. * 5 – izoef. СОД – 40,0Гр.
IV	60	Лучевая терапия + радикальная операция РОД – 2,0Гр. * 5 – . СОД – 40,0Гр.
V	48	Лучевая терапия + 5 ФУ + радикальная операция РОД – 2,0Гр. * 5 – СОД – 40,0Гр. + 5ФУ-500мг * 3р. в неделю до 5,0г + радикальная операция.
VI	35	РОД – 2,0*5. – СОД – 40,0Гр. + ЭАС-100,мл.*3р. в неделю -7-10 вливаний + радикальная операция
VII	36	Радикальная операция + лучевая терапия РОД – 2,0-Гр. – СОД – 50,0- 60,0Гр.
VIII	32	Радикальная операция + ПХТ FOLFOX4.-VI курсов
IX	35	Радикальная операция + ЛТ + ПХТ РОД – 2,0Гр. – СОД -50-60 Гр. + .FOLFOX4 –VI курсов
Всего	478	

Таблица №2. Комбинированные методы лечения больных рпк при паллиативных операциях

Группы	Число больных	Методы лечения
I	40	Паллиативная операция
II	40	Паллиативная операция+ ЛТ РОД-2,0Гр.-СОД-60,0-65,0 Гр.
III	38	Паллиативная операция+ЛТ+ЭАС РОД-2,0 Гр-СОД-60,0-65,0 Гр.+р-рКлиона-100,мл*3р.в неделю-7-10 введений
IV	32	Паллиативная операция+ЛТ+5ФУ РОД – 2,0Гр.- СОД– 60,0-65,0 Гр.+5ФУ-500мг*3р.в неделю-5,0-7,0 г.
V	34	Паллиативная операция+ЛТ+ЭАС+5ФУ РОД –2,0Гр. * 5 -. СОД – 60,0-65,0 Гр.+р-р Клиона-100,0мл.*3р.в неделю-7-10введений+ 5ФУ -500,0мг*3р.в неделю-5,0-7,0г.
VI	42	Паллиативная операция+ПХТ FOLFOX4, FOLFOX6, FOLFIRI, 5 ФУ / лейковорин
VII	46	Паллиативная операция+ЛТ+ПХТ РОД – 2,0Гр.* 5 - СОД – 60,0-65,0Гр.+ПХТ, как в VI гр.
Всего	272	

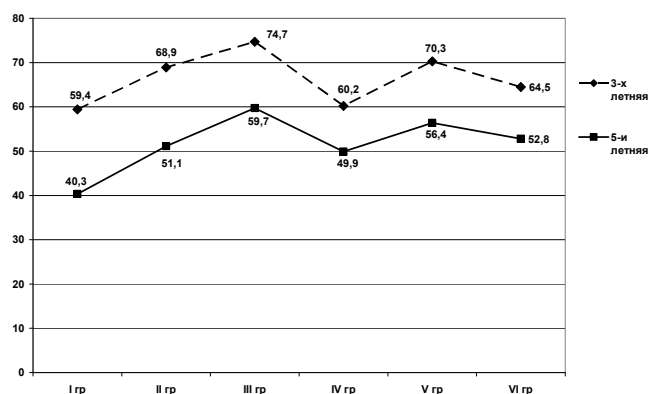


Диаграмма №1. Выживаемость больных рпк при различных методах предоперационной лучевой терапии

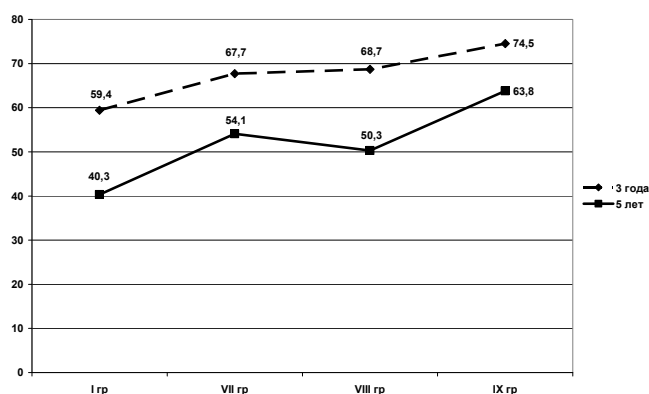


Диаграмма №2. Выживаемость больных рпк при различных методах адъювантной терапии после радикальных операций

Проводимые методы лечения в обеих подгруппах схематически представлены в таблицах № 1 и № 2.

Как видно из таблицы №1, в группе из 84 больных РПК проводилось только радикальное хирургическое вмешательство. Чаще всего – брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, реже – брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмы, внутрибрюшная резекция, операция Гартмана-Инаятова.

II группа включала 76 больных, которым в предоперационном периоде проводилась крупнофракционная ЛТ.

После соответствующей топодозиметрической подготовки сеансы дистанционной ЛТ осуществлялись в разовой очаговой дозе (РОД) – 5,0 Гр. в течение 5 дней ежедневно. Достигнутая за этот период времени суммарная очаговая доза (СОД) равнялась 25,0 Гр., что соответствовало СОД-40,0 Гр., подведенной в традиционном режиме. Последующее оперативное вмешательство производилось не позднее, чем через 3-5 дней, во избежание манифестации лучевых реакций.

В III группе из 72 больных предоперационное облучение в идентичном крупнофракционном режиме сочеталось с физическим радиомодифицирующим агентом – внутриполостной локальной СВЧ-гипертермией. Локальное нагревание опухоли проводилось на аппарате «Плот» с частотой колебания 915 МГц, с помощью гибких СВЧ-излучателей, введенных в соответствии с локализацией опухоли в прямой кишке. Температурно-экспозиционный режим поддерживался в течение 45 минут при 43оС. Манипуляция проводилась через день, за 0,5 часа до ЛТ: в 1, 3 и 5 дни недели.

В IV группе 60 больным РПК ЛТ проводилась в пролонгированном режиме - в РОД-2,0 Гр. ежедневно до СОД-40,0 Гр. – дозы излучения, теоретически достаточной для дезактивации наиболее чувствительных опухолевых клеток и как правило не вызывающей выраженных лучевых реакций со стороны здоровых тканей и организма в целом. Для реализации этой программы требовалось 4 недели, с последующим 1-2 недельным перерывом перед плановой операцией. Этот интервал соблюдался и в других группах, в которых применялся данный режим.

В V группу были включены 48 больных РПК, которым на фоне идентичного пролонгированного курса ЛТ вводился химиопрепарат-5-фторурацил, как радиомодификатор-синхронизатор клеточного цикла. Введение препарата осуществлялось внутривенно по 500 мг 3 раза в неделю, за 1-1,5 часа до облучения. Всего за курс вводилось 3,0-5,0 г 5-ФУ.

В VI группе 35 больным РПК, наряду с предоперационным облучением в пролонгированном режиме, также применялся химический радиомодификатор – электронакцепторные соединения (ЭАС) - как правило, раствор Клиона. За 0,5 часа до ЛТ внутривенно переливалось 100,0 мл раствора, 3 раза в неделю, всего 6-7 инфузий.

В VII группу вошли 36 больных, которым ЛТ проводилась после радикальной операции, как адъювантная. Целью ее проведения являлось стремление максимально снизить вероятность возникновения локально-регионарных рецидивов. ЛТ начинали не позднее 3-4-х недель после операции, осуществлялась она в статическом режиме, как правило – с 4-х полей, в РОД- 2,0 Гр. до СОД -50-60 Гр.

В VIII группу вошли 32 больных РПК, которым после радикальной операции осуществлялась только лекарственная терапия. Химиотерапия в этой группе больных проводилась как правило по схеме FOLFOX4 в количестве VI курсов.

В IX группе – 35 пациентам в послеоперационном периоде проводилось как лучевое, так и лекарственное лечение. В большинстве случаев постоперационная терапия была начата с курса ЛТ, которая проводилась в тех же параметрах, что и в I группе, а затем, после небольшого перерыва - от 1 до 3 недель, проводилось лекарственное лечение по схеме FOLFOX4.

В таблице №2 приводятся данные о методах лечения больных РПК после паллиативных операций.

I группу, где проводилась только послеоперационная ЛТ в указанных в таблице параметрах, было объединено 40 больных.

Во II группе, состоящей из 38 больных, наряду с облучением, применялись химические радиомодификаторы

– электронакцепторные соединения (ЭАС) – как правило, раствор Клиона-100,0 ml. За 0,5 часов до облучения внутривенно капельно переливался раствор ЭАС три раза в неделю, в большинстве случаев – 6-7 инфузий.

В III группе больных РПК из 32 человек, наряду с идентичным курсом облучения, применялся химиопрепарат 5-фторурацил, как радиомодифика-тор-синхронизатор клеточного цикла. Введение препарата осуществлялось внутривенно по 500 мг 3 раза в неделю, за 1-1,5 часа до облучения. Всего за курс вводилось в среднем до 5,0 г 5-ФУ.

В IV группе 34 больным ЛТ проводилась на фоне полирадио-модификации – с применением как ЭАС, так и 5-ФУ. Препараты вводились внутривенно капельно, поэтапно, через день. Как правило, между введениями радиомодифицирующих средств капельно переливались изотонические солевые растворы.

В V группу были объединены 42 больных РПК, которым после паллиативной операции проводились поэтапно курсы ПХТ (обычно 6-8 циклов) по схемам FOLFOX4, FOLFOX6, FOLFIRI, 5-ФУ/лейковорин.

В VI группу вошли 46 пациентов, которым в послеоперационном периоде проводился как полный курс ЛТ, так и поэтапные курсы ПХТ по вышеуказанным схемам.

Результаты и обсуждение

Все полученные данные были проанализированы и обработаны методами вариационной статистики. Критериями оценки полученных результатов были приняты результаты лечения, которые выражались в двух основных важнейших параметрах-выживаемости больных и качестве их жизни. Учитывались также количество и тяжесть интра- и послеоперационных осложнений, длительность реконвалесценции, отдаленное метастазирование и др. Выживаемость больных РПК при комбинированных методах лечения с радикально выполненным оперативным вмешательством представлена в диаграммах №1 и №2.

Анализируя полученные данные, можно было заключить, что предоперационная терапия улучшала показатели выживаемости во всех группах больных ($P < 0,05$). Из этой же диаграммы видно, что наиболее высокий процент 3-х и 5-летней выживаемости больных РПК после радикальных операций был в тех группах, где в предоперационном периоде проводилась крупнофракционная ЛТ в сочетании с локальной ГТ, а также – ЛТ в пролонгированном режиме при сочетании с химическим радиомодификатором 5-ФУ. Предоперационная ЛТ улучшила 3-х и 5-летние результаты, независимо от режима фракционирования дозы ионизирующего излучения, при тенденции к лучшим показателям 5-летней выживаемости при крупнофракционном курсе по сравнению с пролонгированным. Использование ЭАС в сочетании с ЛТ заметно не повлияло на эффективность лечения. Выраженная тенденция к улучшению результатов просматривалась при сочетании ЛТ с 5-ФУ, а наилучшие результаты предоперационной терапии с последующей радикальной операцией у больных РПК отмечались при сочетании ЛТ и локальной ГТ ($P < 0,05$).

При анализе представленных в диаграмме №2 данных о выживаемости больных РПК после адъювантной послеоперационной терапии больных РПК было выявлено, что при любой программе показатели годового выживаемости больных в ближайшие три года достоверно улучшаются по сравнению с чисто хирургическим методом. В то же время, не найдено значительных различий между показателями выживаемости больных VII и VIII групп, то есть при реализации одного вида послеоперационной терапии – лучевой или лекарственной. В IX группе, у тех больных РПК, которым осуществлялось поэтапное химиолучевое лечение, выжива-

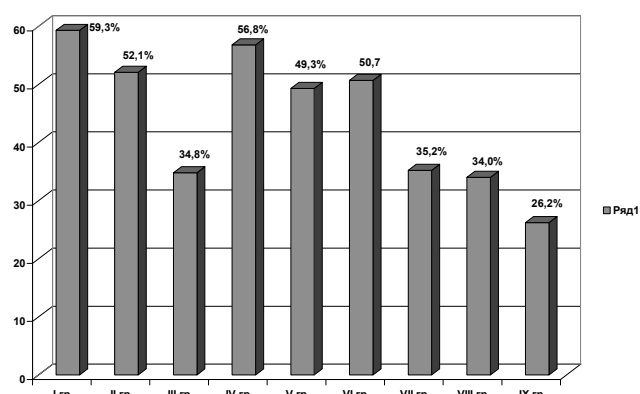


Диаграмма №3. Частота рецидивов после различных комбинированных методов лечения больных рпк при радикальных операциях (Сроки наблюдения – 3 года).

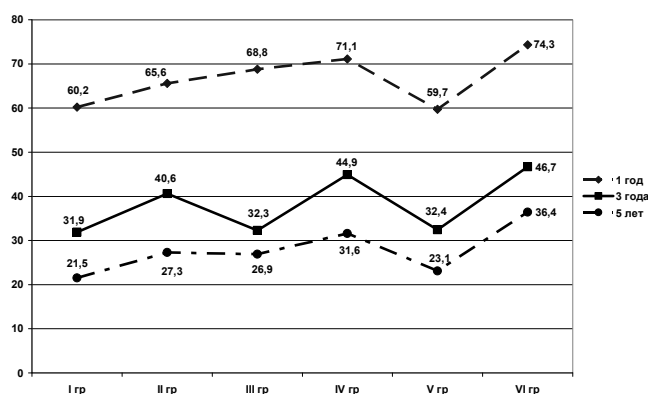


Диаграмма №4. Выживаемость больных рпк при различных видах лечения после паллиативных операций

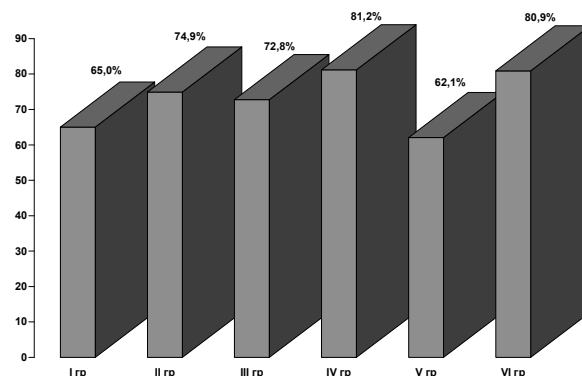


Диаграмма №5. Частота полной редукции болевого синдрома у больных рпк после комбинированных методов при паллиативных операциях

емость оказалась существенно выше ($P < 0,05$).

Одновременно было выявлено, что у больных РПК всех IX групп длительность жизни коррелировала со степенью инвазии стенки кишки, характеризующейся символом Т, наличием или отсутствием регионарных метастазов на момент начала лечения (N), локализацией опухоли в органе, степенью гистологической дифференцировки опухоли. Наилучшие результаты в рамках данных параметров отмечены при локализованных формах опухоли (стадии T2N0M0), расположении опухоли в проксимальных отделах кишки и высокой степени дифференцировки.

Между тем, данная закономерность проявлялась в различных группах больных неодинаково. Если при опухолевом процессе, соответствующем символу «Т2», различия показателей выживаемости в группах больных были не столь значительными, то при символах «Т3-4» отмечалась выраженная тенденция к улучшению при пред- и послеоперационной лучевой терапии и значительное повышение показателей 3-х и 5-летней выживаемости при предоперационной ЛТ в сочетании с СВЧ-гипертермией и 5-ФУ, и

постоперационной химиолучевой терапии по сравнению с чисто хирургическим методом ($P < 0,05$). При оценке показателей выживаемости больных РПК, в зависимости от величины символа N, были выявлены еще более выраженные различия. У всех пациентов с наличием в параректальной клетчатке метастазов в лимфоузлы, что характеризовалось символами N1-2, выживаемость резко снижалась по сравнению с больными, у которых эти метастазы отсутствовали (N0). Отмечалось некоторое улучшение результатов во всех группах больных, получавших постоперационную терапию, наиболее выраженное в IX группе, при сочетании лучевой и химиотерапии ($P < 0,05$).

У больных РПК с локализацией опухоли в дистальных отделах, наиболее высокая выживаемость отмечалась при предоперационной ЛТ в сочетании с СВЧ-гипертермией, при тенденции к улучшению в сочетаниях ЛТ и химиотерапии ($p \leq 0,05$).

Одновременно было выявлено, что частота рецидивов при различных вариантах лечения также была неодинаковой, данные представлены в диаграмме № 3.

При анализе отмечено, что у больных РПК в среднем частота рецидивов через 3 года после операции в 1,5 раза выше, чем у больных, которым после оперативного вмешательства проведены адекватные курсы лучевой или химиотерапии, и более, чем в 2 раза выше, чем у пациентов, получивших комплексное химиолучевое лечение в постоперационном периоде. Предоперационная ЛТ в пролонгированном режиме, а также ее сочетание с ЭАС на данный показатель заметно не повлияли, в то время, как сочетание с локальной СВЧ-гипертермией, 5-ФУ уменьшили его, соответственно, на 10% и 24,5%, а крупнофракционная ЛТ-на 7,2% ($p \leq 0,05$).

В диаграмме №4 приведены данные о выживаемости больных РПК после паллиативных операций, при неудаленной опухоли. Из больных, которым постоперационная терапия не проводилась, 1-й год прожили 15%, 3 года не прожил ни один, поэтому их данные в диаграмме не приводятся. Как видно из последней, применение монорадимодификации повышало 1, 3-х и 5-летнюю выживаемость у больных II и III групп по сравнению с чисто ЛТ и ПХТ ($P < 0,05$). Между тем, наиболее выраженный эффект был зарегистрирован при полирадиомодификации, а также сочетании ЛТ и ПХТ. Очевидно, это обусловлено тем обстоятельством, что, выступая синергистами и влияя на разные звенья механизма преодоления радиорезистентности, данные компоненты лечения при рациональном сочетании позволяют добиться более выраженных повреждений опухоли.

Обращают на себя внимание более высокие показатели выживаемости в группах, где ЛТ применялась в сочетании с электронакцепторными соединениями-ЭАС. Как указывалось выше, у больных с операбельными формами РПК значительного повышения результатов при таком сочетании не выявлено. Очевидно, данный факт объясняется наличием более значительной массы опухоли и, соответственно, количества гипоксичных клеток в неоперабельных опухолях, что повышает их чувствительность к ЭАС. Длительность безметастатического периода у больных местнораспространенным РПК после комбинированного лечения также была неодинаковой, и зависела от метода лечения. У больных РПК, включенных в данное исследование, на этапах динамического наблюдения наиболее часто манифестировали метастазы в печень, в паховые, бедренные и забрюшинные лимфоузлы, кости, у 1 пациента III группы – в головной мозг. В среднем длительность безметастатического периода составляла 16-18 месяцев. В то же время, у больных III, IV и VI групп отмечалась тенденция к его увеличению на 1,0-2,5 месяца соответственно ($p \leq 0,05$).

При оценке качества жизни больных РПК после паллиативных операций основополагающими синдромами мы посчитали: боль, общее астеническое состояние, серозно-кровянистые выделения из прямой кишки. В постоперационном периоде у 203 больных из 232 (87,5%) отмечался болевой синдром различной степени выраженности. К концу постоперационного лечения и в первый месяц динамического наблюдения, когда терапевтический эффект можно было считать реализованным, редукция болевого синдрома отмечалась у 167 пациентов, у 52 больных боли значительно уменьшились, у 13 человек заметных изменений не было, притом у 3-х из них болевой синдром расценивался как довольно интенсивный (соответственно – 71,7%, 22,7%, 5,5% - из них 1,3%).

При анализе было отмечено, что число больных с зарегистрированной полной редукцией болевого синдрома в группах больных было неодинаковым (диаграмма №5). Между тем, принимая во внимание цель столь масштабного по времени исследования – разработку оптимальных алгоритмов комбинированных методов лечения больных РПК, полученные результаты оценивались с учетом индуцируемых многокомпонентным лечением негативных реакций и осложнений – как локальных, так и со стороны организма больного. С этой целью на разных этапах проводился комплекс клинико-инструментальных исследований. Предоперационная терапия в наших наблюдениях ни разу не послужила поводом для отмены или значительной отсрочки планируемой операции, а в других группах больных РПК некоторое усиление локальных и общих негативных реакций являлось прогнозируемым явлением и поддавалось коррекции.

Выводы

Предоперационная и постоперационная терапия в рамках комбинированных методов лечения повышает выживаемость больных РПК после радикальных операций и уменьшает количество рецидивов. Наибольший эффект выявлен при сочетании ЛТ с СВЧ-гипертермией и 5-ФУ в предоперационном курсе, а также при сочетании ЛТ с циклами полихимиотерапии при постоперационной терапии;

Проведение постоперационной терапии при паллиативных операциях повышает выживаемость больных РПК и улучшает качество их жизни, наиболее эффективна полирадиомодификация- сочетание ЛТ с химиопрепаратами и ЭАС.

Литература

1. Барсуков Ю.А., Ткачев С.И., Олтаржевская Н.Д. и др. Полирадиомодификация в комбинированном лечении больных раком прямой кишки // Рекомендации к лечению -М., 2009, С. 45.
2. Гордеев С.С. American Society of Clinical Oncology (ASCO), 2010. Annual Meeting: Abstract, 3507.
3. Дворниченко В.В., Афанасьев С.Г., Шелехов А.В., Москвина Н.А. Лучевая терапия в комбинированном лечении рака прямой кишки (обзор литературы) // Сибирский онкологический журнал-2009-№1- С.72-77.
4. Помазкин В.И. Метаанализ влияния опыта и специализации на отдаленные результаты хирургического лечения колоректального рака. // Вопросы онкологии-2010-№3-Т.56- С.359-365
5. Bosser J.F. Chemotherapy with preoperative radiotherapy in rectal cancer // New Engl. J. Med. -2006-№355-Р.1114-1123.
6. Greenle R.T., Murray T., Bolden S. et al. Cancer Statistics // CA Cancer J.-Clin. 50-2007- p.7-33
7. Irvin T., Marriot S. The results of specialists and general surgeons in colorectal cancer surgery // Colorectal. Dis.-2004.- Vol.6 (Suppl.1). - P.55.
8. Wolff B.G., Fleshman J.W., Beek D.E. et al //The ASCRS. Text book of Colon and Rectal Surgery-2007.

Оценка эффективности применения НАПХТ при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря

Нурғалиев Н.С., Косанов М.С., Онғарбаев Б.Т., Ишкинин Е.И.

Введение

Заболеваемость мышечно-инвазивным РМП на сегодняшний день остается одной из главных проблем современной онкоурологии. Хирургический метод лечения является ведущим в лечении данной нозологии. Тем не менее, отдаленные результаты лечения являются неутешительными. Одними из основных причин получения неудовлетворительных результатов лечения являются позднее осуществление диагностики и несовершенство имеющихся методов терапии. Мышечно-инвазивный РМП в настоящее время рассматривается как диссеминированное заболевание. Более половины больных умирают от возникновения отдаленных метастазов, которые в большинстве случаев присутствовали в виде микрометастазов в начале развития инвазии опухоли. В данной ситуации применение только одного локального хирургического метода является недостаточным. При проведении адъювантной терапии РМП не выявлено убедительных данных улучшения безрецидивной и ОВ этой категории больных. Особого внимания заслуживает проведение предоперационной или неоадъювантной ХТ мышечно- инвазивного РМП.

Цель исследования

– улучшение результатов лечения мышечно-инвазивного РМП.

Материалы и методы

В рамках когортного исследования 125 больных инвазивным РМП был сделан кросекционный анализ. Из них мужчин 114, женщин - 11, Методом случай-контроль больные были разделены на 2 группы. Больным основной группы (n = 42) на первом этапе с лечебно-диагностической целью проводили ТУР мочевого пузыря: было выполнено удаление всей опухоли, видимой для глаза, или максимально возможного объема опухоли при обширном процессе. Материал отправляли на патоморфологическое исследование и в случае подтверждения инвазивного процесса проводили ИГХ-исследование. Показаниями к применению предоперационной ХТ служило наличие верифицированного инвазивного РМП с отсутствием клинических признаков иноперабельности процесса, а также гематологические и биохимические показатели, допускающие проведение системной ХТ. Гистологическая форма РМП в основном была представлена уротелиальной карциномой различной степени дифференцировки, преобладала умеренно дифференцированная форма. Пациентам проводили 2 курса неоадъювантной. ПХТ по схеме гемзар в дозе 1000 мг/м² в 1-й день и 8-й дни + цисплатин – 75мг/м² в 1-й день. Курс повторяли через 3 нед. Через 3 нед после проведения 2-го курса неоадъювантной терапии выполняли оперативное лечение – радикальную цистэктомию с различными вариантами деривации мочи.

Больным контрольной группы, (n = 83) выполняли оперативное лечение – радикальную цистэктомию с различными вариантами деривации мочи.

Қазіргі кезде операция алдында немесе неоадьювантті ХТ инвазиялық-бұлышқетті емдеу үшін РМП. Науқастардың негізгі тобы (n = 42) бірінші сатыда диагностикалық-ем жүргізу мақсатымен несеп қуығына ТУР жүргізілді, артқы 2 курс неоадьювантпен қосқанда. ПХТ гемзар кестесі бойынша дозасы 1000 мг/м² 1-ші күні және 8-ші күндері + цисплатин -75 мг/м² 1-ші күні. 3 аптадан кейін 2-ші курс жүргізіліп, неоадьювантті терапия орындалды.

Жедел емдеу – радикальді цистэктомия әр түрлі варианттар мен зәр деривациялары. Бақылау тобындағы науқастар, (n = 83) жедел ем қолданды – радикальді цистэктомия. Негізгі топтағы тірі қалу нәтижесінің көрсеткіші – 78,6% бақылау тобы - 69,9%. Жақсы қорытынды НАПХТ алғандар. Науқастардан РМП алынды, мынадай оқиғаларда егер ісік оқшауланып бұлышқет көлемінен асып кетсе (88,5% - негізгі, 75,9% - бақылау тобында).

Больным основной группы (n = 42) на первом этапе с лечебно-диагностической целью проводили ТУР мочевого пузыря с последующими 2 курсами неоадъювантной ПХТ по схеме гемзар в дозе 1000 мг/м² в 1-й день и 8-й дни + цисплатин – 75мг/м² в 1-й день. Через 3 нед после проведения 2-го курса неоадъювантной терапии выполняли оперативное лечение – радикальную цистэктомию с различными вариантами деривации мочи. Больным контрольной группы, (n = 83) выполняли оперативное лечение – радикальную цистэктомию. более высокие результаты общей выживаемости в основной группе - 78,6%, в контрольной- 69,9%. Лучшие результаты применения НАПХТ получены у больных РМП в случае если опухоль локализована в пределах мышечной оболочки (88,5% - в основной, 75,9% - в контрольной)

Now preoperative or neoadjuvant chemotherapy actually for treatment of muscle-invasive bladder cancer. Study group (n = 42) in the first stage of treatment was performed TUR of bladder; then conducted 2 courses of neoadjuvant. PCTs by scheme: Gemzar at a dose of 1000 mg/m² day 1 and 8 th days and cisplatin - 75mg/m² in the 1 st day. The course was repeated after 3 weeks. 3 weeks after the last course of neoadjuvant therapy are performed surgical treatment - radical cystectomy with various urinary diversion. Patients in the control group, (n = 83) performed surgical treatment - radical cystectomy with various urinary diversion. Better results in overall survival are show in the study group - 78,6%, in control group - 69.9%. Neoadjuvant chemotherapy demonstrated the decrease in the number of postoperative complications and mortality. Significantly NAPHT proven to be effective only in stage II, if the tumor is localized within the muscular layer (88,5% - in the study group, 75,9% - in control group). The data obtained justify further study of the efficacy of neoadjuvant chemotherapy

Функции дожития

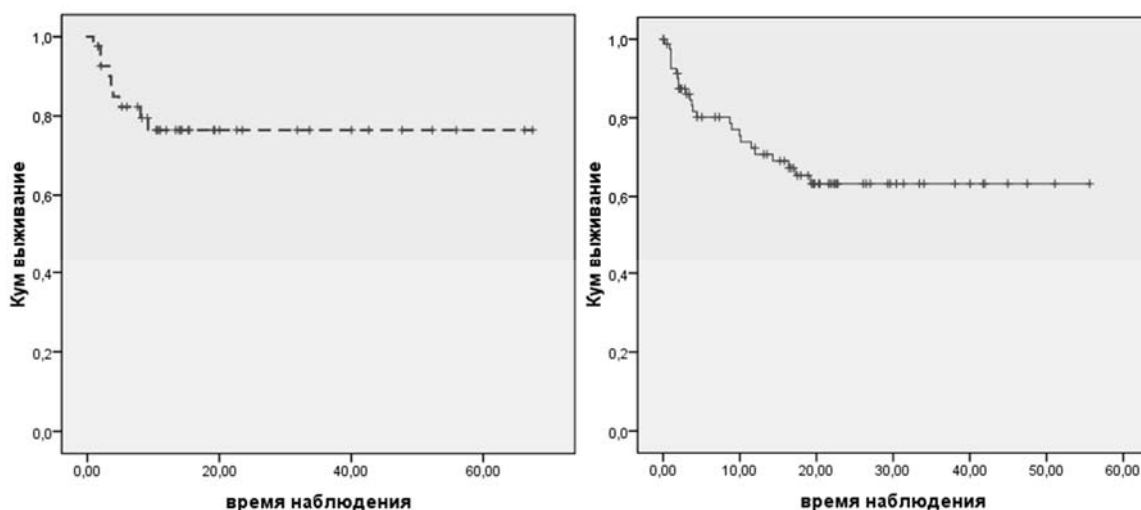
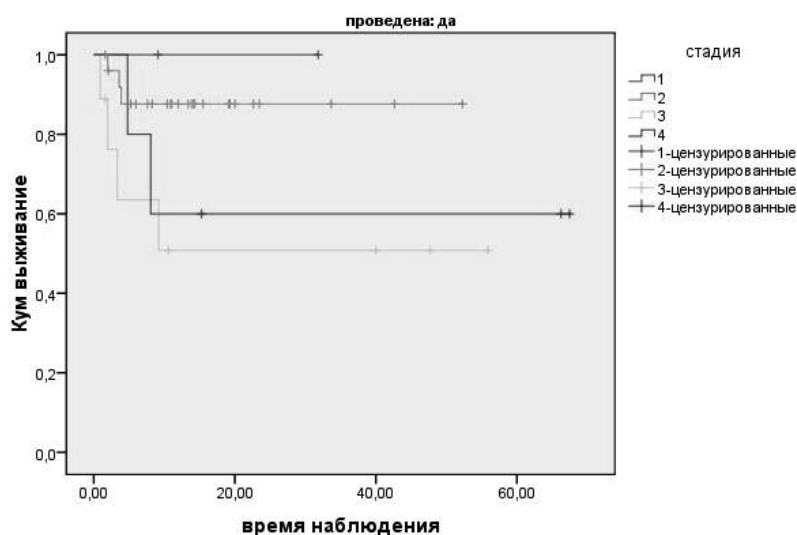


Рисунок 1, Рисунок 2. НАПХТ + радикальная цистэктомия (n = 42) радикальная цистэктомия (n = 83)

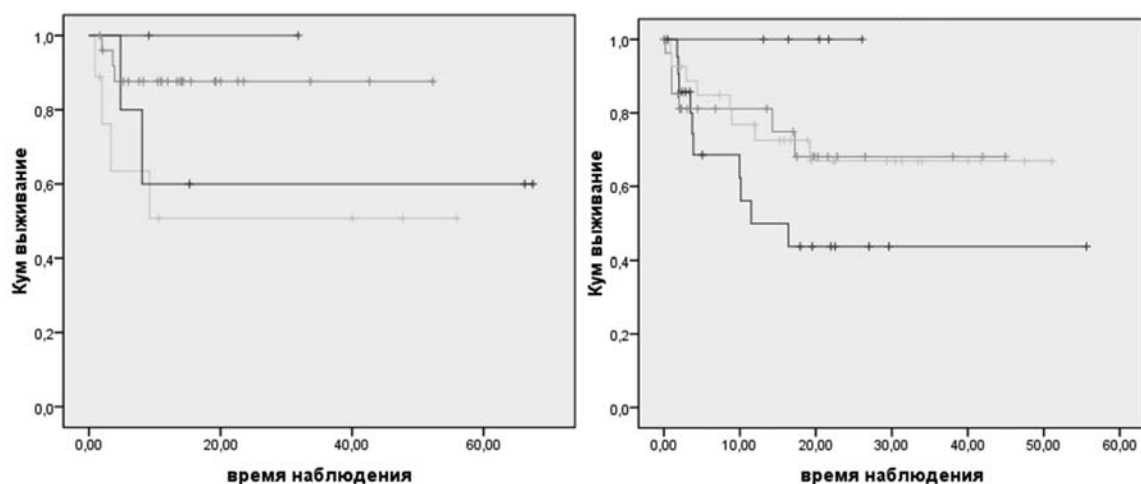


Рисунок 3, Рисунок 4. НАПХТ + радикальная цистэктомия (n = 42) радикальная цистэктомия (n = 83)

Результаты

Всем больным основной группы после осуществления 2 курсов неoadъювантной системной ХТ проводили контрольное комплексное обследование. Выраженных осложнений при проведении лечения, требующих отмены ХТ, не выявлено. Послеоперационной летальности в данной группе больных не зарегистрировано. Пациентам

с T3 и T4, а также с наличием метастазов в регионарные ЛУ продолжено проведение системной ХТ в адъювантном режиме по той же схеме.

В зависимости от проведенной НАПХТ более высокие результаты общей выживаемости в основной группе - 78,6%, в контрольной - 69,9% представлена на (рис 1,2). При сравнении показателей выживаемости в зависимости от стадии опухолевого процесса (рис3,4) достоверно до-

казана эффективность НАПХТ только во II стадии (88,5% - в основной, 75,9% - в контрольной), показатели выживаемости при III и IV стадиях хуже чем в контрольной, что свидетельствует о неэффективности проведения НАПХТ у больных местно- распространенным раком (T3, T4, N+).

Выводы

Использование неoadъювантного подхода в лечении мышечно-инвазивного РМП является перспективным путем улучшения отдаленных результатов. На данный момент проведены исследования непосредственных результатов лечения. В ходе осуществления неoadъювантной ПХТ по данной схеме продемонстрировано отсутствие увеличения числа послеоперационных осложнений и летальности. Лучшие результаты применения НАПХТ получены у больных РМП в случае если опухоль локализована в пределах мышечной оболочки (стадия II). Полученные данные оправдывают дальнейшее изучение эффективности применения неoadъювантной ХТ.

	НАПХТ + радикальная цистэктомия (n = 42)	радикальная цистэктомия (n = 83)
Средний возраст	54,9 (42-70л)	58,7 (31-82г)
Среднее время наблюдения после радикальной цистэктомии	18,17 мес	15,48 мес
Стадия, (выживаемость, %)		
Стадия I	2 (100%)	5 (100%)
Стадия II	26 (88,5%)	29 (75,9%)
Стадия III	9 (55,6%)	27 (70,4%)
Стадия IV	5 (60%)	22 (54,5%)
Всего	42 (78,6%)	83 (72,8%)
N+	5 (11,9%)	16 (19,3%)
M+	2 (4,8%)	4 (4,8%)
Локорегионарный рецидив	1 (2,4%)	4 (4,8%)
Степень гистологической дифференцировки		
G1	4 (9,5%)	4 (4,8%)
G2	26 (61,9%)	48 (57,8%)
G3	10 (23,8%)	28 (33,7%)
плоскоклеточный рак и аденокарцинома	2 (4,8%)	3 (3,6%)
Варианты деривации мочи		
Операция по Хаутману	26 (61,9%)	31 (41%)
Операция по Стюдеру	7 (16,7%)	11 (13,7%)
Илеумконduit по Бриккеру	4 (9,5%)	23 (27,7%)
Уретерокутанеостомия	4 (9,5%)	12 (14,5%)
Гетеротопический мочево й пузырь	1 (2,4%)	3 (3,6%)
Осложнения		
Восходящий пиелонефрит	8 (19,0%)	6 (7,2%)
Мочевые свищи	4 (9,5%)	12 (14,5%)
Парез кишечника	2 (4,8%)	2 (2,4%)
Несостоятельность кишечных анастомозов	1 (2,4%)	1 (1,2%)
ТЭЛА	1 (2,4%)	1 (1,2%)
ОПН	-	3 (3,6%)
кровотечение	-	1 (1,2%)
Острая сосудистая недостаточность	-	2 (2,4%)
Несостоятельность резервуаро- мочеточникового анастомоза	-	2 (2,4%)
Острый орхит	-	1 (1,2%)

Применение схемы R CHOP-14 при лечении В-клеточных индолентных неходжкинских лимфом

Каракулов Р.К., Габбасова С.Т., Сагиндыков Г.А., Асанов А.А., Насипов Б.А., Джазылтаева А.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Заболеваемость неходжкинскими лимфомами (НХЛ) значительно выше в развитых странах (увеличилась более чем на 50% за последние 20 лет). Злокачественные лимфомы в Республике Казахстан в структуре онкопатологии занимает 8 ранговую позицию составляя 4,2 на 100 000 населения. В РК ежегодно регистрируется около 500 первично диагностированных НХЛ, около 350 погибает в первый год регистрации. Самые высокие показатели заболеваемости этой формой опухоли установлены в СКО (16,3‰), Павлодарской - 14,2‰, а по смертности – Мангыстауская - 7,6‰, СКО – 7,1‰, Павлодарской – 7,1‰ и ВКО – 7,0‰ областей.

Пятилетняя выживаемость больных НХЛ в среднем не превышает 48-50% (Арзыкулов Ж.А. и др, 2009).

Выделены две основные группы НХЛ: высокой степени злокачественности (агрессивные) и низкой степени (индолентные), последние составляют около 60% из всех лимфом. Индолентные лимфомы характеризуются длительным течением с периодами рецидива и ремиссии, а также устойчивостью к химиопрепаратам.

При рецидивах и резистентных формах НХЛ весьма перспективным оказалась применение моноклональных антител (МКА) – мабтеры, особенно при фолликулярной лимфоме. Пятилетняя выживаемость больных с индолентной формой НХЛ широко варьирует в зависимости от морфоиммунологического варианта опухоли. Наибольшая эффективность достигнута у больных фолликулярными лимфомами – 60,0%, при средней продолжительности ремиссии 11 мес. В нескольких исследованиях добавление мабтеры к режиму СОР и CHOP позволило добиться полной ремиссии у 75,0% больных (Поддубная И.В., (2004).

Нами впервые при лечении индолентных форм НХЛ использована модернизированная схема R CHOP-14.

Цель исследования

- улучшение результатов лечения больных с индолентной формой НХЛ.

Дизайн и методы исследования

- методом информированного согласия пациентов и рандомизации проводилось квазиисследование (n=15)) с индолентной формой НХЛ П-1У А и Б стадий заболевания проводилось лечение с применением модернизированного метода схемы ПХТ R CHOP-14 (ритуксимаб по 350 мг/м², 1 дни, ЦФ 750 мг/м², доксорубин 50 мг/м², винкристин 1,4 мг/м², 2 день, преднизалон 40 мг/м² внутрь 1-5 дни), цикл повторяется через каждые 14 дней. Всего проведено 6-8 курсов ПХТ.

Контрольную группу эквивалентную основной составила (n=15) пациентов с индолентными формами НХЛ П-1У А и Б стадиями процесса, получавшие ПХТ по схеме CHOP 14. Всего 6-8 введений. Выборка была квотированная.

Размеры первичной опухоли, данные рентенотомографических исследований, КТ и ЯМРТ, УЗИ, а также ОАК, биохимический анализ крови (ЛДГ и щелочная фосфата) и

RCHOP-14 кестесін В-жасаушы индолентті ходжкин емес лимфоманы қолдану

Мақсаты: Ходжкин емес лимфоманың индолентті түрін емдеу нәтижесін жақсарту.

Жұмыста 15 науқасты лимфоманың индолентті түрімен RCHOP-14 кестесі қолданылып, 80% науқаста толық ремиссия алынды, 20% - жартылай ремиссия, ауру қайталануы болған жоқ. Ал, бақылау тобында емдеу нәтижелері былай: толық ремиссия- 58%, жартылай ремиссия- 42,6 %, аурудың қайталануы- 26% құрады.

Применение схемы RCHOP-14 при лечении В-клеточных индолентных неходжкинских лимфом.

Целью исследования - улучшение результатов лечения больных с индолентной формой НХЛ.

Материалом исследования служили истории болезни 15 пациентов с индолентной формой НХЛ, получавшие ПХТ по схеме R CHOP-14 (основная группа), в качестве контроля служили больные (n=15), получавшие ПХТ по схеме CHOP 14.

Результаты наших исследований показывают, что в основной группе полная ремиссия процесса составила 80,0%, частичная - 20,0%, прогрессирование процесса не было. В контрольной группе результаты лечения оказались таковыми – 58,0 и 42,0%, соответственно, прогрессирование – у 26,0% больных. В основной группе качество жизни больных составило 2 балла.

Application scheme RCHOP-14 in the treatment of indolent B cell non-Hodgkin's lymphoma.

Karakulov R.K., Gabbasova S.T., Sagindykov G.A., Asanov A.A., Nassipov B.A., Kossenkov N.YU.

The aim of our study was to improve the treatment results of patients with indolent form of non-Hodgkins lymphoma.

Material studies were histories cases of 15 patients (n=15) with indolent form of non-Hodgkins lymphoma treated with polychemotherapy according to the scheme RCHOP-14 (main group) and patients who received polychemotherapy scheme CHOP-14, served as control. Our results shows that in the experimental group achieved a complete remission 80%, partial 20% of patients. Progression of the process is not registered. In the control group, the results have been established, 58% and 42.0%, respectively, the progression from 26.0% of patients. In the study group, the quality of life of patients was 2 points.

активность больного по шкале Карновского использовали в качестве первичных точек.

Вторичные конечные точки включали степень регрессии опухолей (полная, частичная регрессия) на основе данных уменьшения размеров опухоли, купирования симптомов

Таблица 1- Результаты лечения больных индолентной формой НХЛ

Количество больных	Полная ремиссия	Частичная ремиссия	Прогрессирование процесса
Основная (n=15)	12 (80,0%)	3 (20,0%)	0 (0,0%)
Контрольная (n=15)	6 (40,0%)	5 (34,0%)	4 (26,0%)
Примечание: p<0,05			

интоксикации, улучшения данных рентгенологических исследований, КТ, ЯМРТ, УЗИ, показателей ОАК, биохимических исследований и степень активности по шкале Карновского.

Критерии включения: объектом исследования служили 15 пациентов (основная группа) с НХЛ П-1У А и Б стадиями заболевания с низкой степени злокачественности, находящиеся в отделении гемобластозов КазхНИИИиР. Из 15 больных мужчин составили 9, женщин – 6, возраст пациентов колебался от 21 до 72 лет. Всем пациентам было проведено гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследования. У 10 пациентов было зарегистрирована В-клеточная лимфоцитарная лимфома, у 2-х пациентов – экстранодальная MALT лимфома, в 3-х случаях – нодальная фолликулярная лимфома (1-П тип). При ИГХ исследований у всех больных было установлено экспрессия в опухоли CD 20 (+) антигена. Пациентами из основной группы была проведена ПХТ по схеме R CHOP – 14 (мабтера 375 мг/м², 1 день ЦФ 750 мг/м², винкристин 1,4 мг/м², адрим 40 мг/м² (2 день), преднизалон 40 мг/м², 1-5 дни в/в. Больные контрольной группы получали ПХТ по схеме CHOP 14 (15 пациентов).

Оценка безопасности - предлагаемый метод воздействия (ПХТ по схеме R CHOP-14. переносили удовлетворительно, аллергических реакций не зарегистрированы.

Статистический анализ проведен с использованием статистической программы SPSS 10.0 для Windows.

Результаты и их обсуждение

Как видно из таблицы в основной группе, где пациенты получали ПХТ по схеме R CHOP – 14 полная ремиссия процесса достигнута у 80,0% пациентов, частичная – 20,0%, прогрессирование процесса не зарегистрировано. В контрольной группе (CHOP 14) полная ремиссия процесса была установлена только у 40,0% больных, частичная – у 34,0%, а прогрессирование – у 26,0% больных (p < 0,05).

В одном из первых клинических исследований 2 фазы мабтеры в комбинации с химиотерапией при вялотекущей НХЛ, у 28 пациентов установили объективный эффект (полная ремиссия составила 58,0%, частичная – 42,0%), причем медиана времени до прогрессирования заболевания превышала 7 лет (Czuczman et.al.2003).

Таким образом, сравнительный анализ результатов лечения с применением различных протоколов (GELA LNH) показывает преимущества режима мабтера плюс CHOP-14. Общая 2-х летняя выживаемость в группе мабтера плюс CHOP составила 70,0%, а в группе CHOP только 57,0%. В основной группе качество жизни больных повысилось на 2 балла, против контроля, где таковое составило 0-1 балл.

Список использованной литературы

1. Арзыкулов Ж.А и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2009 г.- Алматы, 2010.
2. Поддубная И.В. Лечение индолентных неходжкинских лимфом //Практическая онкология.-2004.- Т.5, №3.
3. Czuczman A. et.al. Rituximab in combinatio with CHOP of fludarabine in low-grade lymphoma // Semin.Oncol- 2003.-Vol.29.-P. 36-40.

Ультразвук – от диагностики к лечению (HIFU терапия)

Құлтаев А. С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Традиционным методом лечения опухолей считается хирургическая операция, лучевая терапия, химиотерапия. Однако, существуют ряд злокачественных новообразований, когда хирургическое вмешательство имеет ряд противопоказаний, высокий уровень осложнений и смертности, и не приводит к увеличению выживаемости (например: рак поджелудочной железы, опухоли забрюшинного пространства, метастазы печени).

Среди альтернативных методов лечения самым перспективным и современным, в котором объединены последние технологии диагностики и лечения, является фокусированная высокоинтенсивная ультразвуковая абляция (HIFU) опухолей.

HIFU, что означает High Intensity Focused Ultrasound — высоко интенсивный фокусированный ультразвук, изначально разрабатывался как метод лечения ДГПЖ (доброкачественная гиперплазия предстательной железы).

Принцип действия лечебного высокоинтенсивного фокусированного ультразвука не отличается от диагностического и основан на способности ультразвуковой волны проникать через ткани, не повреждая их. Однако создаваемая за счет специальной линзы фокусировка вызывает в небольшой зоне повышение температуры, достаточной для развития некроза (очага повреждения) патологического образования.

Для термоабляции ткани необходима мощность импульсов более 100 ватт на импульс. Термическое энергетическое воздействие происходит в течение менее одной секунды, хорошо управляется (предварительно проводится центрация поля подлежащего деструкции, без повреждения окружающих тканей) и регулируется в дозах. Температура немедленно повышается до 70 — 100°C, что приводит к термоабляции тканей. Окружающие ткани — в радиусе 2 мм от зоны фокусировки остаются неповрежденными. Зоны фокусировки небольшие (2,0мм x 3,0мм x 30,0мм), выполняемые одно за другим воздействия позволяют увеличить объем ткани, подвергшейся абляции. В дальнейшем ткань, подвергшаяся воздействию HIFU постепенно сморщивается и замещается фиброзной, образуется рубец.

Возможно ослабление или поглощение сигнала HIFU окружающими тканями. Плотность и состав межлежащей ткани может влиять на мощность HIFU. Кость или кальцификаты могут значительно ослаблять или даже отражать сигнал HIFU. Хотя при саркомах происходит деминерализация костной ткани, в зонах поражения отражения сигналов уменьшаются. Имеются данные при лечении данной нозологии с единичными случаями сохранения конечностей пациентов. В клиниках Казахстана так же, ведутся лечебные воздействия hifu при саркоме. Результаты: снятие болевого синдрома и уменьшение объема опухоли. Воздух не только источает сигнал HIFU, но и препятствует визуализации процесса. Проведена попытка лечения большого с периферическим раком легкого, результаты превзошли ожидаемые.

Процедура HIFU одобрена в странах Европы, Китае, Японии, Карибском бассейне, Мексике и странах Латинской Америки. HIFU терапия входит в стандарты лечения более 60 странах мира, включая США, страны ЕС, Японию, Россию пролечено более 50000 больных с различными локализациями

Ультрадыбыс – диагностикадан, емдеуге.

(Жоғары интенсивті ультрадыбыспен емдеу)

Құлтаев А. С

Жоғары интенсивті ультрадыбыспен ісіктерді емдеу, бүгінгі күннің емдеу және диагностикалау технологияларының ішіндегі тәсілдерін біріктірудің ең соңғы әдістемесі.

Жоғары интенсивті ультрадыбыс қатерлі және қатерсіз ісіктердің пайда болған жеріне қарамастан бұзу арқылы әсер етеді.

HIFU- терапиясы клиникалық жағынан алғанда, өте әсері мықты, экономикалық тиімді және қауіпсіз, ал кейбір жағдайларда жалғыз емдеу тәсілі болып табылады.

Среди альтернативных методов лечения самым перспективным и современным, в котором объединены последние технологии диагностики и лечения, является фокусированная высокоинтенсивная ультразвуковая абляция (HIFU) опухолей.

Принцип действия лечебного высокоинтенсивного фокусированного ультразвука – разрушение патологического образования, как доброкачественного, так и злокачественного, не зависимо от локализации.

HIFU- терапия является клинически эффективным, безопасным, экономический выгодным, а в ряде случаев единственным методом лечения пациентов.

циями (Xiong L. et all. 2007., Li JX et all. 2007). Имеются множество (более 3000) публикации данных различных центров мира за последние 15лет (Карпов О. Э., 2009г, Аляев Ю. Г 2010г). В России работы ведутся в НМХЦ им. Н. И. Пирогова, Клинике урологии ММА им. И. М. Сеченова, в НИИ урологии и 7 онкологических диспансерах) и т. д. Имеются публикации Российских ученых по научным результатам 6 летней работы. В Китае hifu-терапия проводится в 400 клиниках, и их количество растет. Только в Китае пролечено более 40000 больных. 80% всей HIFU установок в мире продукция Китайских заводов.

В Казахстане имеются 2 стационарных аппарата с высокоэнергетическим фокусированным ультразвуком (HIFU), в ННМЦ (JC-100), в мед. центре АЛАС и К (FEB-BY02). В Республике за 1 год и 3 месяца на данных аппаратах пролечено 263 больных, при мощности аппаратов позволяющих пролечить 1200 – 1500 больных в год. Малое количество больных вероятно из-за неосведомленности граждан, за последние 1,5 года в республике проведено всего 2 научно-практических конференции по HIFU- терапии (организаторы АЛАС и К).

На конференциях доложили свои научные результаты представители крупных научных центров, НИИ и клиник: профессор Каприн А. Д., академик Терновой С. К; проф. Бурдина Л. М; проф. Серяков А. П; проф. Шаплагин Л. В г.Москва; проф. Тютин Л. А. г.Санкт-Петербург; проф.

Фазылов А. А. г.Ташкент; член. корр., Чоенозов Е. Ц; проф. Величко С. А. г. Томск.

В лечении больных на аппарате «JC-200» (рисунок 1), участвуют 2 врача специалиста HIFU, 2 медсестры + врач анестезиолог, медсестра анестезистка, санитарка, инженер. Процедура в большинстве случаев проводится под общим наркозом, длительность до 8 часов (большие объемы патологических очагов, в связи с поздней обращаемостью).

Работа на аппарате FEP-BY02 (рисунок 2) проводится одним оператором (врачом УЗИ) контроль лечебного процесса проводится на УЗ аппарате «Logiq-5 PRO», визуализация всего процесса идеальная. Центрация и контроль лечебного процесса проводятся четко.

HIFU терапия - бурно развивающаяся технология, которая быстро охватывает новые области применения в медицине, благодаря своей высокой эффективности, отсутствием побочных эффектов и невысокой стоимости. В ряде случаев HIFU-терапия является единственным методом лечения, который позволяет сохранять жизнь пациенту.

В настоящее время в мире существуют более 20 коммерчески доступных систем для HIFU терапии: Sonablate (США), FocusSurgery (США), InSightec (Израиль), Philips (Нидерланды), Ablatherm (Франция), и более 10 производителей в Китае (80 % мирового рынка). Кроме крупных университетских центров Токийского, Сеульского и Миланского университетов эта система используется более чем в 500 госпиталях по всему миру. В последнее время, организованы более 50 частных HIFU центров в Северной и Южной Америке, Японии, Южной Корее.

Для организации HIFU-центра не требуется специализированных больших помещений, сложной технической подготовки и развертывания стационара. Это означает, что для создания HIFU-центра достаточно помещения 25,0 – 75,0 кв.м. В день на одной установке «JC-100» (в ННМЦ) можно проведение лечения 2-8 больных, в на установке FEP-BY (в АЛАС и К), в амбулаторных условиях возможно проведение лечения 10-15

Стоимость HIFU лечения в пациентах.
странах мира.

Страна	\$США
Южная Корея	15000-20000
Япония	25000-30000
США	30000-50000
Великобритания	40000-60000
Израиль	40000-80000
Казахстан	
ННМЦ	3000
«АЛАС и К»	2000-7000

Визуализация в режиме реального времени позволяет оператору моментально оценивать реакцию тканей во время проведения HIFU - абляции. Оператор может прервать процесс в любой момент без вреда для пациента. На установке «JC-100» (в ННМЦ) один преобразователь – «верхний», поэтому имеются ограничения в лечении нескольких локализаций. На установке FEP-BY02 (в АЛАС и К), имеются

2 преобразователя: «верхний» и «нижний», с матричными датчиками 4D. Используя данное преимущество в лечении больных заболеваниями предстательной железы, прямой кишки и шейки матки.

В Казахстане неуклонно растет заболеваемость онкопатологией. Планируются скрининговые программы по выявлению: колоректальной онкозаболеваемости, рака предстательной железы, рака желудка. Проведенная программа безусловно повысит заболеваемость, что потребует затраты для лечения этих больных.

Таким образом, применение HIFU технологии для лечения злокачественных и доброкачественных образований является клинически эффективным, безопасным, экономич-



Рисунок 1 - «JC-200», в комплекте имеет УЗ приставку итальянского производства.



Рисунок 2. FEP-BY02, в комплекте имеет УЗ аппарат «Logiq-5 PRO»

чески выгодным, а в ряде случаев единственным методом лечения пациентов. Актуальность применения HIFU в Казахстане несомненна.

Технология HIFU в отличие от других способов абляции она не требует подведения к опухоли специальных проводников (электродов, как при радиочастотной абляции, светопроводящих волокон, как при лазерной абляции, специальной полый иглы, как при криоабляции жидким аргонem и т.д.). Лечение проводится без нарушения целостности кожных покровов или слизистой оболочки (очень важных защитных барьеров), поэтому, на сегодняшний день – это единственный такого рода неинвазивный метод разрушения опухолевого очага, справедливо называемый хирургией будущего.

Список использованной литературы

1. Navarro L. High intensity focused ultrasound (HIFU) in the treatment of live cancer (Structured abstract), 2008.
2. HAYES Inc High-intensity focused ultrasound treatment for prostate cancer (Structured abstract), 2009.
3. Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research (CAHTA) High-Intensity Focused Ultrasounds (HIFU) in the treatment of solid tumors (Project record), 2010.
4. National Institute for Health and Clinical Excellence High-intensity focused ultrasound for atrial fibrillation in association with other cardiac surgery, 2006.
5. National Horizon Scanning Centre High intensity focused ultrasound for prostate cancer - horizon scanning review (Brief record), 2002.
6. National Institute for Clinical Excellence High-intensity focused ultrasound for prostate cancer (Structured abstract), 2005.
7. Warmuth M., Johansson T High-intensity focussed ultrasound (HIFU) for the treatment of prostate cancer (Structured abstract), 2010.

Применение Тонбиола в лечение больных раком легкого, желудка, молочной железы, толстой и прямой кишки III-IV ст.

Досан Б.О.

Центральная больница г.Жезказган

Лечение препаратом Тонбиол проводится больным раком лёгкого, желудка, молочной железы, раком толстой и прямой кишки, которым не показано проведение спец. методов лечения. Препарат обладает противоопухолевым действием,

Лечение препаратом Тонбиол проводится больным раком лёгкого, желудка, молочной железы, раком толстой и прямой кишки III-IV ст. которым проведение спецметодов лечения не показано, либо в случае отказа больного от предложенных методов лечения (все больные, направленные на симптомическое лечение по месту жительства).

Препарат Тонбиол обладает противоопухолевым действием, зарегистрирован в Республике Казахстан – РК – ЛС – 3 №009186 от 22.10.2004г., и согласно рекомендации Фармакологического Государственного комитета РК от 31.05.2002 г. разрешено его использование в качестве лечебного препарата.

Цель исследования

- получение собственного опыта клинического эффективности Тонбиола.

Материалы

В онкохирургическом отделении 20 пациентов получали лечение Тонбиолом в суммарной дозе 1 гр. в/в на физрастворе, из них женщин -7, мужчин -13, с различной локализацией, представленной в табл. 1.

Возраст больных колебался от 41-72 лет. Средний возраст составил 57 лет. Все больные прошли клинко-рентгенологическое, ультразвуковое, морфологическое обследование. Диагноз во всех случаях подтверждён морфологически. По степени распространённости процесса больные распределились следующим образом:

1. после паллиативной операции – 8

Таблица 1 – Распределение больных по локализации и полу

Локализации	Всего	Муж.	Жен.
Рак легкого	4	4	-
Рак желудка	6	4	2
Рак молочной железы	3		3
Рак толстой и прямой кишки	7	3	4
Итого:	20	11	9

Таблица 2 - Непосредственные результаты лечения Тонбиолом

Локализация	R-графия грудной клетки	УЗИ	ФГДС
Рак легкого	2 (1)		
Рак желудка			6 (2)
Рак молочной железы		3 (2)	
Рак толстой и прямой кишки		7	
Итого:	1	2	2

Цель исследования - получение собственного опыта клинического эффективности Тонбиола.

Материал и методы. 20 пациентов получали лечение Тонбиолом в суммарной дозе 1 г внутривенно на физ. растворе.

Результаты. Эффект препарата начинался через 2-3 дня. У 30% больных отмечалась улучшение, интенсивность болей уменьшилась, улучшилось самочувствие и аппетит. В связи с чем 10 больных получили повторные, до 3-4 курсов лечения, тем самым продлив качество жизни.

Таким образом, очевидно положительное влияние Тонбиола на непосредственные результаты проводимого лечения больным раком легкого, желудка, молочной железы, рак толстой и прямой кишки III-IV заболеваний.

2. без операции – 12 больных.

Оценку непосредственного объективного эффекта терапии проводили по методике предложенной ВОЗ.

1. На контрольном УЗИ – сравнивались размеры опухоли до и после лечения.
2. На контрольном ЭГ ДФС – размеры опухоли до и после лечения.
3. На контрольном рентгенографии легких – размеры опухоли до и после лечения.

Из таблицы видно, что после лечения на R – грамме легких отмечается уменьшение объема опухоли на 30% у 1 больного – 50%.

На УЗИ уменьшение опухоли молочной железы до 35% - у 2-х больных – 40%.

При раке желудка – уменьшение опухоли на ФГДС у 2-х больных – 33%.

Эффект препарата начинался через 2-3 дня. У 30% больных отмечалась улучшение, интенсивность болей уменьшилась, самочувствие улучшилось, улучшился аппетит. В связи с наступлением улучшения, 10 больных получили повторные, до 3-4 курсов лечения, тем самым продлив качество уровня жизни.

Таким образом, можно сказать о положительном влиянии Тонбиола на непосредственные результаты проводимого лечения больным раком легкого, желудка, молочной железы, рак толстой и прямой кишки III-IV заболеваний.

Список использованной литературы

1. Багрова С.Т. Результаты II-ой фазы клинического изучения циклопатана // Вопросы онкологии. – 2001 - №6 – С.. – 752-756.
2. Тогандыков Т.Ж., Оспанов Х.К., Гуляев А.Е. Фармакология унитиола и унитиолатных комплексов металлов - Алматы, 2004.

Роль бронхоскопии в диагностике неопластических процессов дыхательных путей

Мизиев И.А., Созаева С.Р. Базиев З.М.

Кафедра факультетской и эндоскопической хирургии КБГУ, г.Нальчик

Во многих странах рак лёгкого занимает первое место в структуре заболеваемости населения злокачественными новообразованиями. До настоящего времени, рак лёгких в большинстве случаев диагностируются лишь в поздних стадиях своего развития.

В нашей работе основным методом диагностики заболеваний дыхательных путей явилась бронхоскопия. В основу работы положено клиническое исследование, проведенное в условиях Республиканской Клинической Больницы г.Нальчик. Представлены результаты обследования 468 пациентов с опухолями органов дыхания за период с 2008 по 2010 гг. Плоскоклеточный рак лёгких чаще являлся как центрально растущая опухоль. В 26% случаев рака встречалась аденокарцинома, которая располагалась в периферических отделах лёгкого. Реже, в 20% случаев, наблюдался мелкоклеточный рак. Подобный тип опухоли проявлял себя наиболее агрессивно. Диагноз перибронхиально растущей опухоли устанавливали на основании косвенных эндоскопических признаков (65% случаев). При опухоли промежуточного бронха в 32% случаев наблюдали нарушение вентиляции средней и нижней долей, выявляли инфильтративно растущую патологическую ткань. Опухоль язычковых бронхов росла эндобронхиально с наличием узла в 42% случаев. Бронхоальвеолярный рак составлял 9% всех первичных злокачественных опухолей лёгких. В итоге комплексного обследования I–II стадии рака лёгкого установлены только у 147 (31,5%) пациентов, у остальных диагностирован злокачественный процесс с отдаленными метастазами.

Таким образом, полученные в результате нашего исследования данные, подтверждают необходимость широкого использования ФБС в диспансеризации и в лечении, что позволит оптимизировать диагностику новообразований лёгких, существенно увеличив процент выздоровления

Мақалада Нальчик қаласындағы Республикалық Клиникалық Аурухананың эндоскопия бөлімі жағдайында жүргізілген клиникалық зерттеулер тәжірибесі қарастырылады. Тыныс алу мүшелерінің ісіктері бар 468 науқасты бронхоскопиялық тексеру нәтижелері ұсынылады. Нәтижесінде алынған мәліметтер бронхоскопияны диспансерлеуде және емдеуде кеңінен қолдану қажеттілігін растайды. Бұл өкпе қатерлі ісіктерін анықтауды оңтайландыруға мүмкіндік беріп, емделушілердің сауығу пайызын арттырады.

В статье описан опыт клинических исследований, проведенных в условиях эндоскопического отделения Республиканской Клинической Больницы г.Нальчик. Представлены результаты бронхоскопических обследований 468 пациентов с опухолями органов дыхания. Полученные в результате данные подтверждают необходимость широкого использования бронхоскопии в диспансеризации и в лечении. Это позволит оптимизировать диагностику новообразований легких и увеличит процент выздоровления пациентов.

The experience of the clinical researches described in this article spent in conditions of endoscopic department of Republican Clinical Hospital of Nalchik city. Results of bronchoscopic inspections of 468 patients with tumors of respiratory organs are presented. The data obtained as a result confirms necessity of wide use of bronchoscopy in health survey and in treatment. It will allow us to optimize diagnostics of new growths of lungs and will increase percent of patients' recuperation.

Профилактика постлучевых осложнений у пациенток с раком шейки матки

Батырова Л.М.

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

Вероятность постлучевых осложнений органов смежных с маткой – зависит от многих факторов - имеет разную степень выраженности и являются актуальной проблемой, требующей дальнейшего изучения и изыскания путей решения. (1,3).

Комплексное решение этой проблемы с учетом оптимизации лучевого лечения и особенностей опухолевого процесса позволит улучшить качество жизни пациентов пролеченных по поводу злокачественной опухоли шейки матки. (1,2,5,9)

Установленная взаимосвязь возникновения постлучевых осложнений с величиной суммарной поглощенной дозы, режима фракционирования, объема облучаемых тканей, сопутствующих заболеваний органов, входящих в зону облучения определяет необходимость проводить своевременную коррекцию умеренно - и выраженных лучевых реакций. (3,4,7)

Таким образом, цель данного исследования основана на оптимизации методов профилактики лучевых осложнений у больных злокачественными новообразованиями шейки матки.

За период с 2007-2010 годы в областном онкологическом диспансере города Талдыкорган было пролечено 40 больных и постлучевые осложнения в органах мочевой системы наблюдались у 0.4% больных, которым проводили сочетанную терапию по поводу злокачественных заболеваний рака шейки матки.

Лучевые циститы чаще наблюдались у женщин, лечившихся по поводу рака шейки матки в основном III и IV стадии, когда применялись большие дозы облучения. Лучевые циститы в основном были легкой формы, характеризовались только учащенным, иногда с режками, мочеиспусканием, равномерной гиперемией слизистой мочевого пузыря, наличием лейкоцитов и эритроцитов в моче.

Постлучевые изменения в органах наступают не сразу после лечения. В период от 3 мес до 1 года появляются ранние лучевые реакции, а поздние лучевые реакции наступают в период от 1 года до 5- 10 лет, а иногда и более (до 30 лет) после окончания лучевого лечения

Для уменьшения уровней поглощенных доз в области соседних с маткой органов используются защитные блоки, что оказывает существенное влияние на степень тяжести лучевых повреждений.

Совершенствуя точность укладок пациентов мы достигаем существенного расширения терапевтического интервала лучевого воздействия без возрастания лучевых осложнений. (1,3,4,8)

Коррекция общесоматического статуса больных проводится на всех этапах лечения и после, так как является обязательным элементом профилактики лучевых повреждений.

Назначение препаратов регулирующих функцию кишечника и мочеиспускания, назначение витаминов, ферментов, препаратов улучшающих тканевый кровоток, обладающих противовоспалительным, антиоксидантным действием. (2,5,7).

Иммунный статус у больных злокачественными новообразованиями шейки матки перенесших лучевую терапию, характеризуется глубокими изменениями в Т-клеточном звене, что создает предпосылки для развития инфекционных процессов различного генеза.

Поэтому, терапия постлучевых реакций и осложнений направлена на повышение сопротивляемости организма, уменьшение проницаемости тканей. (7,9)

Подводя итог, факторы, определяющие развитие лучевых осложнений необходимо принимать во внимание при планировании лечения. (2,5,8)

Несомненно важным элементом профилактики развития как ранних, так и поздних лучевых осложнений является адекватная коррекция общесоматического статуса больных до начала лучевой терапии и назначение лечебных микроклизм, а, по показаниям, различных медикаментозных средств, в том числе регулирующих и функцию кишечника. Эти мероприятия необходимо проводить также во время облучения и в ближайшее время после его окончания (3,6).

Именно комплексное решение проблем профилактики - приводит к сокращению сроков достижения положительного эффекта, снижению частоты повторных обострений, а также к увеличению продолжительности между началом ремиссии и обострением лучевых повреждений, приводит к еще более выраженным положительным эффектам (1,4,9).

Список литературы

1. Аветисов Г.М. Синдромы острой лучевой болезни. Клинические проявления, профилактика и лечение // М. - ВЦМК «Защита». - 2003. - 244 с.
2. Антонов В.Г., Козлов В.К. Патогенез онкологических заболеваний, цитоплазматические и молекулярно-генетические механизмы иммунной резистентности малигнизированных клеток // Цитокины и воспаление. - 2004. - Т. 3. - № 2. - С. 23-33.
3. Бардычев М.С. Местные лучевые повреждения / М.С. Бардычев, А.Ф. Цыб. - М.: Медицина, 1985. - 240 с.
4. Бычкова Е.Ю. Оппортунистические инфекции у онкологических больных (эпидемиологические и иммунологические аспекты): Автореф. дис. канд. мед. наук. - Омск, 2003. - 18с.
5. Васин М. В. Средства профилактики и лечения лучевых поражений: Учебное пособие // М. - 2001. - 312 е.
6. Горбунова В.А., Бредер В.В. Качество жизни онкологических больных // Материалы 4 Рос. Онк. Конф. - М. - 2000. - С. 125 - 127.
7. Иваницкая В.И.; Кисличенко В.А., Герштейн И.Г. и др. Осложнения лучевой терапии у онкологических больных // Киев. - Здоровья. - 1989. - 184 с.
8. Лучевая терапия в лечении рака. Практическое руководство. // Всемирная организация здравоохранения. - Лондон - Нью-Йорк — Токио - Мельбурн - Мадрас. - 2000. - С. 338.
9. Ярилин А.А. Радиация и иммунитет. Вмешательство ионизирующих излучений в ключевые иммунные процессы // Радиационная биология. Радиозкология. - 1999. - Т. 39. - № 1. - С. 181-189.

Консервативное лечение больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста

К.И.Ниязбекова

ГККП Алматинский региональный онкологический диспансер

В структуре онкопатологии женского населения Республики Казахстан за последние годы рак молочной железы переместился с пятого на первое место [1].

Риск развития рака молочной железы в возрасте старше 65 лет в 150 раз выше таковой у лиц моложе 30 лет. Женщины с раком молочной железы пожилого и старческого возраста чаще обращаются в специализированные лечебные учреждения с уже распространенным процессом и наличием сопутствующей патологии, которая влияет на течение заболевания, выбор тактики лечения и выживаемость [2].

Несмотря на то, что в последние годы появилось отдельное публикации о возможности консервативного лечения рака молочной железы у женщин пожилого и старческого возраста, в частности с помощью гормональной терапии (ГТ), либо сочетания ГТ с лучевой терапией, которые с успехом могут проводиться даже в амбулаторных условиях, вопросы проведения полихимиотерапии требуют дальнейшего изучения [3,4,5].

Проведен ретроспективный анализ историй болезни и амбулаторных карт больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста (60-80 лет и выше), получавших специализированное лечение в условиях Алматинского регионального онкологического диспансера в период с 2004г по 2010г.

Женщины с раком молочной железы пожилого и старческого возраста были в глубокой менопаузе сроком 10-30 лет.

Проводилось комплексное обследование, включающее клинично-инструментальные (рентгенологические, ультразвуковые и др), лабораторные и морфологические исследования, после которых устанавливался не только окончательный диагноз, но и выявлялась сопутствующая патология (у многих больных впервые).

Диагноз был подтвержден не только цитологически и морфологически, но и проводилось иммуногистохимическое исследование с определением рецепторов на онкомаркеры.

На догоспитальном этапе морфологически верифицирован РМЖ у 85 больных, из них женщины с сопутствующей патологией 55 (64%). После верификации процесса определялась дальнейшая тактика лечения с учетом стадии процесса и сопутствующей патологии.

Соответственно классификации TNM (ВОЗ, 1998 год), в группе больных, получивших консервативное лечение, у 40 больных (47%) установлено II стадия опухолевого процесса, у 42 (49,4%) больных –III стадия, и у 3(3,5%) больных IV стадия.

У больных раком молочной железы пожилого и старче-

Консервативное лечение больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста

К.И.Ниязбекова

Алматинский региональный онкологический диспансер

В данной статье обобщен опыт по консервативному лечению рака молочной железы у больных пожилого и старческого возраста.

Сүт безінің қатерлі ісігіне шалдыққан егде және қарт жасындағы науқастардың консервативті емі

К.И.Ниязбекова

Алматы аймақтық онкологиялық диспансері

Осы мақалада Алматы аймақтық онкологиялық диспансеріндегі сүт безінің қатерлі ісігіне шалдыққан егде және қарт жасындағы науқастарды консервативті емдеуден кейінгі нәтижелері жинақталып көрсетілген.

Treatment of mummer cancer in elderly and senile age

K.I.Niyazbekova

Almaty Regional Oncological Hospital

Current article generalized experience of Almaty regional oncological hospital on treatment of mummer cancer in elderly and senile age.

ского возраста сопутствующая патология распределилась следующим образом:

Наиболее часто (30,5%) больные имели сердечно-сосудистую патологию (ИБС, стенокардия, артериальная гипертензия, в анамнезе инфаркт миокарда) - 26 женщин.

Сахарный диабет I или II типа отмечен у 17(20%) больных раком молочной железы (у 6 больных впервые выявленный в условиях нашей клиники).

III-группа –12 (14,1%) больных с прочими сопутствующими заболеваниями (бронхиальная астма, хронические заболевания легких, заболевания мочеполовой системы и.т.д.).

Наличие сопутствующей патологии и распространенность опухолевого процесса у 55 больных (64,7%) были одной из основных причин проведения консервативной терапии. В некоторых случаях причиной проведения консервативной терапии был отказ больных от хирургического лечения. Выявление сопутствующей патологии способствовало проведению дополнительных диагностическо-консультативных и лечебных мероприятий, направленных на улучшение статуса больных при проведении запланированного консервативного лечения.

ПХТ проводилось по схемам CMF (циклофосфан 600 мг/м² в 1-й день, метотрексат 40 мг/м² в 1-й и 8 дни, 5-фторурацил 600 мг/м² в 1-й и 8-й дни), CAF (циклофосфан 500 мг/м² в 1-й день, доксорубин 50 мг/м² в 1-й и 8 дни, 5-фторурацил 500 мг/м² в 1-й и 8-й дни), CAMF (циклофосфан 600 мг/м² в 1-день, метотрексат 50 мг/м² в 1-й и 8 дни, 5-фторурацил 600мг/м² в 1-й и 8-день, доксорубин 50 мг/м² в 1-й

Таблица №1. Распределение больных РМЖ пожилого и старческого возраста по сопутствующей патологии

Возраст	I-группа: сердечно-сосудистая патология	II-группа: сахарный диабет	III-группа: прочие заболевания
60-70 лет	18	11	3
70-80 лет	6	5	8
80 и выше	2	1	1
Всего	26	17	12

день) 3-6 курсов.

ГТ включала в себя длительный (более 5 лет) прием больными тамоксифена.

Токсические проявления во время и после проведения ПХТ оценивали соответственно шкале токсичности (NCIC).

При соответствующей коррекции и сопроводительной терапии токсические проявления не требовали прекращения запланированного лечения.

Таким образом, консервативное лечение больных раком молочной железы в пожилом и старческом возрасте является методом выбора при наличии сопутствующей патологии и у больных, отказавшихся от хирургического лечения.

Список использованной литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Ж. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2009 году (статистические материалы), Алматы, 2010.
2. Абдрахманова А.Ж. К эпидемиологии рака молочной железы в Казахстане. Актуальные вопросы современной онкологии. Сборник научных трудов. Бишкек, 1998 год.
3. Абисатов Х.А. Клиническая онкология, том 2 «Арыс», Алматы, 2007.
4. Иванов В.М., Летягин В.П., Высотская И.В. Лечение рака молочной железы у больных пожилого и старческого возраста. М., 2001.
5. Особенности лечения рака у пожилых людей // Материалы Российского национального конгресса «Человек и лекарство» под редакцией В.А.Горбунова.-М., 1999.

Ранняя диагностика рака яичников

Батырова Л.М.

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

Проблема распознавания злокачественных опухолей яичников является одной из наиболее трудных и нерешенных(1,3). Повсеместный рост заболеваемости раком яичников, высокие показатели смертности определяет актуальность и приоритетность этой проблемы.

Отсутствие патогномоничных симптомов при ранних стадиях заболевания, широта возрастной группы заболевших женщин – все это представляет значительные трудности в диагностике рака яичников, поэтому больные чаще всего поступают в стационар на лечение в стадии диссеминации опухоли.(1,3,4,5,8)

Так, целью данного исследования является поиск наиболее эффективного сочетания комплексного обследования пациенток с подозрением на рак яичников.

Диагностика злокачественных опухолей яичников основана на использовании инструментальных и лабораторных методах исследования.

Основные задачи диагностики сводятся к:

- определение топики процесса (какой орган поражен);
- характер поражения (злокачественный или доброкачественный процесс);
- степень распространенности процесса;
- состояние организма (с целью определения возможности применения того или иного вида лечения).(2,4,7,9)

При обнаружении объёмного образования в области малого таза необходимо исключить такие заболевания, как дивертикулиты, внематочную беременность, кисты и доброкачественные опухоли яичника, миому матки, и эндометриоз. Следует помнить, что некоторые злокачественные новообразования, такие, как рак ЖКТ или молочной железы, могут метастазировать в яичники.(2,4,10)

С клинического обследования - начинается постановка диагноза: выяснение жалоб, сбор анамнеза и гинекологическое исследование.(1,5,6,10)

Наряду с анализом клинических данных применяется УЗИ малого таза. Этот метод- точен на 80-90 процентов, безвреден и многократно проводим при необходимости.(1,3,7) Для более углублённой диагностики при наличии опухолей яичников применяют такие высокоинформативные методы, как КТ и МРТ, ПЭТ. Диагностическая информативность МРТ в выявлении злокачественных опухолей яичника выше, чем УЗИ, КТ, показателя СА-125 в сыворотке крови и других клинических методов исследования.(4,7,8,9)

Возможность визуализации жизнеспособной опухолевой ткани и оценки ее биологической активности по степени интенсивности накопления в тканях метаболического РФП отличает ПЭТ от лучевой диагностики. ПЭТ обеспечивает возможность получения уникальной информации, в частности: достоверную дифференциальную диагностику злокачественных опухолей, доброкачественных новообразований и неопухолевых заболеваний; точное определение регионарной и отдаленной распространенности опухолевого процесса «во всем теле» и за одно исследование; объективную оценку эффективности проводимого лечения, а также раннее выявление рецидивов.(1,2,5,9)

Рентгенография грудной клетки — обязательный компо-

нент обследования при подозрении на опухоль яичников, так как позволяет диагностировать возможное метастазирование в лёгкие и плевральную полость. (2,6,10)

Выполнение лапароскопии или лапаротомии и получение материала для гистологического исследования является необходимым для постановки диагноза. Только гистологическая верификация диагноза может дать точный и окончательный ответ. (1,3,8)

Определение маркеров опухоли яичников – опухолевых антигенов в частности - СА 125, не является решающим в постановке диагноза и учитывается лишь в сочетании с другими признаками рака.(4,8) Маркеры рака яичников могут быть повышены и при других заболеваниях, а также у беременных женщин.

С целью уточнения патогенеза опухолей и опухолевидных образований яичников, наряду используются такие современные методы исследования, как цитоморфологические, морфометрические, гистохимические.

Таким образом, согласно данным литературы, современная диагностика опухолей яичников не может базироваться на одном каком-то методе исследования, а требует целого комплекса диагностических мероприятий для установления факта наличия яичникового образования на ранних стадиях развития и проведения дифференциальной диагностики доброкачественного или злокачественного процесса, а также определения возможного морфологического строения опухоли.

Своевременная диагностика в значительной мере определяет успех современного лечения при раке яичников.

Список литературы

1. Абдуллаева Л.М., Бабаджанова Г.С., Турсунов Х.З., Назарова Д.Б. Клинико-морфологические особенности доброкачественных опухолей яичников // Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ. Ташкент, 2008. 372.
2. Автандилов Г.Г. Окулярная измерительная сетка для цито-, гисто- и стереометрических исследований // Архив патологии. 1972. Т.34. №6. 76-77.
3. Айрапетян Л.Г., Джилаван Г.А. Оценка некоторых прогностических факторов при лечении рака яичников // Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ. Ташкент, 2008. 373.
4. Антонеева И.И. Патогенетические аспекты прогрессии неоплазмы при раке яичников // Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ. Ташкент, 2008. 374.
5. Ахмедова А., Сергеева Н.С., Маршуткина Н.В., Мишунина М.П., Новикова Е.Г. Опухолеассоциированный антиген СА 125 в динамике у больных раком яичников при разных схемах лечения. // Вопросы онкологии. 2003. 49. № 1. 95-98.
6. Каирбаева М.Ж. Современные подходы к лечению рака яичников // Здоровье и болезнь. – 2009. - №5(81).- С.5-9.
7. Нугманов Э.У., Каирбаев М.Р., Кукубасов Е.К., Каирбаева М.Ж. Молекулярный маркер СА-125 в сыворотке крови больных раком яичников // Терапевтический вестник. – 2009. - № 3 (23). – С.302.
8. Жордания К.И. Некоторые аспекты диагностики и лечения рака яичников // Онкология и гематология – 2003 - №10 – с 4-6.
9. Урманчеева А.Ф. Мешкова И.Е. Вопросы эпидемиологии и диагностики рака яичников // Онкология и гематология – 2006 - № 3-с 6-9.
10. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. Л., 1989.–464 с.

Роль ранней диагностики рака молочной железы

Батырова Л.М.

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

Каждый год в мире регистрируются около 1 млн. женщин заболевших раком молочных желез (РМЖ).[1,2]

В структуре онкологической заболеваемости рак молочной железы занимает первые позиции [1]. Летальность от рака молочной железы в Алматинской области увеличилась в 1,3 раза и составляет 6,1 чел. на 100 000 населения (2008 год) [1]. Поэтому, совершенствование методов ранней диагностики рака молочной железы является актуальным.

В Республике Казахстан – ежегодно регистрируют и ставят на учёт с раком молочной железы около трех тысяч женщин. [3]

Учитывая опыт передовых стран с 2008 г. в Казахстане внедряется скрининговая программа рака молочной железы. В маммографическое обследование включены женщины в возрасте от 50 до 60 лет.[1,2,6]

Цель настоящего исследования - анализ эффективности проводимых комплексных обследований молочной железы - маммографического, ультразвукового, биопсийного, для успешного лечения и снижения смертности от рака молочной железы в областном онкологическом диспансере города Талдыкорган.

Диагностика рака молочной железы включает два направления: первичный и уточняющий.[2,5]. К первичной диагностике относят самообследование и индивидуальный осмотр. Одним из ведущих методов уточняющего диагноза является маммография.

Скрининговая маммография (МГ) – целевая профилактическая рентгенография молочной железы определенных возрастных групп женщин. Причем, соответственно стандарта каждой женщине делают снимки в двух проекциях, то есть четыре снимка.

Основная цель скрининговой маммографии – выявление бессимптомных ранних форм рака молочных желез[4,5].

При маммографии определялось, что для раннего рака молочной железы характерны округлость образования однородной структуры размером от 1см до 5см, мелкобугристые контуры, соседние ткани имели дезорганизацию структурного рисунка и микрокальцинаты.

Раннее выявление РМЖ – своевременное лечение и продление срока жизни. Ранний рак молочной железы – это преневазивный (неинфильтрирующий) внутрипротоковый рак, а также «микроинвазивный» рак с очагами начинающей инвазии.[1,6]

При ультразвуковом исследовании определялась неоднородность внутренней структуры, наличие синдрома внутреннего эха и акустическое затемнение позади[1,2]

Таблица 1. Показатели размеров опухолей

Больные, %	Размеры, см
24,8±5,2	до 1
45,2±3,7	от 1 до 2
30,0±4,7	от 2 до 5
100	

Ультразвуковое исследование проводилось с использованием цветового и энергетического доплера (HITACHI,

Япония).

Таблица 2. Гистологические типы опухолей

Больные, %	Тип опухоли
8,2±2,2	Неинвазивный протоковый
5,1±0,7	Инвазивный дольковый
76,5±6,8	Инвазивный протоковый
3,4±0,8	Инвазивный папиллярный
2,3±0,06	Медуллярный
4,5±0,8	Слизистый
100	

Морфологическая диагностика проводится в несколько этапов: цитологический (дооперационный), цитологические и гистологические экспрессные методы (интраоперационные), плановое гистологическое исследование (операционный) и цитологическое исследование (диспансерный).

Биопсия - проводилась с выделений из молочной железы, пункционная с образования, готовились мазки-отпечатки с изъязвленной поверхности и операционный материал с самой опухоли молочной железы и регионарных лимфоузлов. В результате морфологической диагностики выявляется внутрипротоковый, интрадольковый; инвазивный протоковый, дольковый, медуллярный, коллоидный и тубулярный рак (таблица 2).

Итак, маммография и лабораторный скрининг могут применяться как алгоритмы при комплексном подходе выявления ранних стадий рака молочной железы [3,4,5,6] Многоэтапная диагностика позволяет достичь установления 100% диагноза.

Таким образом, наиболее перспективным в диагностике рака молочной железы является дальнейшее развитие многоэтапной диагностики.

Литература

1. Лучевая диагностика заболеваний молочной железы (методические рекомендации). МЗ РК КАЗНИИОУР. г.Алматы 2009 г. с 5-7.
2. Лучевая диагностика заболеваний молочной железы(методические рекомендации). 7-18.08.2006. МЗ РК КАЗНИИОУР. с 2-5.
3. Республиканский семинар «Вопросы ранней диагностики рака молочной железы и шейки матки» (сборник статей) МЗ РК КАЗНИИОУР. Международное общество гинекологического рака. 1-3.11.2007 г. Алматы. с 15-16.
4. Республиканский семинар с международным участием «Современные подходы в диагностике и лечении рака молочной железы» (сборник статей) МЗ РК КАЗНИИОУР. 6-7.10.2008 г.Алматы. с 7-8.
5. Республиканский Мастер-КЛАСС с международным участием 5.«Выявление, диагностика и лечение рака молочной железы» МЗ РК КАЗНИИОУР. Европейская школа онкологии. 2-6.11.2009 г.Алматы. с 3-4.
6. Приказ МЗ РК №607 от 15.10.2007. «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения». с 4-7
7. Аналитические годовые обзоры Областного онкологического диспансера г Талдыкорган за 2007, 2008, 2009 г с55-56, с78-79, с94-96.

Опыт хирургического лечения обтурационной толстокишечной непроходимости опухолевого происхождения

Тимашиова Е.В.

Алматы, Республика Казахстан

Обтурационная кишечная непроходимость является одним из наиболее частых и тяжелых осложнений рака толстой кишки. По данным большинства авторов частота ее колеблется от 30 до 76,8%. По данным А. Е. Богданова и С. В. Силуянова, в правой половине толстой кишки опухоли располагаются в 19,3 % случаев, в поперечной ободочной - в 5,3 %, в левой половине - в 50,8 % и в прямой кишке - у 24,6 % больных.

С ростом урбанизации и значительной миграцией населения количество таких больных значительно возросло, при этом последние поступают в стационары уже в стадии декомпенсации и ими вынуждены заниматься хирурги общего профиля. Кроме того, только единичные пациенты поступают в хирургический стационар в первые сутки после начала заболевания, подавляющее большинство (60-90%) – в сроки более 3-х суток.

Среди госпитализированных по поводу острой обтурационной толстокишечной непроходимости пациенты старше 60 лет составляют 80-90%. Отягощенность сопутствующей сердечно-сосудистой и дыхательной патологией у этой категории лиц достигает 100%. Все перечисленное обуславливает высокую послеоперационную летальность при острой кишечной непроходимости. Основной задачей в хирургическом лечении острой толстокишечной обтурационной кишечной непроходимости опухолевого генеза является устранение явлений кишечной непроходимости и восстановление пассажа кишечного химуса.

При этом проблема хирургического лечения в данной группе больных, при довольно-таки значительном опыте, остается на сегодняшний день актуальной.

За последние 6 месяцев нами анализирована группа из 13 больных с классической картиной острой обтурационной левосторонней толстокишечной непроходимости, которые подверглись хирургическому лечению в экстренном порядке. Все больные были нами предварительно обследованы и подвергнуты оперативному лечению. Выбор объема оперативного вмешательства зависел от тяжести состояния больного (обусловлена возрастом, сопутствующей патологией), локализацией новообразования и его резектабельностью. Небольшие размеры опухолей и сравнительно раннее развитие явлений непроходимости объясняло то, что большинство из них были резектабельными, отсутствовали отдаленные метастазы. Однако, из-за тяжести состояния в 3 случаях операция была завершена наложением разгрузочных колостом (из них только в 1 случае имелись парааортальные метастазы и метастазы в печень), а в 10 случаях – радикальной резекцией опухоли. Тем не менее, среди всех оперированных нами пациентов летальных исходов не было.

При этом в тактике ведения данной группы больных мы придерживались определенных алгоритмов действий, которыми в данной публикации хотелось бы поделиться:

1. Жалобы, анамнез.
2. Физикальные обследования (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, ректальный осмотр).

Ісікпен байланысты тоқ ішектің обтурациялық бітелуін хирургиялық емдеудегі тәжірибелер.

Тимашиова Е.В.

Алматы, Қазақстан Республикасы.

Тоқ ішектің обтурациясымен ауыратын науқастарды хирургиялық жолмен емдеу әліде актуалды мәселе болып тұр. Мақалада жедел хирургиялық кейінгі 13 науқастың анализі көрсетілген. Автормен айтылған патологияны емдеуде қанағаттанарлық жетістікке жетудегі хирургтың тәсілі алгоритммен көрсетілген. Тоқ ішектің обтурациясымен ауыратын науқастарға жедел хирургиялық көмек ұйымдасқан диагностика және дайындықпен жүргізілуі тиіс.

3. Лабораторные методы исследования: общий анализ крови, гематокрит, общий анализ мочи, группа и резус-фактор крови, билирубин, креатинин, мочевины, глюкоза, коагулограмма.
4. Инструментальные методы исследования: обзорная рентгенография грудной клетки и брюшной полости, УЗИ брюшной полости, ЭКГ.
5. Установка назогастрального зонда и очистительная клизма.
6. Предоперационная инфузионная и симптоматическая терапия.
7. Обязательная антибиотикопрофилактика (использовались препараты широкого спектра действия – цефтриаксон, абактал).
8. Непосредственное хирургическое лечение.
9. В послеоперационном периоде – профилактика тромбоэмболических осложнений (использовался клексан в дозировке 20 мг), эластическое бинтование нижних конечностей.
10. Направление пациента для дальнейшего наблюдения и лечения к онкологу по месту жительства.

Таким образом, неотложная хирургическая помощь больным с обтурационной толстокишечной непроходимостью должна осуществляться при четкой организации диагностики и подготовки больного, при этом не всегда следует стремиться к выполнению радикального оперативного вмешательства, особенно при локализации опухолевого процесса в левой половине ободочной кишки.

Список использованной литературы

1. Абеlevич А.И., Овчинников В.А., Серопян Г.А. // Хирургия. — 2004. — N 4. — С.46
2. Быков А. С. К оценке хирургической тактики при обтурационной толстокишечной непроходимости : диссертация ... кандидата медицинских наук : 1- Ярославль, 2009. - 151 с.
3. Помазкин В. И., Мансуров Ю. В. // Хирургия. — 2008. — № 9. — С. 15—18.
4. Dumont F., Vibert E. et al. // Ann. Chir. — 2005. — Vol. 130, N 6—7. — P. 391—399.

Диагностика и хирургическое лечение обтурационной толстокишечной непроходимости

Курбонов К.М., Шамсиев Г.Х., Шарипов Х.Ю., Назаров Х.Ш.

Кафедра хирургических болезней №1, (зав.- член. корр. АН РТ, проф. Курбонов К.М.)

Введение

Наряду с ростом заболеваемости раком ободочной кишки в настоящее время отмечено значительное увеличение числа больных с осложненным его течением и одной из наиболее актуальных, в неотложной абдоминальной хирургии, является проблема диагностики и лечения осложнений рака ободочной кишки[2,3]. Хотя, в последние десятилетия достигнуты некоторые успехи в лечении этой категории больных, однако послеоперационная летальность после радикальных оперативных вмешательств по данным разных авторов колеблется от 41,6% до 48,8% (1,2). Среди осложнений одно из первых мест занимает острая толстокишечная непроходимость, которая встречается от 20,0 до 85,5%.(3). Непроходимость кишки при локализации опухоли в левой половине (сигмовидная, нисходящая ободочная и прямой кишки) в 2-3 раза выше, чем при локализации в правой. Причиной летальных исходов служат: несвоевременная диагностика, позднее обращение больных, отсутствие квалифицированных специалистов в отдаленных районах от центра, увеличение числа больных преклонного возраста и наличие тяжелых сопутствующих патологий со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

От своевременной диагностики и оказанной квалифицированной помощи зависит дальнейшая судьба этих пациентов.

Цель исследования

- улучшение диагностики и непосредственных результатов хирургического лечения больных с обтурационной толстокишечной непроходимости (ОТН).

Материалы и методы

В клинике хирургических болезней №1 за период с 1998 по 2008 г. находилось 77 больных с ОТН, в возрасте от 38 до 80 лет. Женщин было 45 (61,4%), мужчин -32 (38,6%). Около 55% больных были в возрасте 60-70 лет.

Всем поступившим больным проведены клинко-лабораторные, инструментальные методы исследования, включая УЗИ, ирриграфию, по показаниям колоноскопию, КТ и МРТ и комбинированную методику исследования разработанную в клинике а также видеолaparоскопию при трудных случаях. При изучении анализа причин запущенности заболевания, оказалось, что 43 (55,8%) поздно обратились за медицинскую помощь, а 34 пациентам (44,2%) поздно поставлен диагноз, из-за отсутствия онкологической настороженности врачей первичного звена.

Результаты и их обсуждение. Анализ обращения больных за медпомощью и сроки госпитализации свидетельствуют о поздних сроках госпитализации. Следует отметить, что лишь 17 больных из 77, госпитализированы в первые 24 часа от момента заболевания, остальные 50 (64,9%) поступали поздно.

При поступлении большинство пациенты имели со-

путствующие заболевания (таблица №1).

Таблица №1. Сопутствующие заболевания у больных с ООТН

Сопутствующие заболевания	Количество	%
Ишемическая болезнь	19	24,6
Гипертоническая болезнь	10	12,9
Атеросклероз сосудов	9	11,7
Хроническая легочная патология	5	6,5
Заболевания почек	4	5,2
Сахарный диабет	7	9,1
Прочие	6	7,8
Всего	60	77,8

Необходимо отметить, что у более 50% больных имело место сочетание двух и более сопутствующих заболеваний.

Дальнейшее изучения клинического материала выявило частоту локализации патологического процесса (таблица2).

Таблица №2. Распределение больных в зависимости от локализации опухоли

Локализация опухоли	Количество больных	%
Ректосигмоидальный отдел	41	53,2
Слепая кишка	14	18,2
Восходящая ободочная кишка	6	7,8
Поперечноободочная кишка	9	11,7
Нисходящая ободочная кишка	7	9,1
Всего	77	100%

Как видно из таблицы 2 в левой половине толстой кишки, опухоль локализовалась у 48(62,3%), в правой половине у 20 (26,0%) и в поперечно ободочной кишке у 9 больных (11,7%).

Изучения операционного материала позволило, что в левой половине опухоли имели эндофитный рост, а в правой половине чаще экзофитный рост. Микроскопические строение опухоли изучали по операционным материалам и наиболее часто встречались аденокарциномы различной дифференцировки.

Больные были распределены в зависимости от клинической стадии болезни по Б.Е. Петерсону и Н.Н. Блохину (1979). При этом у большинство оперированных больных отмечен РОК IIIA и IIIB стадии.

В клинике разработана методика ранней диагностики толстокишечной непроходимости и степени обструкции с применением металлических контрастных меток (рац. удостоверение №1558, выд. ТГМУ от 28.08.95г)

Суть метода заключается в следующем. Натощак перорально больному дается металлические шарики одновременно со 100 мл жидкой бариевой взвеси. Указанное количество контрастной массы резко снижает возможность получения эффекта наслаивания друг на друга контрастированных кишечных петель. Затем через 2-4-6, а при

необходимости и более часов проводится обзорная рентгенография органов брюшной полости, либо УЗИ брюшной полости. При наличии стеноза или непроходимости «контрастные метки» задерживаются в области препятствия при непроходимости, а при формирующем стенозе пассаж бариевой взвеси происходит беспрепятственно. Указанная методика успешно применена 30 больным.

В зависимости уровня локализации непроходимости нами проведены следующие виды операций:

При правосторонней локализации на первом этапе сформировали илеотрансверзоанастомоз с отключением правой половины ободочной кишки (2) или формировали двустольную илеостому (2) с дренированием зоны абсцесса, через 2-4 месяца выполняли правостороннюю гемиколэктомию. Ещё двум больным с декомпенсированной клиникой непроходимостью правой половины толстой кишки в начале формировали цекостому с декомпрессией тонкой кишки, через 1,5 месяца произвели субтотальную колэктомию с ликвидацией цекостомы с формированием Y-образного анастомоза.

При обструкции поперечно-ободочной кишки проводили левостороннюю гемиколэктомию с формированием трансверзоректоанастомоз (4), субтотальная колэктомия с формированием Y-образного анастомоза (2), резекция поперечно-ободочной кишки по Гартману (3).

Наиболее большое количество больных были с кишечной непроходимостью левосторонней локализации. Ими проводили различные по характеру операции (таблица №3).

Для повышения физической и биологической герметичности асцендоректального 10 больным линия швов укреплена пластинками ТахоКомба в сочетании с антибиотиками (Уведом. о положит. результат. по приорит. спр. № 01000666 от 5.06.2001 г.) 5 пациентам произведена левосторонняя гемиколэктомия с перевязкой нижнебрыжеечной артерии и вен с формированием Y-образного трансверзоректального анастомоза.

В ближайшем послеоперационном периоде экзатировали 12 больных (15,6%). Причиной летальности у 7 больных была тяжелая интоксикация вследствие перитонита, на почве несостоятельности анастомоза, у 2-острая сердечно-сосудистая недостаточность, ещё у 1-острая печеночно-почечная недостаточность, у 1-послеоперационная пневмония и 1 больной умер от тромбоэмболии легочной артерии. Нагноение послеоперационной раны наблюдались у 11(14,2%).

Заключение

Таким образом, ранняя диагностика и квалифицированная оказанная помощь, больным с обтурационной толстокишечной непроходимости, с учетом возраста, сопутствующих заболеваний и тяжести патологий, распространенности процесса, значительно влияет на успех

Таблица №3

Вид операции	О т д е л локализации опухоли		Всего	Число умерш.
	Нисх. отдел	Ректо- сигмо- идный отдел		
Дистальная субтотальная резекция толстой кишки с формированием асцендоректального анастомоза	2	7	9	1
Дистальная субтотальная резекция толстой кишки с перевязкой а. mesenterica inferior и формированием асцендоректального анастомоза	1	8	9	2
Дистальная субтотальная резекция толстой кишки с перевязкой а. mesenterica inferior и формированием асцендоректального анастомоза. Укрепление линии швов пластинами Тахокомба	1	9	10	
Левосторонняя гемиколэктомия с перевязкой а. mesenterica inferior и формированием трансверзоректального анастомоза		5	5	2
Левосторонняя гемиколэктомия с трансверзоректальным анастомозом	1	4	5	2
Операция Гартмана		7	7	
Проксимальная трансверзостомия	2	4	6	
Всего	7	41	48	7

лечения.

Применение современной технологии, в частности видеолaparоскопия, при затруднительных случаях дает возможность своевременно ставить диагноз и выбрать правильную хирургическую тактику.

Применение пластины ТахоКомба укрепляет физическую и биологическую герметичность линии анастомоза.

Литература

1. Ганцев Ш.Х. и др. Рак ободочной и прямой кишки. М., 2004.
2. Ефимов Г.А., Ушаков Ю.М. Осложненный рак ободочной кишки. М., 1984.
3. Кандаков О.К. Пути улучшения диагностики и хирургического лечения толстокишечной непроходимости опухолевого генеза. Автореф. канд.мед.наук. Душанбе, 2007, 15 с.

Преимущества грудного вскармливания для здоровья детей и матерей

Мамбетова С.Т.

Атырау

Актуальность

Молоко матери максимально адаптировано к потребностям именно ее малыша и содержит антитела и иммунные клетки, защищающие его от инфекций, аллергии и хронических заболеваний. Так как снижает частоту и продолжительность диспептических заболеваний, обеспечивает защиту от респираторной инфекции, снижает частоту случаев отита. При этом возможна защита от некротического энтероколита новорожденных, бактериемии, менингита, ботулизма и инфекции мочевыводящих путей, снижение риска аутоиммунных болезней. Улучшается острота зрения и психомоторное развитие, что может быть обусловлено наличием в молоке полинасыщенных жирных кислот. Повышаются показатели умственного развития по шкале, что может быть обусловлено присутствующими в молоке факторами или повышенным стимулированием. Уменьшаются аномалии прикуса благодаря улучшению формы и развитию челюстей.

Для матери грудное вскармливание имеет следующие значения:

1. Раннее начало грудного вскармливания после рождения ребенка способствует восстановлению сил матери после родов, ускоряет инволюцию (сокращение) матки и уменьшает риск кровотечения, тем самым снижая материнскую смертность, а также сохраняет запасы гемоглобина у матери благодаря снижению кровопотери, что ведет к улучшению положения с содержанием железа в организме.
2. Увеличивается период послеродового бесплодия, что ведет к увеличению интервала между беременностями, если не используются противозачаточные средства.

Возможно ускорение потери массы тела и возвращения к массе тела, которая была до беременности, т. е. быстрее восстановится форма после родов, потому что лишний жир, накопленный в организме за время беременности, перерабатывается в энергию, необходимую для производства грудного молока. Уменьшается риск рака груди и рака яичников в предклимактерическом возрасте. Возможно улучшение минерализации костей.

Цель исследования

– увеличить количество матерей, используемых грудное вскармливание малышей для улучшения здоровья детей и профилактики онкозаболеваний груди и яичников матерей.

Секрет успешного грудного вскармливания довольно прост – желание мамы кормить грудью, информационная подготовка и практическая помощь. Но, увы, третий пункт не всегда выполняется. Поэтому опыт приходится накапливать самостоятельно – в процессе совершения ошибок и их устранения. Но, все же, сократить количество ошибок возможно, для этого выделены первые и основные правила кормления грудью:

Правило 1. Кормим грудью по первому требованию.

Көкірек емізудің бала мен ана үшін пайдасы.

Мамбетова С.Т.

Ана сүті мейлінше пайдалануға үйренішті, антидене мен иммунитеттік жасушалар сәбиді жұқпалы аурулардан, аллергиядан, созылмалы аурулардан қорғайды, баланың ақыл-ойының дамуы жылдам болады.

Зерттеудің мақсаты – емізу арқылы сәбилердің денсаулығын жақсартатын аналардың санын көбейту, аналардың сүт безі онкологиялық ауруларына профилактика жүргізу.

Аналармен бірлескен жұмыс жүргізу сәбилердің денсаулығын жақсарту және көкірек сүт безі онкологиялық ауруларына профилактика. Осы тұрғыда, жас аналармен тікелей жұмыс жүргізу, бала емізудің пайдалы екеніне көз жеткізу, жалпы алғанда ана мен баланың денсаулығын жақсарту.

Актуальность. Молоко матери максимально адаптировано к потребностям именно ее малыша и содержит антитела и иммунные клетки, защищающие его от инфекций, аллергии и хронических заболеваний, повышаются показатели умственного развития детей. Необходима повсеместная работа с матерями для улучшения здоровья детей и профилактики онкозаболеваний груди и яичников матерей.

Цель исследования – увеличить количество матерей, используемых грудное вскармливание малышей для улучшения здоровья детей и профилактики онкозаболеваний груди и яичников матерей.

Практически во всех родильных домах поощряется кормление по требованию. Это правило можно по праву назвать самым важным. В природе все устроено мудро – чтобы малышу было также хорошо в новом мире, как и у мамы в животике, матка 'заменяется' на мамины руки, а плацента – на мамину грудь. Именно с грудью кроха учится всему: получает необходимую пищу, успокаивается, засыпает – это его первые жизненные уроки. Для мамы такие частые кормления грудью тоже необходимы, ведь образование необходимого количества молока зависит от выработки соответствующего количества гормонов – пролактина и окситоцина. На выработку пролактина оказывает влияние частота прикладываний к груди, правильное сосание, наличие ночных кормлений грудью. На выработку окситоцина – эмоциональное состояние кормящей мамы. Для успешной лактации очень важно, чтобы кормления грудью в первые недели и месяцы были достаточно частые, в этом случае грудь хорошо стимулируется и чутко реагирует на возрастающие не по дням, а по часам потребности малыша.

При правильном кормлении грудью: Мама не испытывает болевых ощущений, малыш не причмокивает, на сосках не проявляются трещинки, грудь хорошо опорожняется, поэтому риск застоя молока минимален.

Правило 2. Учимся правильно прикладывать ребенка

к груди. Оказывается, что в первые три месяца ребенок учится правильно сосать грудь мамы, поэтому наша задача - помочь ему в этом нелегком деле.

Помогите ребенку взять грудь правильно - при этом его ротик широко открыт, губки вывернуты наружу, подбородочек упирается в грудь, при кормлении виднеется язычок (на нем располагается грудь), снизу ареола захватывается больше, чем сверху.

Правило 3. Кормить грудью в разных положениях, так как очень важно, чтобы грудь хорошо опорожнялось, все дольки работали одинаково, поэтому положение кормления грудью необходимо менять. Максимально опорожняется та доля, которая направлена на подбородочек ребенка. При уплотнении в груди - воспользоваться этим правилом гораздо быстрее.

Правило 4. Не используем пустышку и бутылку! Как это на первый взгляд ни странно, кормление из бутылки и сосание пустышки может привести к раннему окончанию грудного вскармливания. Но мамы не всегда воспринимают эту рекомендацию всерьез. Например, при сосании бутылки малыш больше работает губками, втягивает щеки, поджимает язычок, а при сосании груди работает нижняя челюсть, грудь лежит на язычке, поэтому при совмещении таких разных способов сосания одни детки начинают брать грудь неправильно (что ухудшает ее стимуляцию), а другие и вовсе могут отказываться от груди.

Правило 5. Кормим ребенка ночью. Ночные кормления грудью - стимуляторы лактации. Гормон пролактин вырабатывается ночью в самом большом количестве, поэтому не стоит малышу ночью предлагать замен) груди - кормить как и днем, по первому требованию.

Правило 6. Не проводим контрольные взвешивания. Не стоит малыша часто взвешивать, более того, не стоит высчитывать количество съеденного молока при помощи контрольных взвешиваний. У каждой мамочки молоко отличается по содержанию калорий, да и усваиваемся по разному. Малыш может высосать 50 мл молока и усвоить только 25, или же высосать 50 мл и усвоить все 50. Объективную оценку достаточного питания дает подсчет мочеиспусканий.

Правило 7. Недопаиваем ребенка водичкой. Грудное молоко состоит на 87% из воды, поэтому давать ребенку дополнительно воду в первые полгода не стоит. Наличие

другой жидкости может уменьшать выработку молока, так как центр насыщения и центр утоления жажды у малыша находится очень близко, и порция водички воспринимается как еда. Не стоит переживать, что молоко жирное и ребенку тяжело его переваривать. В нем недостаточно жидкости (особенно в переднем молоке) и ферментов, которые помогают молочку «себя переваривать». К тому же, вода - инородная жидкость для малыша, введение ее в рацион повышает риск занесения инфекции.

Правило 8. Не сцеживаемся. Когда мы кормим малыша по требованию, спрос всегда равен предложению. Сколько молочка из груди убыло - столько же и прибудет. Сцеживание без показаний (таких как: застой молока, глубокое трещины, разлучение мамы и малыша, необходимость кормления сцеженным молочком либо увеличение стимуляции груди с целью повышения лактации) может привести к гиперлактации (повышенной выработке молока) и повышает риск образования застоев.

Следует отметить, что сцеживание - это, прежде всего, практика. Поэтому обязательно пригласить специалиста, который научит вас как это делать правильно и безболезненно.

Правило 9. Применяем «Золотой стандарт». Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует кормящим мамам придерживаться так называемого «золотого стандарта» - исключительного грудного вскармливания в первые 6 месяцев. Вводить прикорм не стоит ранее этого срока, так как ферментативные системы малыша еще не созрели, и нища не будет хорошо усваиваться. Кроме того, ранее введение взрослой пищи в рацион ребенка может вызвать вполне объяснимые осложнения - запор, понос, аллергические высыпания.

Правило 10. Не стесняемся просить помощи. Материнство - волнующий и очень интересный этап в жизни каждой женщины, но, все-таки, согласитесь, опыт приходит со временем. А почему не стесняться просить помощи, даже если возникающие вопросы покажутся мелочными или глупыми. Ведь вся наша жизнь и складывается из таких мелочей, которые нужно правильно суметь сложить.

Таким образом, однозначно нужно проводить работу с молодыми мамами, убеждать их в необходимости грудного вскармливания малышей, что в общем приведет к повышению здоровья детей и матерей.

Климактерический синдром и ЗГТ

Тян И.И.

Институт репродуктивной медицины

В определенном возрасте, чаще всего 50 годам, в организме женщин происходят изменения, связанные с угасанием функции яичников, снижением выработки половых гормонов. Все возникающие симптомы можно условно разделить на три группы (по времени появления).

1 группа – это «ранние» симптомы. К ним относятся приливы жара, которые беспокоят более 80% женщин, у 20% они могут продолжаться более 4 лет. Нарушение сна отмечает каждая вторая женщина, обратившаяся к врачу после 45 лет. Отмечается резкое колебание артериального давления, сердцебиение, плаксивость, склонность к депрессии.

2 группа – это «средневременные» симптомы, которые возникают, чаще всего, спустя 3-5 лет после последней менструации. К ним относятся жалобы, связанные с атрофическими изменениями урогенитального тракта. Женщину может беспокоить сухость во влагалище, неприятные ощущения во время полового акта, связанное с этим негативное отношение к половой жизни, что в свою очередь приводит к конфликтным ситуациям в семье.

3 группа – это «поздние» проявления климактерических расстройств – сердечнососудистые заболевания, осложнившиеся инфарктом или инсультом. Еще одним поздним осложнением является остеопороз. Дословно перевод этого термина звучит «потеря костной ткани». Причиной этому является недостаток эстрогенов и, как следствие, нарушения обмена кальция. Снижается концентрация кальция в крови, его резорбция из костей, кости, хотя и очень медленно, становятся более пористыми и хрупкими, чаще возникают переломы предплечья, шейка бедра, появляются боли в спине, уменьшается рост.

Все проявления климактерических расстройств можно и необходимо корректировать. Существует как медикаментозное лечение, так и не медикаментозные методы. Однако патогенетическим лечением является применение гормональной заместительной терапии (ЗГТ). Одним из ценных положительных качеств в ЗГТ является улучшение качества жизни женщины. Даже после непродолжительного периода приема препарата (2-3 месяца) происходит улучшение самочувствия, нормализация сна, повышение работоспособности и интереса к жизни. Кроме того, установлено, что ЗГТ препятствует возрастному повышению артериального давления, ухудшению памяти, развития атрофических изменений кожи и слизистых оболочек, и является основным методом профилактики остеопороза.

Препараты фирмы «Шеринг» давно себя зарекомендовали с положительной стороны. Например, «Климонорм» подходит женщинам астеничным, со склонностью к депрессии, т.к. левоноргестрел, входящий в состав этого препарата, обеспечивают активную позитивную жизненную позицию женщине, наряду с купированием климактерических расстройств. Препарат «Климен» содержит в своем составе ципротерон ацетат, который оказывает антиандрогенное действие, тем самым препятствуя прибавке в весе, нормализуя артериальное давление, устраняет такие косметические проблемы, как появление избыточного роста волос в области подбородка, верхней губы, околососковой зоне. Данные препараты являются двухфазными, циклическими, т.е. на фоне их применения менструации проходят регулярно, умеренно. Другая группа – это монофазные препараты для непрерывного применения. К ним относятся «климодиен», в состав которого входит уникальный прогестаген диеногест, обладающий метаболической нейтральностью. Данная комбинация эстрадиола и диеногеста способствует устранению климактерических расстройств, снижению массы тела и является профилактикой остеопороза и сердечнососудистых заболеваний.

К монофазным относится и новый препарат «Анжелик», который появился на нашем рынке в 2005 году. Принципиальным отличием этого препарата является содержание дроспиренона, обладающий антиминералокортикоидным действием, т.е. способствует выведению жидкости из организма. На фоне этого значительно улучшается сон женщины, устраняются вегетативные, эмоциональные симптомы, снижается артериальное давление. Помимо этого, «Анжелик» содержит 1 мг эстрадиола, что в 2 раза меньше по сравнению с другими препаратами для ЗГТ, следовательно, такие адаптационные жалобы как боли в молочных железах, боли внизу живота на фоне применения этого препарата встречаются гораздо реже. В нашей стране заместительная терапия половыми гормонами у женщин в климактерии применяется редко. Это объясняется тем, что наша промышленность не производит необходимых лекарств. Кроме того, дефицит собственного опыта гормональной терапии у наших врачей сдерживает распространение заместительной гормональной терапии и создает скептическое отношение к ней. Ведь ни у кого не вызывает сомнения в целесообразности применения инсулина при сахарном диабете I типа, тиреоидных гормонов при гипотиреозе, кортикостероидов при болезни Иценко-Кушинга. При климактерических расстройствах наблюдается снижение выработки эстрогенов, следовательно и восполнять их необходимо препаратами, которые содержат эстрогены, следуя принципу индивидуального подбора для каждой пациентке.

Таким образом, патогенетически обоснованная гормональная терапия препаратами половых гормонов является одним из основных методов лечения женщин в климактерическом периоде, поскольку позволяет в известной мере восстановить возрастной гормональный гомеостаз и таким образом нормализовать в соответствии с возрастом функции как репродуктивной системы, так и других органов и систем, деятельность которых связана с половыми гормонами.

Литература

1. Сметник В.П., Ткаченко Н.М., Глезер Г.А., Москаленко Н.П. *Климактерический синдром*. – М.: Медицина, 1988.
2. Сметник В.П., Тумелович Л.Г. *Неоперативная гинекология*. – М., 2006.
3. *Материалы семинара «Менопауза и ЗГТ»*. – М., 2001.
4. Крымская М.Л. *Климактерический период*. – М.: Медицина, 1989.
5. *Исследования проблем менопаузы в 90-годах. Доклад научной группы ВОЗ*. – Женева, 1994.

Сочетание хронического вирусного гепатита В и злокачественной опухоли фатерова сосочка смешанной этиологии. Случай из практики

Сулейменова З.И., Лавлинская Е.А., Жакешов Т.И., Сагитов Ш.Ж., Анетбекова А.А.

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

Городская клиническая инфекционная больница имени И.С. Жекеновой

Первичные опухоли печени могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. При вирусном поражении печени гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) развивается на фоне хронического гепатита (ХГ) и цирроза печени (ЦП). Но, опухоль может возникнуть и без сопутствующего ЦП. При HBV – инфекции ГЦК чаще формируется на фоне ЦП. При HCV – инфекции более низкая частота формирования ГЦК, так как необходим период от 10 до 29 и более лет после инфицирования. При сочетанной инфекции HDV и HBV опухоль встречается реже, возможно ввиду подавляющего действия HDV (1).

Б-й, 72 лет поступил в стационар городской клинической инфекционной больницы города Алматы (ГКИБ) в начале марта через 1,5 месяца от начала заболевания с направленным диагнозом ХГВ в стадии обострения.

Из анамнеза болезни: заболевание началось с ощущения тяжести в эпигастрии и области правого подреберья, тошноты и периодически возникающей слабости. Через 8 суток от начала заболевания изменился цвет мочи и появилось желтушное окрашивание кожи и видимых слизистых. Через 22 дня от начала заболевания было отмечено

Ұзақ персистенген HBV және HCV инфекциялары кезінде бауыр циррозынан кейін немесе онсыз гепатоцеллюлярлы карциноманың дамуы заңды. Кәрілік жастағы бірінші рет тіркелген қант диабеті, қарқынды өсуші билирубинемия, сілтілі фосфатаза мен альфа-амилазаның жоғары көрсеткіштері персистеуші HBV – инфекциясында дамыған фатеров емізіктерінің қатерлі ісіктерін диагностикалауға мүмкіндік берді.

При длительно персистирующей HBV и HCV – инфекциях, закономерно развитие гепатоцеллюлярной карциномы на фоне цирроза печени или без него. Впервые зарегистрированный сахарный диабет в пожилом возрасте, нарастающая билирубинемия, высокие показатели щелочной фосфатазы и альфа-амилазы, позволило диагностировать злокачественную опухоль фатерова сосочка, которая развивалась на фоне персистирующей HBV – инфекции.

Таблица 1. Динамика биохимических проб печени

АЛТ	111 мкм\л	126 мкм/л	126 мкм/л	137 мкм/л	135 мкм/л
АСТ	181 мкм/л	227 мкм/л	221 мкм/л	250 мкм/л	210 мкм/л
ЩФ	442 ед	449,9 ед	530 ед	601,2 ед	620 ед

нарастание желтушности и слабости. На догоспитальном этапе пациент обследовался: по данным УЗИ и КТ органов брюшной полости были выявлены диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы, гепатомегалия и как находка – гемангиома правой доли печени, а также деформация желчного пузыря и застойный холецистит, хронический пиелонефрит и киста паренхимы левой почки. Обследование на маркеры вирусных гепатитов методом ИФА выявил наличие HBsAg, анти HBcorAT, анти HBeAT.

Анамнез жизни: в январе 2011года операция по поводу субдуральной гематомы правой гемисферы и одновременно был выявлен сахарный диабет 2 типа и хроническая язвенная болезнь 12-перстной кишки.

ОБ-но: Сознание ясное, полная ориентация во времени и пространстве. Беспокоили тошнота, слабость, сниженный аппетит. Имела место выраженная желтушность кожи и видимых слизистых, без кожного зуда. Печень выступала из-под реберного края на 4-5 см, плотной консистенции, безболезненная при пальпации. Имелась спленомегалия.

Лабораторные показатели: ОАК- Эр 4,40 млн/мл; Гем 137,6 г/л; тр 277тыс; л 7,2 тыс/мл; п/я 1%; с/я 57%; э 3%; м 3%; л 36%; СОЭ 20 мм/ч.

ОАМ: белок 0,066; эп пл 0-1 в п/зр; л 15-18 в п/зр скопления до 40; зерн цил 0-1 в п/зр. Биохимия: АЛТ-124мкмоль/л; АСТ-173 мкмоль/л; Альфа-амилаза-130 ед; холестерин-9,9; об белок-55,6 г/л; альбумин 31,8 г/л; ЩФ-468,2 ед/л; тимоловая-5,7 ед; Билирубин-298,0/241,5/56,5 мкмоль/л. ПО-1,3; фибриноген-6,2 г/л. ИФА: HBsAg, анти HBcor total антитела.

Таким образом, в биохимических пробах печени имело место сочетание синдромов цитолиза (ферментемия, низкое содержание общего белка и альбумина) и холестаза (гипербилирубинемия и высокий показатель ЩФ), а также обращало на себя внимание повышенный показатель альфа-амилазы без клиники панкреатита. В клиническом анализе крови имела место ускоренная СОЭ и в моче пиурия. Предварительный клинический диагноз ХГВ был верифицирован наличием поверхностного антигена. Пациенту была назначена базисная терапия, гептрал в суточной дозе 800 мг и ампициллин 4.0 г/сутки.

Дальнейшее наблюдение показало нарастание слабости до адинамии, снижение аппетита до анорексии и постоянную тошноту, не связанную с приемом пищи. Объективно отмечалось нарастание желтушности и потеря массы тела. Динамика биохимических проб печени показала сохраняющуюся ферментемию, дальнейшее снижение альбумина. Нарастание билирубинемии за счет связанной фракции и нарастание показателя альфа-амилазы (таблица 1).

Необходимо отметить, что за период наблюдения протромбиновое отношение (ПО) было в пределах нормы, но отмечалось повышенное содержание фибриногена, от 7,4 до 8,6 г/л. Отмеченная отрицательная динамика в состоянии пациента и в лабораторных показателях с преобладанием холестаза и отсутствие эффекта

Острая обтурационная толстокишечная непроходимость как грозное осложнение опухоли толстой кишки в экстренной абдоминальной хирургии у больных пожилого и старческого возраста

Сактаганов К. Е., Мукашев У.И.
Областная больница, г. Петропавловск

Число больных раком толстой кишки неуклонно растет. Неблагоприятным является тот факт, что у большинства больных встречаются осложненные формы данного заболевания (40%-90%). (Трапезников Н.Н., Аксель Е.М., 2001). Проблема неотложной абдоминальной хирургии заключается в том, что значительную часть этих больных составляют пациенты пожилого и старческого возраста и острая кишечная непроходимость опухолевой этиологии нередко является первым проявлением заболевания. Послеоперационная летальность у больных пожилого и старческого возраста с данной патологией составляет 21-44%, а при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний достигает 80% (Ханевич М.Д., Шашолин М.А., 2005).

В связи с этим, улучшение результатов хирургического лечения обтурационной толстокишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста является актуальной проблемой.

Лечение больных с обтурационной кишечной непроходимостью, обусловленное стенозирующей опухолью толстой кишки в сочетании с тяжелыми соматическими заболеваниями создает определенные трудности в принятии оптимальной лечебной тактики.

Нами анализированы результаты лечения 46 больных старших возрастных групп за период 2005-2009гг, подвергнутых экстренному оперативному вмешательству. Мужчин было 16(35%), женщин – 30(65%), у 80% пациентов возраст составлял старше 75 лет.

Во время оперативного вмешательства выявлены: стенозирующие опухоли правой половины – 12,3%, поперечно-ободочной кишки- 24,7%, левой половины толстой кишки- 49,9%, ректосигмоидного отдела -13,9%.

Результаты и обсуждение.

Все больные поступали в тяжелом состоянии с декомпенсированной формой кишечной непроходимости. После предоперационной подготовки все больные оперированы. Немаловажную роль в исходе заболевания играет двойной характер интоксикации, обусловленный основным раковым процессом и переполнением толстого кишечника с вовлечением в процесс непроходимости тонкой кишки. В этой связи важным этапом в оперативном лечении опухолевой толстокишечной непроходимости в стадии декомпенсации является адекватная декомпрессия тонкой кишки путем назоинтестинальной интраоперационной интубации тонкого

кишечника и предварительной цекостомии.

Больным выполнены операции:

1. При левосторонней локализации опухоли в большинстве случаев (92%) выполнены обструктивные резекции толстой кишки с опухолью и выведением одноствольной колостомы (Операция Гартмана).

2. При локализации опухоли в правой половине (слепая, восходящая) 64% удалось выполнить правостороннюю гемиколэктомию с выведением концевой энтеростомы. В остальных случаях вынуждены были ограничиться цекостомией или концевой энтеростомией.

3. При стенозирующих опухолях поперечно-ободочной кишки выполнены резекции участка кишки вместе с опухолью с выведением колостомы.

В послеоперационном периоде проводили интенсивное лечение, направленное на восстановление белкового баланса, КЩР, поддержку жизненно важных органов.

Анализ результатов лечения у представленной группы больных показал, что послеоперационная летальность у больных пожилого и старческого возраста с острой толстокишечной непроходимостью опухолевого составила 13,6%.

Заключение

Приведенные данные свидетельствуют, что в большинстве случаев при опухолевой толстокишечной непроходимости удаление опухолевого образования при первичной операции способствует улучшению результатов хирургического лечения обтурационной кишечной непроходимости опухолевого генеза у больных пожилого возраста, а также несомненно положительно отражается на продолжительности жизни данной категории больных.

Список литературы

1. Трапезников Н.Н., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ. М.: РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2001.
2. Ерюхин И.А., Петров В.П. Кишечная непроходимость. – СПб.: Питер, 1999.
3. Ханевич М.Д., Шашолин М.А. Колоректальный рак., Петрозаводск, 2003.
4. Ерюхин И.А., Зубарев П.Н. Декомпрессия тонкой кишки при острой непроходимости кишечника//Хирургия . 1998 №11, с. 15-19.

Биполярная трансуретральная резекция доброкачественной гиперплазии предстательной железы

Турысбеков К.Т.

Центральная клиническая больница УДПРК

Актуальность

В последние годы в связи со значительным ростом населения планеты в возрасте старше 60 лет увеличивается заболеваемость доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Наиболее эффективным в терапии ДГПЖ остается хирургическое лечение ДГПЖ. На сегодняшний день золотым стандартом в ее оперативном лечении является трансуретральная резекция, с помощью которой удается оперировать значительную часть больных. В тоже время по литературным данным при данном методе лечения у 20 % больных развиваются различные осложнения. В этой связи ведется поиск новых методов лечения больных ДГПЖ. Одним из таких методов является биполярная трансуретральная резекция простаты.

Цель исследования

– изучить особенности применения метода биполярной трансуретральной резекции ДГПЖ.

Материал и методы исследования

Материалом для ретроспективного анализа послужили 48 случаев биполярной ТУР ДГПЖ, проведенных в урологическом отделении ЦКБ УДПРК. Возраст больных варьировал от 62 до 81 года. Объем резецированной предстательной железы составлял от 38 до 160 куб. см.

Биполярная ТУР ДГПЖ проводилась на оборудовании KARL STORZ (ГЕРМАНИЯ).

Больные предъявляли жалобы на расстройство мочеиспускания, проявляющееся затруднением при мочеиспускании, увеличением ночных мочеиспусканий, чувством неполного опорожнения мочевого пузыря и вялой струей мочи. Всем больным проведено измерение суммарного балла по междуна-родной системе суммарной оценки симптомов при заболеваниях предста-тельной железы, по 35 бальной шкале; пальцевое ректальное исследование; общеклинические исследования, рентгенография почек и мочевого пузыря; абдоминальное и трансректальное УЗИ предстательной железы; урофло-уметрия с определением наличия и количества остаточной мочи; определе-ние уровня простатоспецифического антигена по показаниям.

Результаты

Послеоперационное пребывание в стационаре 6,5 к/дн, срок дренирования мочевого пузыря - 24 часа. Назначались уроантисептики, антибактериальные препараты и гемостатики. Интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений не наблюдалось.

Выводы

Преимуществами биполярной ТУР ДГПЖ являются более короткий период дренирования мочевого пузыря после операции; невозможность возникновения ТУР - синдрома; короткий период пребывания в стационаре после операции.

Цитомегаловирусная инфекция

Мамбетова С.Т.

г.Аытрау

Цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВ) можно эффективно лечить. Существуют три группы пациентов, для которых актуален контроль за активностью ЦМВ. Это беременные; лица, страдающие рецидивирующим герпесом; пациенты с нарушенным иммунным ответом.

1. Цитомегаловирус и беременность. Эта проблема беспокоит каждую четвертую женщину детородного возраста. Им необходимо:

- подготовка к беременности женщин, страдающих герпесом и ЦМВ-инфекцией;
- своевременные лечебно-профилактические мероприятия во время беременности и при подготовке к родам - это реальная возможность избежать негативного влияния цитомегаловируса на течение беременности, развития патологии плода и новорожденного.

2. Цитомегаловирус и генитальный герпес - одна из причин плохо поддающегося терапии рецидивирующего герпеса при любой локализации процесса; смешанная ЦМВ-ВПГ- инфекция, что требует значительной коррекции в проводимом противорецидивном лечении.

3 Цитомегаловирус и иммунитет:

- у лиц с нормальным иммунитетом (иммунокомпетентных) цитомегаловирус обычно находится в латентном (спящем) состоянии, не причиняя человеку вреда. При активации латентной инфекции могут возникать рецидивирующие бронхиты, пневмонии, воспаление периферических лимфатических узлов (лимфоаденопатия), астения: субфебрильная температура тела, ознобы, повышенная утомляемость, недомогание.

- у лиц с иммунодефицитом (ВИЧ-инфицированные, химиотерапия по поводу злокачественных новообразований, иммуносупрессивная терапия при трансплантации внутренних органов) цитомегаловирус вызывает тяжелые заболевания (поражение глаз, легких, пищеварительной системы и головного мозга), которые могут приводить к смерти.

Распространенность и пути заражения ЦМВ

Цитомегаловирус был открыт в 1956 г. Возбудитель (Cytomegalovirus hominis - ЦМВ) относится к семейству герпес вирусов (herpesviridae). Вирус имеет сродство к ткани слюнных желез и при локализованных формах обнаруживается только в этих железах. ЦМВ персистирует в организме (сохраняется) пожизненно. Он широко распространен в популяции. Антитела к цитомегаловирусу выявляют у 10-15% подростков. К возрасту 35 лет эти антитела выявляют уже у 40% людей.

ЦМВ не очень заразен. Для заражения обычно требуются длительное, тесное общение или многократные контакты.

Заражение цитомегаловирусом происходит:

- в быту: воздушно-капельным путем и контактным со слюной при поцелуях;
- половым путем: контактным - со спермой, слизью шейки матки;
- при переливании крови и трансплантации донорских органов;

- трансплацентарный путь - внутриутробное инфицирование плода;
- инфицирование ребенка в послеродовом периоде через грудное молоко больной матери.

Клинические проявления цитомегаловирусной инфекции

Длительность инкубационного периода составляет от 20 до 60 дней. Острая фаза болезни длится от 2 до 6 недель: повышение температуры тела и появление признаков общей интоксикации, ознобы, слабость, головная боль, боли в мышцах явления бронхита.

В ответ на первичное внедрение развивается иммунная перестройка организма. После острой фазы в течение многих недель сохраняется астенизация, иногда вегетативно-сосудистые расстройства. Множественное поражение внутренних органов.

Наиболее часто ЦМВ-инфекция проявляется как ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). В этом случае больные жалуются на слабость, общее недомогание, быструю утомляемость, головные боли, насморк, воспаление и увеличение слюнных желез, с обильным отделением слюны и белесоватыми налетами на деснах и языке.

Генерализованная форма ЦМВ-инфекции с поражением внутренних (паренхиматозных) органов. Наблюдается воспаление печеночной ткани, надпочечников, селезенки, поджелудочной железы, почек. Это сопровождается частыми «беспричинными» пневмониями, бронхитами, плохо поддающимися антибиотикотерапии; отмечается снижение иммунного статуса, уменьшается количество тромбоцитов в периферической крови. Нередки поражение сосудов глаза, стенок кишечника, головного мозга и периферических нервов. Увеличение околоушных и подчелюстных слюнных желез, воспаление суставов, кожная сыпь.

Поражение органов мочеполовой системы у мужчин и женщин проявляется симптомами хронического неспецифического воспаления. Если не установлена вирусная природа имеющейся патологии - заболевания плохо поддаются антибиотикотерапии.

Патология беременности, плода и новорожденного - наиболее серьезные осложнения ЦМВ-инфекции.

Максимальный риск развития этой патологии возникает при инфицировании плода во время беременности. Однако, необходимо помнить, что проблемы нередко возникают и у беременных с активацией латентной ЦМВ-инфекции с развитием вирусемии (выход вируса в кровь) с последующим заражением плода. ЦМВ - одна из наиболее частых причин невынашивания беременности. Внутриутробная ЦМВ-инфекция плода приводит к развитию тяжелых заболеваний и поражений центральной нервной системы (отставание в умственном развитии, тугоухость). В 20-30 % случаев ребенок погибает.

Диагностика герпесвирусных (ВПГ и ЦМВ) инфекций

- Диагноз ВПГ и ЦМВ-инфекции можно ставить (особенно при малосимптомной, атипичной и скрытой формах герпеса) только на основании выявления вируса в

биологических жидкостях организма (кровь, моча, слюна, отделяемое половых путей) методом ПЦ1 или при специальном посеве на культуру клеток;

- ПЦР отвечает на вопрос: вирус обнаружен или нет, но не дает ответа об активности вируса;

- посев на культуре клеток не только выявляет вирус, но и дает информацию о его активности (агрессивности). Анализ результатов посева на фоне лечения позволяет делать заключение об эффективности проводимой терапии;

- антитела IgM могут свидетельствовать или о первичной инфекции или об обострении хронической инфекции. Антитела IgG говорят только о том, что человек с вирусом

встречался, инфицирование произошло. IgG при герпес-вирусных инфекциях сохраняется пожизненно (в отличие, например, от хламидиоза). Есть инструкции, в которых IgG имеют диагностическое значение.

Лечение ЦМВ-инфекции должно быть комплексным, включать в себя иммунную и противовирусную терапию. ЦМВ довольно быстро уходит с периферии и перестает выделяться из биологических жидкостей (кровь, слюна, грудное молоко) - наступает латентная фаза инфекции. Качественно проведенная иммунотерапия активизирует защитные механизмы, которые контролирует в дальнейшем активацию латентной ЦМВ инфекции.